



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF  
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC  
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL – MPEA

Autora: Amanda Rezende Silva de Oliveira

ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NOS  
PROCESSOS GERENCIAIS DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA  
COM DEFICIÊNCIA EM LAGOA SANTA/MG

Niterói/RJ

Fevereiro de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL – MPEA

ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NOS PROCESSOS  
GERENCIAIS DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM  
LAGOA SANTA/MG

Trabalho apresentado ao  
Mestrado Profissional em  
Enfermagem Assistencial/MPEA,  
Universidade Federal Fluminense -  
UFF, como parte dos requisitos para a  
obtenção do título de Mestre.

Autora: Amanda Rezende Silva de Oliveira

Orientadora: Maithê de Carvalho e Lemos Goulart

Niterói/RJ

Fevereiro de 2025

## **DEDICATÓRIA**

A todas as pessoas com deficiência e suas famílias, que enfrentam, com coragem e resiliência, os desafios do cotidiano e depositam no Sistema Único de Saúde (SUS) a esperança de suas necessidades atendidas e seus direitos respeitados.

Este trabalho é para vocês. É a expressão do meu mais profundo respeito e apreço pela luta diária de cada um e pelo valor intrínseco de cada vida.

A maior recompensa que virá deste estudo é saber que, de alguma forma, ele poderá contribuir para que vidas sejam beneficiadas, sonhos sejam realizados e barreiras sejam superadas.

Com toda a minha dedicação,

## AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, cuja graça infinita e amor incondicional sustentaram minha caminhada. Em cada passo deste percurso, senti a presença luminosa, orientando-me e fortalecendo-me nos momentos de dúvida e superação.

À minha família, minha sustentação, meu lar de força e amor. Obrigada por acreditarem em mim, por cada gesto de carinho, apoio e compreensão. Vocês são a razão pela qual nunca me deixei desanimar, mesmo diante dos maiores desafios.

À minha orientadora, cujo saber, paciência e dedicação foram fundamentais para que este trabalho ganhasse forma. Suas palavras e orientações foram luz em minha trajetória acadêmica, permitindo que eu avançasse com confiança e propósito.

Aos meus colegas e amigos de trabalho que, com sua dedicação e compromisso, me inspiram diariamente. Vocês são a prova viva da nobreza e da importância do SUS, cuja essência é cuidar e promover a vida.

À Secretaria de Saúde de Lagoa Santa, que tão gentilmente acolheu e apoiou este projeto, estendo minha gratidão pelo compromisso com a saúde pública e pela confiança depositada em mim.

Ao COREN-MG e ao MPEA, por proporcionarem condições e estímulos para que esta caminhada fosse possível. Reconheço, com imenso carinho, o papel que desempenham na valorização da categoria da enfermagem e na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.

Aos integrantes da banca, agradeço profundamente pelas contribuições valiosas e pelo apoio oferecido, que enriqueceram este trabalho com sua visão crítica e construtiva. Suas orientações e sugestões foram essenciais para a finalização deste projeto, tornando-o mais robusto e alinhado com as necessidades da pesquisa e da prática profissional.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste sonho. Cada palavra de incentivo, cada sorriso compartilhado e cada gesto de apoio foram sementes de coragem plantadas em meu coração.

Que este trabalho seja uma pequena retribuição a tudo o que recebi ao longo desta jornada.

Com carinho e gratidão,

“Quanto ao mais, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai”.

Filipenses 4:8-13

## RESUMO

Oliveira, RS Amanda. Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa – Minas Gerais. Ano de defesa 2025. Dissertação Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, ano de defesa 2025.

**Introdução:** a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência se propõe a ampliar, qualificar e diversificar as estratégias para a atenção às pessoas com deficiência por meio de uma rede de serviços integrada, articulada e efetiva. **Objetivo:** elaborar e implementar um plano de melhorias nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais. **Método:** Estudo de implementação de melhoria através da avaliação de programas e políticas que seguiu as recomendações do *Consolidated Framework for Implementation Research*. Foi realizado entre julho de 2023 e janeiro de 2025, em 2 etapas: 1) Pré-implementação e 2) Implementação. Os participantes do estudo foram os *stakeholders*, composto por dois representantes de cada segmento: gestores; profissionais de nível superior integrantes da equipe multiprofissional; profissionais da Junta Reguladora; usuários, pessoas com deficiência, ou seu responsável. Etapa de pré-implementação: diagnóstico gerencial da rede, definição de indicadores, realização da primeira oficina com os *Stakeholders*, avaliação da prontidão organizacional para mudança e elaboração do plano de melhorias. Etapa de implementação: nova oficina com os *Stakeholders* para apresentação do plano de melhorias e a exposição dos resultados para à gestão, além da implementação das ações prioritárias. Os dados coletados foram analisados de forma descritiva e para os indicadores, foram tabulados em uma planilha do *software* Excel e analisados por meio de estatística no programa *Statistical Package for the Social Sciences*, versão 20.0. O estudo conta com a anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa e a aprovação do comitê de ética da Universidade Federal Fluminense pelo número do parecer 6.948.655/2024, CAAE: 79167224.1.0000.5243. **Resultado:** realizou-se o diagnóstico do cenário do estudo onde identificou-se que a taxa de acesso à Rede variou ao longo dos anos, considerando-se o período de 2020 a 2024, sendo a maior taxa de 64,5% em 2023 e a menor taxa de 11,6% em 2022. Posteriormente, realizou-se uma oficina com 10 *stakeholders* na qual estabeleceu-se as causas para a dificuldade de acesso à Rede: a falta de integração da rede, a estrutura física, o letramento do cuidador, a ausência de fluxos, de capacitações e de profissionais. Foi realizado novo mapeamento da Rede e elaborado um plano de melhorias. Implementadas as ações prioritárias como o novo fluxo da rede, um seminário para capacitação dos profissionais sobre a Rede e a campanha brincar sem telas. **Conclusão:** as melhorias implementadas possibilitaram melhor articulação da Rede e clareza nos processos de trabalho, facilitando o acesso dos usuários. Espera-se que novas melhorias sejam realizadas e que a Rede avance em direção a um cuidado mais acessível, humanizado, equitativo e de qualidade para todos os envolvidos. **Produtos:** adequados aos critérios CAPES, apresentando impacto local e regional, com articulação intersetorial e política. Diagnóstico situacional da Rede, alinhado ao impacto social e profissional; novo Fluxograma, inovação técnica e tecnológica; plano de melhorias, forte aplicabilidade do conhecimento, Protocolo publicado, produção técnica; Seminário, reflete e formação continuada e impacto na prática, Campanha brincar sem telas, transferência de conhecimento para a sociedade.

**Descritores:** Pessoas com Deficiência; Serviços de Saúde para Pessoas com Deficiência; Gestão em Saúde; Integralidade do Cuidado; Reabilitação.

## ABSTRACT

Oliveira, RS Amanda. Study to Implement Improvements in the Management Processes of the Care Network for People with Disabilities in Lagoa Santa, Minas Gerais. The Year of Defending 2025. Dissertation Professional master's degree in nursing care: Aurora de Afonso Costa Nursing School, Fluminense Federal University, Niterói, year of defense 2025.

**Introduction:** The Care Network for People with Disabilities aims to expand, qualify, and diversify strategies for caring for people with disabilities through an integrated, coordinated, and effective network of services. **Objective:** To design and implement an improvement plan for the management processes of the Care Network for People with Disabilities in Lagoa Santa, Minas Gerais. **Method:** Implementation study of improvement through evaluating programs and policies that followed the consolidated Framework for Implementation Research recommendations. It was carried out between July 2023 and January 2025 in 2 (1.31 m2) stages: 1) Pre-implementation and 2) Implementation. The participants in the study were the stakeholders, made up of two representatives from each segment: managers, senior professionals from the multi-professional team, professionals from the Regulatory Board, users, people with disabilities, or their guardians. **Pre-implementation stage:** management diagnosis of the network, definition of indicators, holding of the first workshop with stakeholders, assessment of organizational readiness for change, and preparation of the improvement plan. **Implementation stage:** a new workshop with stakeholders to present the improvement plan and present the results to management, as well as implementing priority actions. The data collected were analyzed descriptively, and the indicators were tabulated in an Excel spreadsheet and analyzed using statistics in the Statistical Package for the Social Sciences, version 20.0. The study has the consent of the Lagoa Santa Municipal Health Department and the approval of the ethics committee of the Federal Fluminense University under opinion number 6.948.655/2024, CAAE: 79167224.1.0000.5243. **Results:** A diagnosis of the study scenario was carried out, which identified that the rate of access to the network varied over the years, considering the period from 2020 to 2024, with the highest rate of 64.5% in 2023 and the lowest rate of 11.6% in 2022. Subsequently, a workshop was held with 10 stakeholders. The causes for the difficulty in accessing the network were established: the lack of network integration, the physical structure, the literacy of the caregiver, and the lack of flows, training, and professionals. A new network mapping was carried out, and an improvement plan was drawn up. Priority actions were implemented, such as the new network flow, a seminar to train professionals about the network, and the Play without screens campaign. Professionals about the Network and the Play without screens campaign. **Conclusion:** The improvements implemented have made it possible to better articulate the network and clarify work processes, facilitating access for users. It is hoped that further improvements will be made and that the network will move towards more accessible, humanized, equitable, and quality care for all those involved. **Products:** in line with CAPES criteria. Situational diagnosis of the network, aligned with social and professional impact; new flowchart; technical and technological innovation; improvement plan; strong applicability of knowledge, published Protocol, technical production; Seminar, reflection and continuing training and impact on practice, Play without Screens Campaign, transfer of knowledge to society.

**Descriptors:** Disable Persons; Health Services for Persons with Disabilities; Health Management; Comprehensive Care; Rehabilitation.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

|                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Rede de Atenção à Saúde de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                                                         | 28 |
| Figura 2. Modelo de Diagrama de Ishikawa utilizado no escritório com o grupo de Stakeholders, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                | 37 |
| Figura 3. Modelo de Matriz GUT utilizado na oficina com o grupo de Stakeholders, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                             | 38 |
| Figura 4. Registros identificados nos recursos informacionais (n=4152), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                      | 44 |
| Figura 5. Processo de triagem e exclusão dos registros identificados nos recursos informacionais (n=4076), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                   | 45 |
| Figura 6. Processo de seleção e inclusão dos registros para análise do escopo (n=27), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                        | 46 |
| Figura 7. Fluxograma de seleção dos registros (PRISMA-SCR), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                                  | 47 |
| Figura 8. Nuvem de palavras dos vocábulos mais recorrentes nos resultados dos registros analisados na revisão de escopo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....     | 61 |
| Figura 9. Análise de Similitude dos vocábulos mais recorrentes nos resultados dos registros analisados na revisão de escopo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024..... | 62 |
| Figura 10. Mapeamento Gerencial da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                  | 66 |
| Figura 11. Novo Mapeamento Gerencial da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                             | 70 |
| Figura 12. Serviços que compõem a RCPD, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                                                      | 71 |
| Figura 13. Mapa das Regiões de Saúde da grande Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                                            | 74 |

|                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 14. Apresentação do Fluxograma atual da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa e ferramentas de gestão a serem utilizadas na Oficina com os Stakeholders, Minas Gerais, Brasil, 2024..... | 79 |
| Figura 15. Stakeholders trabalhando em grupo na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                                                                                          | 80 |
| Figura 16. Diagramas de Ishikawa modificados pelos grupos de Stakeholders na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                                                             | 81 |
| Figura 17. Diagrama de Ishikawa elaborado pelos Stakeholders na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                                                                          | 81 |
| Figura 18: QRcode para acessar o formulário POM, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                                                                                                  | 84 |
| Figura 19. Apresentação do Plano de Melhorias da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa na Oficina com os Stakeholders, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                          | 95 |
| Figura 20. Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                                                                 | 96 |
| Figura 21. Profissionais de saúde e gestores presentes no I Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                | 97 |
| Figura 22. Identidade visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                                                                         | 98 |

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Indicadores de taxas de acesso à RCPD e número de casos não atendidos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2024..... 77

Tabela 2. Indicador do tempo de espera para o primeiro atendimento/acolhimento dos indivíduos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2024..... 77

## LISTA DE QUADROS

|                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quadro 1. Critérios de inclusão, exclusão e substituição dos <i>stakeholders</i> , Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                        | 31 |
| Quadro 2. Indicadores estabelecidos e a respectiva forma de mensuração, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                                   | 35 |
| Quadro 3. Descrição dos passos, responsáveis e ações no fluxograma da RCPD, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                                               | 48 |
| Quadro 4. Síntese recomendações das melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025..... | 64 |
| Quadro 5. Descrição dos passos, responsáveis e ações no fluxograma da RCPD, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.....                                               | 72 |
| Quadro 6. Ações condicionadas como prioritárias pelos stakeholders para a melhoria da RCPD do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                | 83 |
| Quadro 7. Distribuição das respostas no instrumento Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança (n=59), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....            | 86 |
| Quadro 8. Pontuação da Prontidão Organizacional para mudança por dimensão do instrumento POM, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.....                             | 93 |

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AB – Atenção Básica

AE – Atenção Especializada

APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

APS – Atenção Primária à Saúde

CAIS – Centro de Atenção Integrada à Saúde

CAPSIJ – Centro de Atenção Psicossocial Infante Juvenil

CFIR – *Consolidated Framework for Implementation Research*

CIHR – *Canadian Institutes of Health Research*

CREAB – Centro de Reabilitação

ESF – Equipes de Saúde da Família

GUT – Gravidade, Urgência e Tendência

IRAMUTEQ – *Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires*

JRRCD – Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

MPEA – Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial

MS – Ministério da Saúde

OBJN – *Online Brazilian Journal of Nurse*

ORC – *Organizational Functioning and Readiness for Change*

OSF – *Open Science Framework*

PDR – Plano Diretor de Regionalização

PIPA – Programa de Intervenção Precoce Avançado

POM – Prontidão Organizacional para Mudanças

RAPS – Rede de Atenção Psicossocial

RAS – Redes de Atenção à Saúde

RCPD – Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

RUE – Rede de Atenção às Urgências e Emergências

SERDI – Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual

SISREG – Sistema de Regulação do Ministério da Saúde

SUS – Sistema Único de Saúde

TC – Tradução de Conhecimento

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFF – Universidade Federal Fluminense

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

UCT – Universidade Cristã do Texas

## SUMÁRIO

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                                                | <b>16</b> |
| 1.1 Objetivo Geral                                                  | 21        |
| 1.1.2. Objetivos Específicos                                        | 21        |
| 1.2 Justificativa e Relevância                                      | 21        |
| <b>2. BASES CONCEITUAIS</b>                                         | <b>23</b> |
| 2.1 Estrutura do Sistema Único de Saúde                             | 23        |
| 2.2. Pessoa com Deficiência                                         | 25        |
| 2.3. Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência no Brasil             | 26        |
| 2.4. Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência em Minas Gerais       | 27        |
| 2.5. A Tradução do Conhecimento para Melhoria dos Processos da RCPD | 28        |
| <b>3. MÉTODO</b>                                                    | <b>29</b> |
| 3.1. Tipo de Estudo                                                 | 29        |
| 3.2. Cenário do Estudo                                              | 29        |
| 3.3. Participantes ou Stakeholders                                  | 30        |
| 3.4. Procedimentos para Coleta de Dados                             | 33        |
| 3.4.1. Etapa Pré-Implementação                                      | 33        |
| 3.4.2. Etapa Implementação                                          | 40        |
| 3.5. Análise dos Dados                                              | 41        |
| 3.6. Aspectos Éticos                                                | 41        |
| 3.7. Riscos                                                         | 42        |
| 3.8. Benefícios                                                     | 43        |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>4. RESULTADOS</b>                                               | 44  |
| 4.1 Pré-Implementação                                              | 44  |
| 4.1.1 Revisão de Escopo                                            | 44  |
| 4.1.2 Mapeamento gerencial da RCPD                                 | 65  |
| 4.1.3 Indicadores da RCPD                                          | 76  |
| 4.1.4 Oficina com <i>Stakeholders</i>                              | 78  |
| 4.1.5 Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança           | 84  |
| 4.1.6 Plano de Melhorias                                           | 93  |
| 4.1.7 Segunda oficina com os <i>Stakeholders</i>                   | 94  |
| 4.1.8 Melhorias Implementadas na RCPD de Lagoa Santa, Minas Gerais | 96  |
| <b>5. DISCUSSÃO</b>                                                | 99  |
| <b>6. CONCLUSÃO</b>                                                | 106 |
| <b>7. PRODUTO</b>                                                  | 108 |
| <b>8. REFERÊNCIAS</b>                                              | 109 |
| <b>9. APÊNDICES E ANEXOS</b>                                       | 116 |
| 9.1 APÊNDICE A                                                     | 116 |
| 9.2 APÊNDICE B                                                     | 120 |
| 9.3 APÊNDICE C                                                     | 124 |
| 9.4 APÊNDICE D                                                     | 128 |
| 9.5 APÊNDICE E                                                     | 137 |
| 9.6 APÊNDICE F                                                     | 164 |

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 9.7  | APÊNDICE G | 175 |
| 9.8  | APÊNDICE H | 179 |
| 9.9  | ANEXO 1    | 184 |
| 9.10 | ANEXO 2    | 189 |
| 9.11 | ANEXO 3    | 190 |
| 9.12 | ANEXO 4    | 191 |
| 9.13 | ANEXO 5    | 192 |
| 9.14 | ANEXO 6    | 193 |

## 1. INTRODUÇÃO

A saúde é um direito universal e fundamental do indivíduo, família e coletividade, amparado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela constituição de 1988. A Lei nº 8.080, de 1990, delibera sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a disposição e a operacionalização do então instituído Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é um sistema regido pelo poder público, regionalizado, organizado hierarquicamente, que oferece ações e serviços de saúde em todo território nacional<sup>(1-2)</sup>.

Buscando garantir a integralidade do cuidado, as Redes de Atenção à saúde (RAS) surgem como arranjos organizativos de diferentes densidades tecnológicas, ações e serviços de saúde que, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, devem oferecer acesso à assistência qualificada<sup>(3)</sup>. A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, estabeleceu os níveis de atenção e assistência à saúde no Brasil, e determinou as linhas para a organização das RAS no âmbito do SUS, cujos níveis de atenção são: atenção primária, atenção secundária e atenção terciária<sup>(3)</sup>.

A atenção primária à saúde (APS) é a porta preferencial de entrada do usuário no SUS, considerada a ordenadora da rede e o ponto de atenção que coordena ou gere o cuidado de saúde, devido sua posição de centralidade na constituição das redes de cuidado<sup>(4)</sup>. A APS detém a capacidade de resolver de 80% a 90% das demandas da população ou, se necessário, encaminhá-los para assistência na rede de atenção especializada (níveis secundário e terciário)<sup>(3)</sup>. Os serviços que integram a APS realizam ações voltadas para promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde<sup>(5)</sup>. Os profissionais neste nível não ficam restritos aos estabelecimentos de saúde, articulam-se e atuam nos espaços públicos da comunidade e em visitas domiciliares as famílias<sup>(5)</sup>.

A atenção especializada é constituída por dois elementos: atenção secundária (média complexidade) e atenção terciária (alta complexidade)<sup>(3)</sup>. A média complexidade é composta por serviços especializados encontrados em policlínicas, ambulatorios, que oferecem atendimento direcionado para especialidades médicas e multiprofissionais, centros de atendimento com equipamentos para exames mais avançados, unidade de pronto atendimento (UPA) e hospitais<sup>(3)</sup>.

O nível secundário garante a continuidade do tratamento com internação e intervenção médico-hospitalar mais complexa aos casos não resolvidos ou estabilizados na média

complexidade. Através da regulação de acesso assistencial, os casos singulares ou complexos são encaminhados para serviços de alta complexidade (atenção terciária), como hospitais gerais de grande porte, hospitais universitários, Santas Casas e unidades de ensino e pesquisa. Estes serviços oferecem leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centros cirúrgicos e procedimentos que demandam de alta densidade tecnológica<sup>(3)</sup>.

Por intermédio deste ciclo completo de atendimentos, as RAS são operacionalizadas para resolver as mais diversas e específicas condições de saúde e garantir a continuidade e integralidade da atenção nos seus diferentes níveis. Trata-se da melhor estratégia para superar os desafios e integrar os sistemas de saúde<sup>(6)</sup>. Assim, as redes temáticas de atenção à saúde existentes hoje no SUS, são: Rede de Atenção à Saúde Materna e infantil – Rede Cegonha (repristinada - PRT GM/MS nº 13/ 2023, Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), Rede de Atenção à saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD)<sup>(3)</sup>.

Dentre as diversas redes, o objeto deste estudo concentra-se na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), instituída a partir da publicação das Portarias MS/GM nº 793/2012 e 835/2012 (atualmente substituídas, respectivamente, pelas Portarias MS de Consolidação nº 3/2017 e 6/2017). A RCPD se propõe a aumentar a oferta e a qualidade dos cuidados prestados às pessoas com deficiência por meio de diferentes estratégias para o alcance de uma rede de serviços efetiva, integrada e articulada<sup>(3)</sup>. No entanto, apesar da importância da articulação entre os componentes de atenção à saúde, a RCPD enfrenta desafios relacionados à fragmentação dos serviços, comprometendo a continuidade do cuidado<sup>(7)</sup>.

Para o estabelecimento de uma RCPD efetiva é necessário garantir a articulação entre os componentes de atenção à saúde atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar e urgência e emergência<sup>(5,8)</sup>.

Além dessa articulação, é necessário estabelecer e regular os fluxos assistenciais, desenvolver estratégias que viabilizem a educação permanente entre os pontos de atenção, construir mecanismos que apresentem informações epidemiológicas da sua região de abrangência e, fomentar práticas inclusivas para a pessoa com deficiência<sup>(9,8)</sup>.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (2007) enfatiza que a deficiência resulta da interação entre barreiras sociais e as limitações individuais. Na prática, a ausência de integração entre os serviços de saúde dificulta a garantia de acesso a

um cuidado adequado, gerando os vazios assistenciais que vitimam as pessoas com deficiência. Além das ausências por questões territoriais, as dificuldades também são criadas pela especificidade de cada serviço. A ausência ou desarticulação dos serviços de saúde compromete o bem-estar físico e emocional dos pacientes e seus familiares. A falta de oferta adequada dos serviços de saúde impõe as famílias preocupações e desafios constantes, além de importante pressão financeira.

Dessa forma, percebe-se que o sistema não foi construído visando as necessidades da população PcD e que, possivelmente, estes não tiveram voz no momento do planejamento e implantação da política. Vale ressaltar que a ausência de participação de todos os atores nos espaços de decisão impede que suas potencialidades e fragilidades sejam discutidas e alinhadas sob as diversas óticas de uma rede de atenção à saúde<sup>(10)</sup>. Pesquisas sobre a temática, em diversas regiões do Brasil, apresentam, em seus desfechos, similaridades ao afirmarem que as RCPDs não conseguem oferecer o preconizado nas normativas<sup>(11,10)</sup>.

Através da Deliberação CIB-SUS-MG nº 1272/2012, o Estado de Minas Gerais instituiu sua RCPD, considerando as normas e legislações pertinentes e estruturou sua Rede de Atenção. Encontra-se desde então em processo de discussões e implementações de procedimentos para expansão e qualificação da Rede<sup>(12)</sup>. A RCPD-MG oferece atendimento em reabilitação às pessoas com deficiência física, ostomia, intelectual, auditiva, visual e em múltiplas deficiências. Os serviços que integram a Rede contam com diferentes densidades tecnológicas e níveis de atenção à saúde<sup>(12)</sup>.

Para direcionar a descentralização e estruturar os serviços de saúde da RCPD-MG foi utilizado como norteador o Plano Diretor de Regionalização (PDR). Considerando o referido instrumento, verifica-se que o Estado de Minas Gerais é constituído por quatorze Macrorregiões de Saúde e oitenta e nove Microrregiões. O Município de Lagoa Santa integra a microrregião de Vespasiano/MG, pertencente à macrorregião Centro, tendo como município polo a capital do Estado Belo Horizonte<sup>(13)</sup>.

Em Lagoa Santa a RCPD é regida pelo decreto Municipal nº 4.879 de 13 de abril de 2023, uma nova política que estabelece o Protocolo de Atenção Integral à Pessoa com Transtorno do Neurodesenvolvimento e/ou Deficiência Física no Município. O protocolo prevê organizar o acesso e seguimento da assistência dentro da RCPD de Lagoa Santa em consonância com políticas públicas existentes<sup>(14)</sup>.

A atenção às pessoas com transtornos ou deficiência física deve ser realizada pelas Equipes de Saúde da Família (ESF), Clínica Ampliada Multiprofissional, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPSIJ), Centro de Reabilitação (CREAB) e Centro de Atenção Integrado à Saúde (CAIS), contando também com os demais serviços da rede municipal. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), hoje, integra a rede como responsável pelo Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI), e pelo Programa de Intervenção do Precoce Avançado (PIPA). Estes pontos de atenção integrarão o cenário do estudo, uma vez que, compõem a RCPD/LS<sup>(14)</sup>.

A deficiência é, prioritariamente, compreendida pela sociedade como um problema do corpo, não permitindo que o indivíduo seja considerado normal. Tal concepção gera ações de caridade, mediadas por valores e crenças médicas e religiosas<sup>(10)</sup>. Na sociedade capitalista, as pessoas com deficiência são comumente consideradas como descartáveis e inúteis, uma vez que não são produtivas. No Brasil, esse julgamento ainda é presente e imputa um lugar marginal à sociedade para estes indivíduos<sup>(11)</sup>.

As pessoas com deficiência são marginalizadas e invisibilizadas, enfrentam dificuldades no âmbito financeiro, social e dentro da própria RCPD no Brasil. A persistente desarticulação da RCPD impossibilita o acesso da pessoa com deficiência à assistência integral, interdisciplinar e intersetorial comprometendo sua reabilitação e inclusão social<sup>(11,10)</sup>. Estabelecendo sofrimento aos pacientes e seus familiares, observa-se, na luta constante de cada família, ambiguidade de sentimentos entre fragilidade e força. A fragilidade se apresenta no choro, na falta de crença em promessas de mudanças, no sentimento de revolta contra um sistema falho e negligente em atender suas demandas, também no seu adoecimento físico e emocional. A persistência, antagônica, na busca por acesso a saúde de qualidade comprova a força, apesar da difícil realidade.

A sapiência sobre tal perspectiva tornou-se a genitura para o desenvolvimento dessa pesquisa, pois configura-se como medida urgente à necessidade de intervenções que permitam a implementação eficiente das políticas públicas pertinentes. Dessa forma, busca-se resolver o caos humano provocado pelo vazio assistencial e mitigar o sofrimento dos pacientes e de suas famílias.

Diante do exposto, o sofrimento das famílias, somado ao desejo de oferecer dignidade e respeito às suas necessidades, foi a primeira motivação para o desenvolvimento do estudo, além de fazer avançar o conhecimento sobre práticas eficientes para a

implementação de políticas. Compreender o contexto e os processos gerenciais de determinada RCPD apresenta-se como uma ação necessária para o alcance de uma rede de serviços integrada, articulada e efetiva e, por consequência, para a inclusão social e a assistência adequada às PcDs e sua família.

Assim, este trabalho busca alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, adaptando suas metas às especificidades e necessidades da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais. São integrados e articulados, nesse estudo, os ODS 3 sobre Saúde e bem-estar identificando gargalos que afetam a oferta de cuidados e o acesso à saúde para pessoas com deficiência; o ODS 4 relativo a Educação de qualidade, por meio da promoção da qualificação do conhecimento sobre a gestão da rede, que poderá subsidiar melhorias no acesso à educação inclusiva; o ODS 8 referente ao Trabalho decente e crescimento econômico, com a valorização do trabalho dos profissionais, gerando impacto positivo nos serviços; o ODS 10 sobre Redução das desigualdades, através da implementação de ações que possam melhorar a equidade e a inclusão social de pessoas com deficiência; o ODS 16 relativo à Paz, justiça e instituições eficazes, contribuindo para a transparência e eficiência nos processos administrativos e gerenciais garantindo assim a justiça em saúde para as pessoas com deficiência à margem da RCPD e; o ODS 17: Parcerias e meios de implementação, enfatizando a importância do monitoramento por meio de dados confiáveis, permitindo o planejamento eficaz.

A pesquisa se propõe a trazer melhorias gerenciais à RCPD, fundamentadas em evidências, com foco na eficiência, acessibilidade e qualidade dos serviços oferecidos, considerando as diretrizes dos ODS, como a redução das desigualdades, a promoção da saúde e bem-estar, a educação de qualidade, e inovação. Ao interligar essas metas globais com estratégias locais, a pesquisa contribui para o avanço de políticas públicas inclusivas e sustentáveis, oferecendo respostas às demandas identificadas e fortalecendo os processos gerenciais em um contexto de equidade e inovação.

Delimitou-se assim a seguinte questão norteadora: Quais estratégias e intervenções podem ser desenvolvidas para aprimorar os processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do município de Lagoa Santa/MG, de forma a possibilitar aos usuários maior eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento?

## **1.1 Objetivo Geral**

Elaborar e implementar um plano de melhorias para os processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais.

### **1.1.2 Objetivos Específicos**

- Identificar na literatura as práticas relacionadas a gestão da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.
- Mapear os processos gerenciais da rede de cuidados à pessoa com deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais.
- Mensurar os indicadores relacionados à rede de cuidados à pessoa com deficiência.
- Elaborar e implementar um plano de ação de melhorias dos processos gerenciais da rede de cuidados à pessoa com deficiência.

## **1.2 Justificativa e Relevância**

Esse estudo justifica-se pela vinculação profissional da pesquisadora principal, pós-graduanda do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), cuja função é a de responsabilidade técnica da Política da Pessoa com Deficiência e da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do município de Lagoa Santa no Estado de Minas Gerais, no qual é servidora efetiva da Secretaria de Saúde. O contexto da RCPD no referido município aponta para a necessidade de fortalecer e estabelecer uma rede de qualidade no município.

Desta forma a justificativa emerge da experiência prática da autora, adquirida ao atuar como referência da Política e da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Nesse contexto, a autora teve contato direto com famílias atípicas, convivendo com suas histórias marcadas por sofrimento, solidão e desconfiança em um sistema que, historicamente, negligenciou seus direitos e o acesso a serviços intersetoriais. A percepção desse cenário de vulnerabilidade, agravada pela fragmentação da rede de atenção, despertou a inquietação sobre a urgência de intervenções eficazes e estruturadas. Essa vivência prática motivou a autora a buscar na ciência estratégias inovadoras e embasadas para aprimorar os processos gerenciais da rede de cuidados, promovendo maior eficiência, acessibilidade e qualidade no atendimento às pessoas.

Vale ressaltar a obrigação do Estado, Gestores e Profissionais de saúde em oferecer uma assistência universal, integral e equânime para a pessoa com deficiência. Assim o presente estudo trará contribuições para o acesso da pessoa com deficiência nos pontos de atenção da rede, qualidade na assistência prestada, apoio gerencial e integração entre os serviços.

A contribuição e os impactos dessa pesquisa podem ser expressos ao apresentar alguns pontos a serem abarcados com a implementação de melhorias que será sugerida, tais como:

- Compreender as necessidades específicas das pessoas com deficiência;
- Orientar o desenvolvimento de serviços adequados;
- Permitir avaliação dos serviços existentes;
- Identificar lacunas na rede de cuidados o que permitirá melhorar a eficiência e eficácia dos serviços oferecidos, contribuindo para aprimorar a assistência;
- Buscar as melhores práticas adotadas para implementação de políticas públicas voltadas para a inclusão e bem-estar das pessoas com deficiência;
- Contribuir para assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso pleno aos seus direitos, incluindo o acesso à saúde e participação na sociedade;
- Identificar e abordar desigualdades no acesso a serviços, promovendo uma distribuição mais equitativa de recursos e cuidados;
- A pesquisa pode sensibilizar a sociedade e os formuladores de políticas para a importância da inclusão e cuidado adequado às pessoas com deficiência.
- O estudo trará luz para a Ciência da Implementação e Translação do Conhecimento, sua importância, para a prática profissional e para os usuários.

Ademais o plano de melhorias para a RCPD de Lagoa Santa poderá contribuir para o desenvolvimento e aprofundamento dos conhecimentos referentes ao tema, no que tange principalmente aos profissionais de saúde que atuam na rede. Pressupondo que conhecer contribui para que os indivíduos se tornem mais engajados nas propostas. Entender os processos estimula avaliações críticas quanto a própria atuação e aumenta a percepção dos nós críticos dentro da Rede.

O alcance do mestrado e das pesquisas científicas para formulação de políticas que garantam eficácia e efetividade, no planejamento estratégico das ações e a avaliação em saúde é amplo e de inegável valor. Os benefícios de tais conhecimentos e aplicações para

pesquisa o conhecimento adquirido no formato de melhorias para a RCPD, e aproximar a academia da prática profissional.

## **2. BASES CONCEITUAIS**

### **2.1 Estrutura do Sistema Único de Saúde**

Após grande mobilização social, a reforma sanitária, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi implantado pela constituição federal de 1988, e regulamentado dois anos após pela Lei nº 8080 de 19 de setembro de 1990. Em 2024, com 34 anos de idade, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo. Oferece assistência do nascimento aos últimos anos de vida, da escuta qualificada a transplantes dos mais variados e complexos.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) passou por diversas transformações ao longo dos anos desde a sua criação e regulamentação. Vale ressaltar que antes de iniciarmos a discussão sobre a proposição e implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), precisamos contextualizar esse processo para melhor compreendermos a proposta das RAS<sup>(15)</sup>.

Este complexo sistema de saúde transformou a realidade de acesso e direito à saúde pública da população brasileira, uma vez que, só detinham esse direito profissionais de carteira assinada. Os demais brasileiros eram considerados não cidadãos tendo suas necessidades de saúde supridas por caridade em instituições filantrópicas como as Santas Casas de Misericórdia<sup>(16)</sup>.

Ao analisarmos os documentos que fomentaram a estruturação inicial do SUS, constituídos pelo Relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde, a Constituição de 1988 e a Lei Orgânica da Saúde<sup>(2)</sup>, percebemos que em parte são convergentes em relação à organização do sistema de saúde. Tais documentos apresentam um sistema que propõe a atenção baseada nas necessidades de saúde da população por meio de um sistema hierarquizado da atenção, segundo níveis de complexidade: Atenção Básica (AB), Média e Alta Complexidade<sup>(16)</sup>.

A organização do sistema hierarquizado se configurava de forma que a base da pirâmide correspondia à AB, que funcionava como a “porta de entrada” para o sistema de saúde e deveria resolver a maior parte das demandas de saúde da população. A AB também se configurava como o local de acesso para o nível intermediário, que correspondia aos serviços caracterizados como atenção secundária ou média complexidade e incluía os

serviços ambulatoriais especializados e alguns serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. O topo da pirâmide correspondia aos serviços hospitalares de maior densidade tecnológica no que diz respeito às tecnologias materiais duras do cuidado<sup>(15)</sup>.

Para continuarmos esse debate, é importante situar a diferença entre a ideia de tecnologias do cuidado em saúde e a ideia de densidade tecnológica que norteia o sistema hierarquizado de organização do SUS. As tecnologias do cuidado classificam-se em leves, leve-duras e duras. As leves são as tecnologias que se caracterizam como as relacionais (produção de vínculo e das relações, acolhimento, gestão de processos de trabalho); as leve-duras consistem nos saberes bem estruturados (como a clínica médica, epidemiologia, fisiologia); e as duras são relacionadas aos equipamentos tecnológicos, máquinas, normas, estruturas organizacionais<sup>(17)</sup>.

No hierarquizado de organização do SUS predomina uma visão definida por “níveis de complexidade” crescentes, com relações de ordem e graus de importância entre eles. Tanto no senso comum quanto na literatura, observamos correlação dos níveis de complexidade com utilização de aparatos e equipamentos de diferentes densidades tecnológicas e do perfil dos profissionais que atuam nesses espaços. Nessa concepção, quanto maior é a exigência de profissionais especialistas e a utilização de equipamentos materiais (as tecnologias duras) de maiores densidades tecnológicas, maior seria a complexidade dos serviços e dos níveis de atenção<sup>(18)</sup>.

Tal relação não diz respeito à realidade dos serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção. Fundamenta-se num conceito equivocado, ao estabelecer que a AB seria menos complexa do que a atenção nos níveis secundário e terciário e, nessa perspectiva, menos importante. Esse entendimento inadequado contribui para a banalização da AB e a sobrevalorização das práticas que exigem maior densidade tecnológica e profissionais especialistas<sup>(18)</sup>.

Os serviços da atenção secundária e terciária caracterizam-se pela atuação de especialistas, os quais utilizam equipamentos de altas densidades tecnológicas para o cuidado em saúde. Nesses cenários, a autonomia das pessoas diminui em relação à adoção ou não de determinados projetos terapêuticos estabelecidos para o manejo das suas condições de saúde, além de os ambientes serem mais controlados pelos trabalhadores da saúde e sofrerem pouca ou nenhuma interferência de quem recebe o cuidado. Tais características tornam os cuidados na Atenção Especializada (AE) e hospitalar menos

complexos em relação ao cuidado na AB, mesmo que façam uso de maiores densidades tecnológicas e atuação de profissionais especialistas<sup>(18)</sup>.

## **2.2 Pessoa com Deficiência**

Viver com deficiência pode ser avaliado como item de exclusão social e ausência seja familiar ou governamental. Sucedem-se termos como ‘pessoas com deficiência’, ‘deficientes’, ‘pessoas especiais’, ‘pessoas com necessidades especiais’, ‘incapazes’, ‘defeituosos’, eles ao longo do tempo se tornam algo normal para esse<sup>(19)</sup>. Tal vocabulário é a representação da linguagem humana, todavia, ele é capaz de influenciar o pensamento e a qualificação profissional daqueles que estão no processo de controle social. Através de tais linguagens pode-se desenvolver problemáticas diárias<sup>(10)</sup>.

Solomon, ao discutir a complexidade do convívio, da criação e dos cuidados de saúde entre pais e filhos que nasceram ou desenvolveram algum tipo de diferença (surdez, nanismo, múltiplas deficiências, entre outras), reforça na fala de seus entrevistados a relação entre as palavras utilizadas para descrevê-los e suas experiências. Afinal, as concepções por trás das palavras espelham sociedades que garantem ou não o status de cidadão. Concepções orientam modelos teóricos de interpretação do fenômeno, no caso, a incapacidade/deficiência<sup>(19)</sup>.

Essas análises mostram que o Brasil necessita da criação de políticas públicas voltadas para população com deficiência, que muitas vezes são esquecidas pelo poder público, obtendo como consequência taxas abusivas de incapacidade que diminuem a qualidade e expectativa de vida. Nos países desenvolvidos percebe-se ações prioritárias como adaptação da infraestrutura e políticas voltadas a atenção desse público, todavia o acompanhamento em si desses pacientes, por não possuir um sistema de saúde gratuito, acaba dificultando a qualidade de vida dos mesmos que ficam muito tempo sem assistência e acompanhamento médico<sup>(10)</sup>.

Considerando, segundo a Lei nº 13.146/2015, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo podendo ser físico, mental, intelectual ou sensorial, o qual, enfrenta limitações que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as outras pessoas.

### **2.3 Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência no Brasil**

A universalidade, direito doutrinário do Sistema Único de Saúde (SUS), possibilitou a incorporação das necessidades das Pessoas com Deficiência (PcD) às políticas públicas de saúde, todavia, observa-se que as ações para esse público não englobam todos os princípios doutrinários na prática (integralidade, equidade e universalidade) e assim, fica evidente uma deficiência na assistência<sup>(20)</sup>.

Logo, estabelecer políticas públicas firmes que busquem atender a necessidade de determinado público, atendendo os princípios doutrinários, todos os níveis de complexidade do SUS, boa comunicação entre os estabelecimentos, acaba favorecendo um melhor desenvolvimento da assistência do público específico que necessita de maior atenção<sup>(21)</sup>.

De acordo com a CF/88, o estado brasileiro tem dever diante da saúde da população, porém sua incapacidade no gerenciamento de tal atenção, fez com que a população civil tomasse para si tal função. Sendo assim, realizam ações filantrópicas, buscam associações e melhoria do cuidado. Com o passar do tempo, observou-se que tais funções passam a melhorar a área assistencialista e diminuir problemas técnicos e financeiros<sup>(22)</sup>.

Diante dessas ações da sociedade, o país acabou não adquirindo um sistema de regulação minimamente adequado, sendo um fardo perdurado até os dias atuais, na qual não se possui sistema de referência e contra-referência impedindo estabelecimento de parâmetros epidemiológicos e técnico-científicos que orientem os profissionais de saúde diante do que seria mais necessário para o cuidado da população em si<sup>(20)</sup>.

Porém, o movimento da pessoa com deficiência vem crescendo bastante nos últimos anos (ex: Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Nova York) e, no Brasil, o Ministério da Saúde passa a incrementar políticas de saúde voltadas para eles, tendo como principal programa o Viver sem Limite: Plano de direitos da pessoa com deficiência voltado para Atenção à Saúde; Acesso à Educação; Inclusão Social; e Acessibilidade<sup>(20)</sup>.

O Ministério da Saúde é um dos atores centrais do Plano Viver Sem Limite, e além de colocar as políticas de saúde a pessoa com deficiência na pauta fixa do SUS e de manuais que orientem esses profissionais a guiarem e atender de maneira correta esse público<sup>(22)</sup>.

### **2.4 Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência no Estado de Minas Gerais**

No estado de Minas Gerais, a implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com

Deficiência foi pactuada por meio das Deliberações CIB-SUS-MG nº 1272/2012 e Deliberações CIB-SUS-MG nº 1545/2013, com prerrogativas para garantia da integralidade do cuidado em saúde e descentralização de serviços em todas as regiões de saúde, conforme o Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Minas Gerais, que estabeleceu 13 Regiões Ampliadas de Saúde e 77 Regiões de Saúde, contemplando os 853 municípios do Estado<sup>(13)</sup>.

A busca pela integração é resultado das reformas das políticas públicas fundamentadas na Atenção Primária à Saúde (APS). Isso mostra que é necessário melhorar a integração dos serviços de saúde assistenciais através da criação de estratégias que melhorem integração, coordenação de cuidado, integralidade e descentralização sendo utilizado planos de cuidado como as Linhas do Cuidado e as Redes de Atenção à Saúde (RAS)<sup>(23)</sup>.

RCPD de MG possuía um total de 209 serviços de reabilitação, distribuídos em 147 municípios, organizados em 59 Regiões de Saúde das 13 Regiões Ampliadas de Saúde, compondo a rede de atenção especializada em reabilitação da RCPD-MG, conforme dados informados pela SES-MG. Apresenta-se como uma rede bem consolidada, todavia fazendo-se necessário uma avaliação do grau de implantação e integração da RCPD<sup>(24)</sup>.

No Município de Lagoa Santa, a Rede de Atenção à Saúde oferece serviços e programas no âmbito municipal, no SUS. Considera a divisão do município em quatro regiões: Leste, Oeste, Norte e Sul. Cada região conta com a sua Policlínica Regional de referência, a saúde da cidade está caracterizada por ampla cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) com 24 unidades e cada bairro possui uma unidade Cuidar, nome dado para APS/ESF em Lagoa Santa. (Figura 1).



**Figura 1.** Rede de Atenção à Saúde de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

## 2.5 A tradução do conhecimento e a ciência da implementação para melhoria dos processos da RCPD

Uma vez que existem Resoluções e Manuais do MS no Brasil, faz-se necessário buscar a Tradução do Conhecimento (TC) como introdução de saberes que geram benefícios e inovação, buscando o fortalecimento aos sistemas de saúde e trazendo melhoria para a saúde da população. O *Canadian Institutes of Health Research* (CIHR), criado em 2000, define a TC como um processo dinâmico e interativo, que inclui a síntese, a disseminação, o intercâmbio e a aplicação ética do conhecimento para melhorar a saúde, por meio de serviços e produtos mais efetivos, fortalecendo os sistemas de saúde<sup>(25)</sup>.

A OMS adotou a tal definição para aplicar o conhecimento, acelerar os benefícios da inovação global dos sistemas de saúde, e a melhoria na saúde das pessoas<sup>(26)</sup>. Nessa perspectiva, a TC abrange todas as fases entre a criação de novos conhecimentos e sua aplicação para produzir resultados benéficos para a sociedade. Sendo assim, isso ajuda na divulgação, comunicação, ética e informação entre pesquisadores que necessitam de conhecimento para desenvolvimento de diretrizes<sup>(26)</sup>.

Além da síntese e da aplicação ética do conhecimento, por meio de um sistema complexo de interação entre pesquisadores e profissionais de saúde, a translação do conhecimento necessita de uma comunicação efetiva sobre resultados de pesquisa, bem como a revisão, a identificação e a aplicação prática de estudos pelos *stakeholders* (pessoas

ou instituições interessadas), que têm um papel importante na gestão dos resultados de pesquisa<sup>(26)</sup>.

O objetivo da TC é deixar disponível conhecimento para planejamento de ações, determinação de serviços e tratamento, além de colaborar na orientação dos profissionais na tomada de decisão no atendimento. Todavia, a TC ainda não está sendo desenvolvida, sendo utilizado o argumento que seus objetivos não são totalmente explícitos e assim, a absorção de conhecimento varia bastante<sup>(26)</sup>.

### **3. MÉTODO**

#### **3.1 Tipo de estudo**

Trata-se de um estudo de implementação de melhorias, através da avaliação de programas e políticas, realizado entre julho de 2023 e janeiro de 2025, que seguiu as recomendações do *Consolidated Framework for Implementation Research* (CFIR). Amparada pelo arcabouço teórico da tradução do conhecimento, que se destina a implementação de melhorias nos processos gerenciais da RPCD de Lagoa Santa – MG.

O estudo foi realizado em duas etapas: 1) Pré-implementação e 2) Implementação. Na primeira etapa, de pré-implementação, foi elaborado um diagnóstico da RPCD, realizada a primeira oficina com os *stakeholders* e avaliação da prontidão organizacional para mudança da Rede elaborado um plano de melhorias dos processos gerenciais da RPCD<sup>(27)</sup>. Para a segunda etapa de implementação, foi realizada a segunda oficina com os *stakeholders*, e iniciadas ações pertinentes para implementação de melhorias.

#### **3.2 Cenário do estudo**

O estudo foi realizado no município de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte a 35 km de distância da Capital. Possui 231,9 km<sup>2</sup> de área e uma população de 75.145 pessoas, último censo IBGE (2022). Segundo relatório de cadastros individuais do e-SUS APS (Sistema de Informação em Saúde), o número de cidadão ativos cadastrados no SUS no referido município é de 78.211 indivíduos.

A Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde de Lagoa Santa engloba a população de 1906 usuários com deficiência cadastrados no e-SUS APS. Os serviços que integram a rede em questão são: ESF (24 unidades), clínica ampliada, equipe

multiprofissional, CAPSIJ, CREAB, CAIS e APAE.

Fazem parte da pesquisa todos os serviços inseridos na rede de cuidados à pessoas com deficiência de Lagoa Santa-MG, exceto a APAE por se tratar de um serviço terceirizado. Considerando que a implementação de melhorias se dará nos processos gerenciais da RCPD, todos os serviços poderão ser alcançados pelas melhorias implementadas.

### **3.3 Participantes ou *Stakeholders***

Os participantes do estudo são os *stakeholders*, os atores envolvidos no processo, constituindo-se a peça-chave fundamental para o processo de melhorias. Deste modo, para a participação nas oficinas, definiu-se que o grupo de *stakeholders* seria composto por no mínimo dois e no máximo quatro representantes de cada um dos seguintes segmentos:

- Profissionais envolvidos nos processos de gestão;
- Profissionais, de nível superior, integrantes da equipe multiprofissional e atuantes nos pontos de atenção da RCPD;
- Profissionais da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (JRRCD);
- Usuários da RCPD;
- Familiares da PCD.

O seguimento dos usuários da RCPD foi representado por conselheiros e delegados do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Lagoa Santa-MG. Considerando que os respectivos conselheiros e delegados foram eleitos previamente, por pessoas com deficiência, como representantes de seus direitos em âmbito nacional.

Para o alcance de uma representação fiel da realidade e anseios genuínos das PCD, os representantes dos usuários, obrigatoriamente, foram PCD ou seu representante legal. O representante legal participou da pesquisa por impedimento da PCD avaliar os riscos pertinentes a pesquisa e assinar o TCLE. O presente estudo não contemplou a participação de pessoas ou representantes dos menores de 18 anos de idade. O PCD com deficiência neurológica e impedimento para avaliar os riscos inerentes ao estudo foi substituído por seu representante legal.

Como critérios de inclusão, exclusão e substituição dos *stakeholders* para compor as oficinas considerou-se o descrito a seguir:

**Quadro 1.** Critérios de inclusão, exclusão e substituição dos *stakeholders*, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| CRITÉRIOS                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRITÉRIOS DE INCLUSÃO       | Representantes de cada um dos segmentos descritos acima que estejam vinculados a RPCD por pelo menos um ano e que possuam disponibilidade para participar das oficinas previstas nas etapas do projeto.                                                                                                                                                                        |
| CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO       | Ausência em 2 oficinas consecutivas;<br><i>Stakeholders</i> que eventualmente sejam desligados ou afastados da rede de RCPD ao longo do estudo;<br>Menores de 18 anos;<br>Profissionais que exercem funções exclusivamente administrativas.<br>O PCD com deficiência neurológica que o impeça de avaliar os riscos inerentes ao estudo será substituído por seu representante. |
| CRITÉRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO | As perdas serão consideradas e novos integrantes serão convidados a compor o grupo de <i>stakeholders</i> , de modo que nenhum segmento fique sem representação ou em desigualdade.                                                                                                                                                                                            |

A amostra do estudo foi constituída por conveniência em que os *stakeholders* foram convidados a participar das oficinas que ocorreram em uma das salas de reunião do Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa – MG. Para compor os integrantes das oficinas, o convite foi feito pessoalmente pela pesquisadora principal, que explicou os detalhes da pesquisa. Por se tratar de uma amostra por conveniência, o convite e o recrutamento dos representantes de cada um dos seguimentos já citados, se deu de forma verbal, baseada na disponibilidade em participar das oficinas e na detenção de conhecimentos sobre a rede em questão.

Os profissionais envolvidos nos processos de gestão, os profissionais de nível superior, integrantes da equipe multiprofissional e atuantes nos pontos de atenção da RPCD e os profissionais da JRRCD foram convidados pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde em reuniões rotineiras desta secretaria. Os usuários e os familiares de PCD foram convidados a participar do estudo na plenária do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência de Lagoa Santa-MG. A escolha destes locais para a realização do convite ocorreu devido à oportunidade de concentrar mais de um seguimento nesses locais.

Mediante o aceite do convite, a pesquisadora apresentou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A e B), e elucidou as dúvidas pertinentes à participação no estudo. Deste modo, foram fornecidas três datas para o agendamento da primeira oficina. Destaca-se que todos os envolvidos tiveram voz ativa nas oficinas.

Para a avaliação da prontidão organizacional para mudanças (POM), todos os profissionais de nível superior atuantes nos serviços da rede foram convidados presencialmente, de forma verbal, pela pesquisadora principal, a participar do estudo durante o seminário realizado nos dias 7 e 8 de novembro de 2024. Em seguida, foi realizada uma explicação sobre a pesquisa e a participação, além do esclarecimento de dúvidas. Na sequência foi disponibilizado um *QR Code* com acesso ao instrumento online via *Google Forms*, onde estava disponível o TCLE para leitura e aceitação (Apêndice C).

O questionário foi aplicado ao longo da etapa pré-implementação, que visa avaliar a prontidão organizacional para a mudança nos serviços de saúde da RCPD. Tal avaliação é considerada primordial para o alcance de uma implementação bem-sucedida<sup>(28)</sup>. A população de profissionais da equipe multiprofissional vinculados aos serviços integrantes da RCPD do município de Lagoa Santa é de 104 trabalhadores (quantitativo este passível de alterações devido admissões e ou desligamentos). Considerando a amostragem por conveniência em que os profissionais serão abordados e convidados a participar do estudo, torna-se difícil precisar a amostra. Contudo, estimou-se, pelo menos, 60 respostas ao formulário. Considerou-se como critério de inclusão para responder ao questionário (POM) profissionais vinculados a mais de um ano na RCPD.

### **3.4 Procedimentos para coleta dos dados**

Os dados foram coletados em 2024, após a anuência da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lagoa Santa e a aprovação do CEP/CONEP da Universidade Federal Fluminense. A coleta dos dados respeitou as duas etapas do estudo e ocorrerá em distintas fases em cada etapa, a saber:

#### **1) Etapa Pré-implementação:**

- Revisão de escopo
- Mapeamento gerencial da RCPD
- Definição de indicadores da RCPD
- Oficina com os *Stakeholders*

- Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança
- Elaboração do Plano de Melhorias

## 2) Etapa Implementação:

- Oficina com os *Stakeholders*
- Implementação das ações prioritárias do Plano de Melhorias

### 3.4.1 Etapa Pré-implementação

Na etapa de pré-implementação foi traçado um diagnóstico da RCPD, por meio do mapeamento gerencial e fluxos da Rede, definição de indicadores para avaliação, realização da primeira oficina com os *Stakeholders*, a avaliação da POM e elaborado o Plano de Melhorias.

#### • Revisão de escopo

A Revisão de escopo tem como objetivo mapear na literatura científica evidências sobre as boas práticas nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Aplicou-se o acrônimo PCC que se refere à População, Conceito e Contexto, tal estratégia foi adotada para formular a questão de pesquisa da revisão de escopo. “Quais são as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência?” Na qual P (público-alvo): Pessoa com deficiência; C (conceito): melhores práticas relacionadas a gestão; C (contexto): rede de cuidados à pessoa com deficiência.

Foi desenvolvida com base nas recomendações do *Joana Briggs Institute* (JBI), seguindo as etapas propostas pelo método, a saber: definir e alinhar o objetivo e a questão de pesquisa; desenvolver e alinhar os critérios de inclusão com o objetivo e a questão de pesquisa; descrever a abordagem planejada para a busca, seleção, extração de dados e apresentação de evidências; buscar as evidências; selecionar as evidências; extrair as evidências; analisar as evidências; apresentar os resultados e; resumir as evidências em relação ao objetivo da revisão de escopo, realizando conclusões e observando as implicações das descobertas. Realizou-se o registro da revisão de escopo na plataforma *Open Science Framework* (OSF), onde o mesmo pode ser consultado na íntegra através do DOI [10.17605/OSF.IO/VPDMW](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/VPDMW) (Apêndice D).

Destaca-se que o Procolo da referida revisão de escopo foi aprovado para publicação na Revista *Online Brazilian Journal of Nurse/OBJN* (Anexo 2).

- **Mapeamento gerencial da RCPD**

Para o mapeamento gerencial da RCPD foi realizado inicialmente o estudo das normativas pertinentes a RCPD, a partir da estrutura organizacional posta no arcabouço do MS do Brasil, desta maneira, o mapeamento da RCPD do município de Lagoa Santa foi desenvolvido considerando as particularidades e realidade local, inclusive em relação à oferta de serviços especializados. O mapeamento foi disponibilizado em formato gráfico de fluxograma, considerando as etapas de entrada, processo e saída na RCPD de Lagoa Santa.

Para a elaboração da estrutura gráfica do fluxograma foi utilizada a ferramenta *Lucidchart*, aplicativo de diagramação online e gratuita, que permite a criação de fluxos de processos e outros diagramas. Possui interface intuitiva e permite criar representações visuais de dados para facilitar a comunicação e melhorar processos e estruturas organizacionais.

- **Definição de indicadores da RCPD**

Para este estudo foram definidos os indicadores a serem mensurados e estabelecidos na RCPD de Lagoa Santa. Pretende-se avaliar os indicadores considerando a melhoria implementada a curto, médio e longo prazo.

Na etapa de pré-implementação foram estabelecidos os indicadores que melhor refletirão os resultados da implementação de melhorias nos processos gerenciais da RCPD, sobretudo os que se relacionam com a qualidade dos processos gerenciais. Desta forma foram definidos para o acompanhamento e avaliação da implementação prevista no Plano de Melhorias os seguintes indicadores:

- Taxa de Acesso a RCPD: Avalia a facilidade com que as pessoas com deficiência conseguem acessar, ou seja, serem atendidas nos serviços de saúde da RCPD quando necessário.
- Casos não atendidos: Mensura em números absolutos os casos que foram encaminhados mas não foram atendidos na RCPD, considerados como demanda reprimida.
- Tempo de Espera para Atendimento: Avalia o período de espera desde o encaminhamento até marcação da consulta e atendimento.
- Alta qualificada: Mede a transferência do cuidado para o nível de atenção primário (ESF e clínica ampliada).

**Quadro 2.** Indicadores estabelecidos e a respectiva forma de mensuração, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| INDICADOR                                   | CÁLCULO                                                                                                                 | FREQUENCIA |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Taxa de acesso a RCPD                       | Número de acolhimentos da RCPD por ano/Número de entradas na Junta Reguladora por ano X 100                             | Anual      |
| Número de casos não atendidos na RCPD       | Número absoluto de não atendimentos após avaliação pela Junta Reguladora                                                | Anual      |
| Tempo de espera para atendimento na RCPD    | Média entre a diferença da data do primeiro atendimento e a data da primeira regulação de todos os atendimentos por ano | Anual      |
| Número de casos de alta qualificada da RCPD | Número absoluto de alta qualificada da RCPD por mês                                                                     | Anual      |

Tanto o indicador Número de casos não atendidos na RCPD quanto o indicador Número de casos de alta qualificada da RCPD, não puderam ser transformados em taxas, porque os dados analisados não possuíam o quantitativo de atendimentos dos usuários após passar pela junta reguladora, entendendo que não é possível precisar quando os mesmos foram atendidos nos serviços da rede.

- **Oficina com os *Stakeholders***

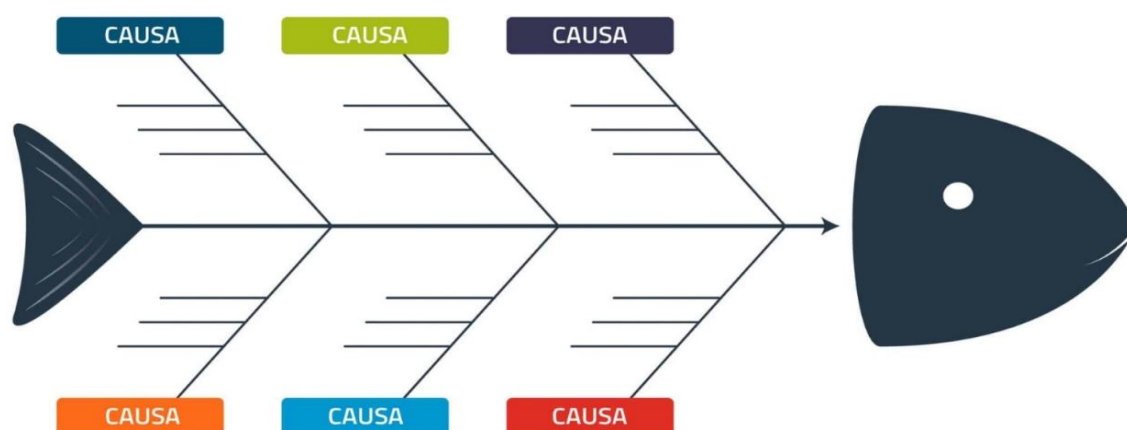
Na realização da primeira oficina, os participantes passaram pelo processo de consentimento e assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para constituírem o grupo de *stakeholders*. Destaca-se que a todos foi entregue uma via assinada do TCLE pela pesquisadora principal e que foram esclarecidos quanto as etapas do estudo. Após o consentimento, foram realizadas perguntas para caracterização do perfil dos *stakeholders* considerando sexo, idade, profissão, tempo em que atuam ou possuem o vínculo na RCPD e para os profissionais de saúde também foi perguntado sobre a especialização ou capacitação na área de atuação referente ao cuidado de pessoas com deficiência.

A primeira oficina, na etapa pré-implementação possuía o objetivo de identificar os nós críticos nos processos gerenciais da RCPD e sua causa raiz, para então propor ações de

melhorias que constituíram o Plano de Melhorias a ser implementado. A oficina foi presencial e previamente agendadas.

A oficina durou, em média, duas horas e trinta minutos e foi realizada em espaço reservado para esta finalidade no Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa e estiveram presentes somente os *stakeholders* e a pesquisadora principal. A primeira oficina foi realizada em três etapas, a saber: definição do problema e causa raiz, proposição de melhorias, priorização das ações. Para a primeira etapa de definição do problema e causa raiz, foi utilizada o diagrama de Ishikawa que constitui-se como diagrama de causa e efeito <sup>(29)</sup>. Comumente chamado de espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta utilizada para encontrar causas e efeitos possíveis que contribuam para a ocorrência da situação problema (Figura 2).

Fonte: Banco de imagens do Canva-pro, 2024.



**Figura 2.** Modelo de Matriz GUT utilizada na oficina com o grupo de Stakeholders, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Os *stakeholders* foram divididos em dois grupos nos quais cada um, paritariamente, contou com um representante de cada seguimento de *stakeholders*, de maneira equitativa. Os grupos receberam orientações sobre a função e elaboração do diagrama. Dessa forma, houve a construção de dois diagramas, que posteriormente gerou um novo diagrama que apresentou a síntese dos pontos levantados pelos dois grupos, garantindo que cada ponto/causa aparecesse uma única vez na ferramenta em questão.

A partir da união dos diagrama de Ishikawa, foi iniciada a segunda etapa da oficina cujo objetivo foi elencar inúmeras ações de melhorias para cada um dos efeitos apontados

anteriormente. Os *stakeholders* foram estimulados a realizar um *brainstorming* (tempestade de idéias) para que assim surgissem visões e percepções distintas sobre as possibilidades de melhorias para as causas que levam ao problema.

Para o registro do *brainstorming* foi utilizada uma cartolina, disposta como um mural, onde no momento da tempestade de ideias a pesquisadora principal fez as anotações pertinentes. Seguimento a oficina, a partir dos registros na cartolina iniciou-se a terceira etapa com a priorização das ações propostas pelos *stakeholders* utilizando a matriz GUT, acrônimo para Gravidade (G), Urgência (U) e Tendência (T) (33) (Figura 3).

| PONTOS | G = GRAVIDADE<br>Consequência se nada for feito      | U = URGÊNCIA<br>Prazo para tomada de decisão | T = TENDÊNCIA<br>Proporção do problema no futuro           | G x U x T               |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5      | Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves | É necessária uma ação imediata               | Se nada for feito, o agravamento da situação será imediato | 5 x 5 x 5<br><b>125</b> |
| 4      | Muito grave                                          | Com alguma urgência                          | Vai piorar em curto prazo                                  | 4 x 4 x 4<br><b>64</b>  |
| 3      | Grave                                                | O mais cedo possível                         | Vai piorar em médio prazo                                  | 3 x 3 x 3<br><b>27</b>  |
| 2      | Pouco grave                                          | Pode esperar um pouco                        | Vai piorar em longo prazo                                  | 2 x 2 x 2<br><b>8</b>   |
| 1      | Sem gravidade                                        | Não tem pressa                               | Não vai piorar ou pode até melhorar                        | 1 x 1 x 1<br><b>1</b>   |

Fonte: Banco de imagens do Canva-pro, 2024.

**Figura 2.** Modelo de Matriz GUT utilizada na oficina com o grupo de Stakeholders, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

- **Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança**

A aplicação da POM foi realizada em uma reunião com os profissionais da equipe multiprofissional ao final do mês de outubro de 2024, período pós-eleitoral por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Em Lagoa Santa, as eleições acontecem em turno único, respeitando a legislação eleitoral.

Todos os profissionais de nível superior atuantes na RCPD foram convidados a participar da reunião e a reponder ao formulário no *Google forms*, que esteve disponível para acesso por meio de um Qrcode. Ao acessar o Qrcode, os pretensos participantes tiveram acesso à primeira parte do formulário, que contém as explicações sobre o estudo e onde

esteve disponível o TCLE para leitura e download. Mediante o aceite em participar do estudo, por meio da marcação da opção, “li e estou de acordo e consinto a minha participação no estudo”, os participantes foram direcionados à segunda parte do formulário. Para aqueles que não consentiram a participação, foi exibida uma página de encerramento e agradecimento pelo tempo disponibilizado. O tempo estimado para responder ao questionário foi de 20 minutos.

Destaca-se que somente tiveram acesso a segunda parte do formulário aqueles que consentiram sua participação previamente. A segunda parte do formulário continha perguntas para caracterização do perfil dos profissionais da equipe multiprofissional da Rede, e o instrumento denominado Prontidão Organizacional para Mudanças (POM) (Anexo 1).

A Universidade Cristã do Texas (UCT) foi a responsável por desenvolver a ferramenta Organizacional *Functioning and Readiness for Change (ORC)*, que é um instrumento que avalia a capacidade para mudanças, motivação, qualidades pessoais, recursos disponíveis para o alcance das mudanças, e o clima organizacional. Apresenta 22 domínios ou escalas para avaliar a capacidade para mudanças dos profissionais envolvidos em serviços de saúde<sup>(31-32)</sup>.

A avaliação POM é uma versão do ORC adaptada ao contexto brasileiro e validado com boas propriedades psicométricas. Consiste em um instrumento simples, dispensando a intercessão de terceiros para sua aplicação. A versão brasileira do instrumento POM (Anexo 2) abrange 65 itens divididos em 12 domínios. São eles:

- ✓ D1- Necessidades do serviço;
- ✓ D2- Necessidades do treinamento;
- ✓ D3- Pressões por mudança,
- ✓ D4- Funcionários;
- ✓ D5- Treinamento;
- ✓ D6- Qualidade dos funcionários - crescimento;
- ✓ D7- Influência,
- ✓ D8-Adaptabilidade,
- ✓ D9- Atitudes no trabalho - esgotamento;
- ✓ D10- Satisfação;
- ✓ D11-Satisfação com treinamento; e

✓ **D12-Utilização do treinamento.**

As respostas do instrumento POM são registradas por meio de escala tipo Likert, onde os respondentes avaliarão o quanto concordam ou discordam de uma afirmação. Sendo uma escala de cinco pontos, onde: 1 - discorda fortemente, 2 - discorda, 3 - incerto, 4 - concorda, e 5 - concorda fortemente. Para os itens que tratam da utilização do treinamento as pontuações se apresentarão de forma semelhante, onde: 1 - nunca, 2 - raramente, 3 - às vezes, 4 - frequentemente, 5 - sempre<sup>(31-32)</sup>.

- **Elaboração do Plano de Melhorias**

A elaboração do Plano de Melhorias, ainda na etapa pré-implementação, é a culminância dos tópicos anteriores considerando as boas práticas no gerenciamento da RPCD descritas por meio da revisão de escopo, bem como o mapeamento do fluxo gerencial da Rede, a definição dos indicadores a serem avaliados de forma periódica, a identificação das causas e efeitos dos problemas encontrados na Rede. Por fim, a avaliação da POM, o diagnóstico situacional da rede e a listagem de ações prioritárias para implementação de melhorias.

O Plano de Melhorias foi desenvolvido com todos estes constituintes, constituiu-se como um guia para a implementação de melhorias, bem como para a avaliação das melhorias implementadas.

### **3.4.2 Etapa Implementação**

Na etapa de implementação foi realizada uma nova oficina com os *Stakeholders* e iniciado o processo para implementação das ações prioritárias.

- **Oficina com os *Stakeholders***

Na segunda oficina com os *stakeholders* foi apresentado o diagnóstico situacional da RPCD e o Plano de Melhorias com as ações prioritárias a serem implementadas. Este foi um momento para sugestões, críticas e mudanças no Plano de Melhorias a partir das considerações dos *stakeholders* e mediante o consenso e pertinência das ponderações. Ademais, foi estabelecido um cronograma para a implementação das ações prioritárias em conjunto com os *stakeholders* que participaram de todo o processo.

- **Implementação das ações prioritárias do Plano de Melhorias**

A partir do cronograma estabelecido na oficina na etapa de implementação, deu-se início as ações prioritárias conduzidas, considerando a viabilidade organizacional, financeira e disponibilidade de recursos humanos para tal. Caso alguma ação prioritária não possa ser desenvolvida, esta será elencada em oficina posterior junto aos *stakeholders* para a proposição de uma solução viável.

### **3.5 Análise dos dados**

Os resultados da revisão de escopo foram apresentados em forma de quadros e nuvem de palavras geradas pelo *software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ)*, além de um resumo descritivo que mostrou como os resultados se relacionam com o objetivo e com a pergunta da revisão.

Os dados referentes aos indicadores foram tabulados em planilha do *Excel* pela pesquisadora principal e foram analisados por meio do cálculo proposto a cada indicador no *software IBM® SPSS®*. A POM foi analisada conforme a sintaxe do instrumento, em que calculou-se a média das respostas por item, somando-se os escores atribuídos a cada resposta e dividindo pelo número de respondentes. Para o cálculo da pontuação por dimensão do instrumento POM, somou-se a média de cada item do domínio e dividiu-se pela quantidade de itens do domínio, após multiplicou-se por 10. As pontuações finais dos domínios variam de 10 a 50, portanto, quanto maior o valor, maior é a propensão a mudança dos participantes.

### **3.6 Aspectos éticos**

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), através do número do parecer 6.948.655/2024, CAAE: 79167224.1.0000.5243. A pesquisadora principal atendeu às exigências éticas apresentadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde<sup>(33)</sup>, que dispõe sobre as diretrizes e normas das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Deu-se início à coleta de dados somente após a aprovação do CEP e mediante a anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa.

Todos os participantes concordaram e assinaram o TCLE e tiveram o direito a uma segunda via do TCLE com a assinatura da pesquisadora principal. Foram informados os objetivos da pesquisa, o método, a garantia do sigilo, e que os mesmos poderiam desistir de

sua participação a qualquer momento.

Foi assegurado aos *stakeholders* o anonimato e sigilo das informações. Os dados coletados neste estudo foram armazenados em dispositivo próprio e local, por um período máximo de 5 anos, sendo destruídos após esse período, logo não será utilizado o armazenamento na nuvem para minimizar o risco de vazamento de dados.

De modo a minimizar os riscos do presente estudo, os participantes receberam um código de identificação após o processo de consentimento (exemplo: S1- *Stakeholders* 1, S2- *Stakeholders* 2 e assim sucessivamente), a fim de preservar a identidade dos participantes e garantir o anonimato. Foi resguardado aos *stakeholders* o direito de não responder qualquer questão sem necessidade de justificativa ou explicação, assim como puderam desistir a qualquer momento e retirar o seu consentimento, sem qualquer tipo de ônus.

### **3.7 Riscos**

Os riscos dessa pesquisa estão relacionados a exposição dos participantes em discussões sensíveis sobre o processo de trabalho e exposição não intencional de informações confidenciais. Para mitigar esses riscos, foi seguido rigoroso protocolo ético, protegendo a privacidade dos participantes, proporcionando um ambiente seguro e garantindo que os benefícios superam significativamente os riscos potenciais. Além disso, a pesquisadora adotou rígidos critérios éticos no decorrer da pesquisa para garantir que os riscos fossem minimizados e a pesquisa conduzida de maneira ética e segura. Para tal os participantes não tiveram, em nenhum momento da pesquisa, sua identidade ou qualquer informação pessoal reveladas ou relacionadas as suas respostas. Nas oficinas, as respostas foram dos grupos e não pessoais e/ou individuais, o conjunto de falas e colocações dos participantes foram trabalhadas de modo a constuir as ferramentas propostas nesta etapa.

Para os participantes que responderam ao formulário via *Google Forms*, as respostas foram anônimas, sem a solicitação de qualquer informação pessoal que identifique o participante, garantindo, assim, o sigilo e incógnita sobre a autoria.

Contudo, destaca-se que não será possível garantir confidencialidade absoluta dos dados, levando em consideração que esta etapa ocorreu em formulário online, aumentando a possibilidade de violação de informações. No entanto, o material e os dados do estudo foram e serão utilizados exclusivamente para os fins definidos no TCLE, conforme a

autorização de concessão pelos participantes. Os resultados serão divulgados em eventos acadêmicos ou publicados em revistas científicas, sem qualquer identificação dos participantes, garantindo a preservação do anonimato.

Para minimizar tais riscos relacionados ao ambiente virtual, utilizamos conexões seguras (HTTPS) para proteger a transmissão e o armazenamento de informações. Após a conclusão da coleta de dados, um *download* dos dados foi realizado para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem".

Os dados coletados foram armazenados em um dispositivo protegido e local seguro. Todos os documentos referentes ao estudo foram salvos em máquina física da pesquisadora principal, assim como os registros físicos serão mantidos arquivados durante cinco anos, sendo deletados a seguir. Os dados coletados não serão utilizados para outras pesquisas.

Cabe esclarecer que a pesquisadora principal não exerce função de chefia sobre os participantes da pesquisa. Não atuando direta ou indiretamente em suas avaliações, validações de carga horária, concessões ou impedimentos de qualquer natureza em relação aos *stakeholders*.

### **3.8 Benefícios**

Como benefício da pesquisa, os participantes contribuíram na melhoria do seu próprio processo de trabalho, atuando de forma ativa e sendo escutados em seus anseios e sugestões. Portanto, a pesquisa pode aumentar a motivação dos funcionários e o engajamento, pois os desafiará intelectualmente e oferecerá oportunidade de contribuição significativa para o avanço do conhecimento em relação à RCPD.

A colaboração com outros colegas, e equipes de diferentes áreas pode expandir a rede de contatos profissionais e promover a colaboração interdisciplinar na resolução de um problema real do processo de trabalho.

O envolvimento neste projeto de pesquisa poderá dar acesso a recursos, informações e tecnologias avançadas que podem não estar prontamente disponíveis no ambiente de trabalho cotidiano. Em relação ao benefício relacionado a participação dos usuários ou de seus responsáveis, vamos citar a participação efetiva no processo de implementação de mudanças em prol de suas reais dificuldades dentro da rede de atenção. Além disso, foi oferecido o direito a voz tão questionado e pleiteado por este público.

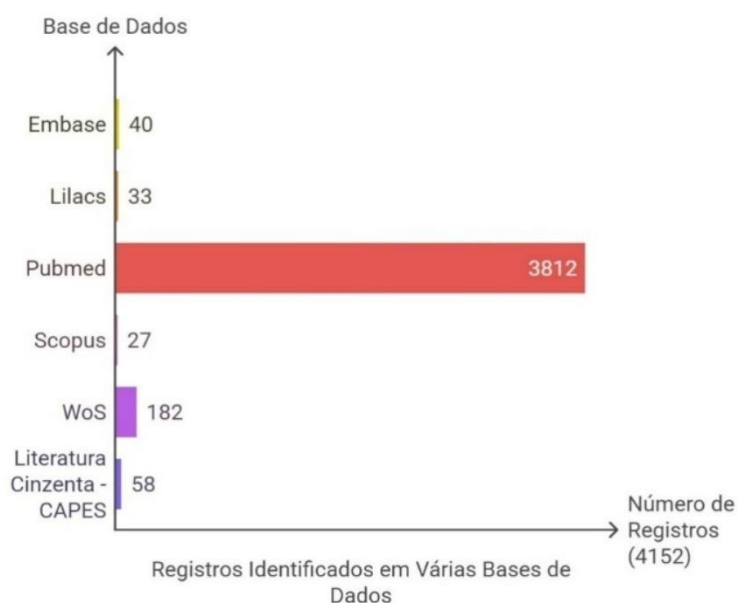
## 4. RESULTADOS

### 4.1 Pré-implementação

#### 4.1.1 Revisão de Escopo

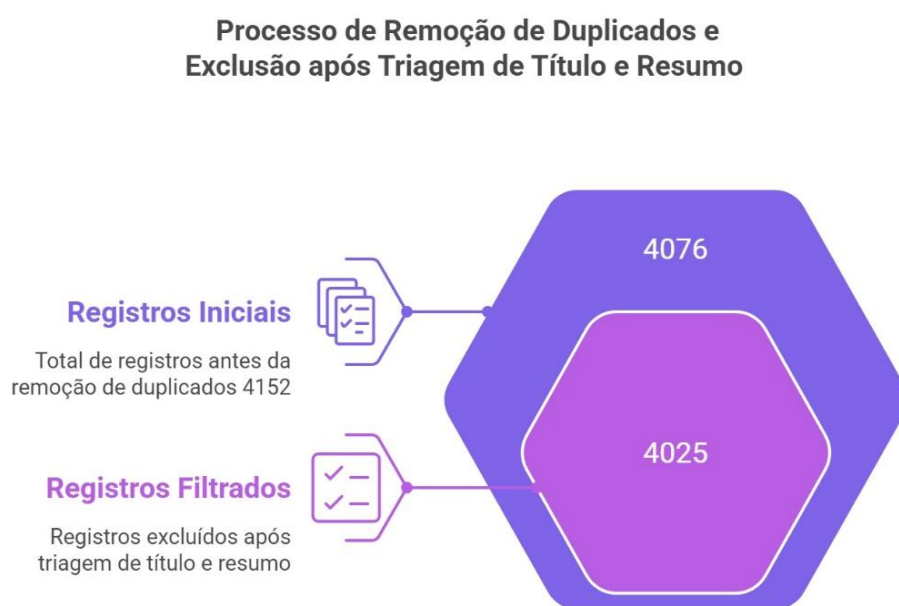
Esta revisão de escopo buscou mapear e agrupar as evidências disponíveis na literatura sobre as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência. O estudo foi conduzido com base nas diretrizes do *Joanna Briggs Institute*. Aplicou-se o acrônimo PCC que se refere a População, Conceito e Contexto, tal estratégia foi adotada para formular a questão de pesquisa da revisão de escopo. “Quais são as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência?” Na qual P (público-alvo): Pessoa com deficiência; C (conceito): melhores práticas relacionadas a gestão; C (contexto): rede de cuidados à pessoa com deficiência

As buscas nos distintos recursos informacionais foram realizadas em novembro de 2023 e retornaram 4152 estudos (Figura 4), a serem filtrados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos no protocolo do estudo cadastrado na *OSF*.



**Figura 4.** Registros identificados nos recursos informacionais (n=4152), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Após as buscas, a literatura foi inserida no *software Rayyan*, onde foram removidas as duplicatas (n=76). A triagem da literatura foi realizada mediante a leitura e avaliação dos títulos e resumos encontrados (n=4076), como potencialmente elegíveis, por dois revisores cegos para reduzir a possibilidade de viés interpretativo (Figura 5). Para a resolução das divergências um terceiro revisor independente foi acionado e neste processo, foram removidos 4025 registros.



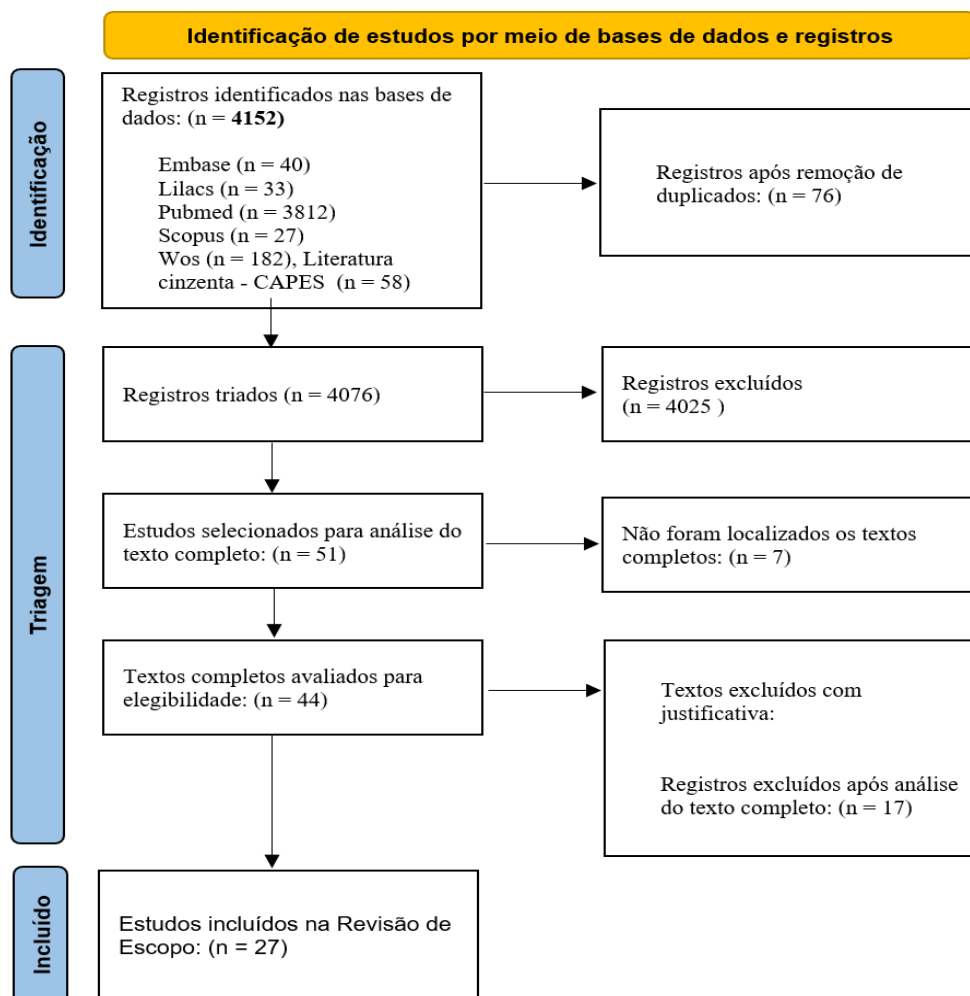
**Figura 5.** Processo de triagem e exclusão dos registros identificados nos recursos informacionais (n=4076), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

A partir da triagem, os títulos considerados elegíveis ( $n=51$ ) foram lidos na íntegra, confirmando sua elegibilidade, destes sete documentos não foram encontrados ou não estavam disponíveis em texto completo. Dos 44 restantes, foram excluídos 17 registros que não respondiam a questão de pesquisa, restando 27 registros para análise de escopo. (Figura 6).



**Figura 6.** Processo de seleção e inclusão dos registros para análise do escopo ( $n=27$ ), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

As etapas de seleção dos estudos foram realizadas de acordo fluxograma de revisão do escopo (PRISMA – ScR), que incluiu 27 estudos para a revisão de escopo (Figura 7).



**Figura 7.** Fluxograma de seleção dos registros *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta – Analyses Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-SCR), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Para a extração dos dados dos artigos selecionados para análise do escopo, utilizou-se um instrumento (Quadro 3) baseado em outro desenvolvido pelo JBI que continha os seguintes tópicos: ano da publicação, autoria, idioma, título, objetivo do estudo, metodologia e o tipo da publicação. Identificou-se a partir da análise da literatura, as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência.

**Quadro 3.** Descrição dos estudos incluídos na revisão de escopo (n=27), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| Nº | ANO/IDIOMA    | AUTOR/TÍTULO                                                                                                                          | OBJETIVO                                                                                                               | MÉTODO/<br>TIPO DE ESTUDO                                                                                                         | PRINCIPAIS RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2008 / Inglês | Teresa A. Coughlin et al.<br>/ Does Managed Care Improve Access to Care for Medicaid Beneficiaries with Disabilities?A national Study | Avaliar o impacto do Managed Care nos EUA para melhorar o acesso à saúde de beneficiários com deficiência do Medicaid. | Análise de dados do National Health Interview Survey (1997–2004), comparando modelos de Managed Care e FFS / Estudo Observacional | A pesquisa indica que os cuidados gerenciados pelo Medicaid podem melhorar o acesso aos cuidados para beneficiários com deficiência, particularmente em áreas urbanas com programas de assistência gerenciada totalmente capitalizados. |
| 2  | 2010 / Inglês | M. Elizabeth Sandel et al. / The California Kaiser Permanente Health System: Evolving to meet the needs of people with disabilities   | Documentar como o sistema de saúde da Kaiser Permanente evoluiu para atender melhor pessoas com deficiência.           | Análise das iniciativas e práticas implementadas após a ADA / Relato de experiência                                               | Implementação de treinamento cultural, adaptação de instalações e modelos centrados no paciente, removendo barreiras para atender à ADA.                                                                                                |
| 3  | 2010 / Alemão | Deutsche Vereinigung für Rehabilitation / Lösungsoptionen der                                                                         | Propor soluções para superar problemas na provisão de                                                                  | Revisão de literatura e análise de práticas relacionadas à distribuição de dispositivos                                           | Identificou desafios na qualidade e acessibilidade. Propôs treinamento, avaliação contínua e processos                                                                                                                                  |

|   |               |                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | Deutschen Vereinigung für Rehabilitation zur Überwindung von Problemen bei der Versorgung mit Hilfsmitteln | dispositivos assistivos na Alemanha.                                                                                                            | assistivos. / Revisão Narrativa                                                          | padronizados para otimizar os serviços.                                                                                               |
| 4 | 2011 / Inglês | WHO/World Report on Disability                                                                             | Tem como objetivo apoiar a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.                          | Revisão de literatura/documentose consulta com especialistas globais. / Relatório Global | Destacou a necessidade de reabilitação comunitária, coordenação entre níveis de cuidado e acesso a dispositivos assistivos.           |
| 5 | 2012 / Árabe  | N.M. Kronfol / Health services to groups with special needs in the Arab world: a review                    | Examinar os serviços de saúde para idosos com limitações físicas e pessoas com doenças mentais em países árabes, incluindo barreiras de acesso. | Revisão narrativa com análise de dados secundários.                                      | Barreira ao transporte e custos foram destacados, além da falta de reconhecimento das necessidades específicas dos grupos analisados. |

|   |               |                                                                                      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 2014 / Inglês | Frontera Walter / The World Health Organization Disability Action Plan               | Apresentar estratégias globais para melhorar o acesso à saúde e reabilitação para pessoas com deficiência.                                | Consultas globais e análise de políticas. / Plano de ação                                                                                                                                | Propôs a remoção de barreiras, ampliação dos serviços de reabilitação e melhor coleta de dados comparáveis internacionalmente. O plano descreve três objetivos principais: remover barreiras aos serviços de saúde, fortalecer os serviços de reabilitação e apoio e aprimorar a coleta de dados sobre deficiência. |
| 7 | 2014 / Inglês | Tara Lagu et al. / The Axes of Access: Improving Care for Patients with Disabilities | Identificar barreiras de acesso físico, político e comunicacional para pessoas com deficiência nos EUA e propor soluções baseadas na ADA. | Discussão baseada em exemplos de casos, integrando normas da ADA e análise de acessibilidade nos serviços de saúde. / Revisão da literatura e evidências existentes, análise qualitativa | Melhorias incluem equipamento acessível, formação de profissionais e revisão de políticas institucionais para universalizar o acesso.                                                                                                                                                                               |

|   |               |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 2014 / Inglês | Juan M. Guzman, Elva G. Salazar / Disability and Rehabilitation in Mexico                                  | Avaliar dados de reabilitação no México e discutir a implementação de um modelo inovador de serviços de reabilitação de primeiro nível. | Análise de dados nacionais e estudo do impacto de um modelo local de reabilitação. / Relato de Esperiência                                                                                                                                                                                                   | O modelo aumentou a capacidade dos serviços em 60% desde 2003, destacando o papel de pequenas clínicas locais no acesso à                                            |
| 9 | 2015 / Inglês | Fary Khan et al. / Rehabilitation in Madagascar: Challenges in Implementing the WHO Disability Action Plan | Explorar os desafios e facilitadores na implementação do Plano de Ação da OMS para Deficiência em Madagascar.                           | Um extenso programa de workshops de 14 dias foi realizado no Hospital Universitário Antananarivo e Antsirabe, envolvendo profissionais de reabilitação de várias instalações. Workshops com 29 profissionais de saúde em Madagascar e análise qualitativa das barreiras enfrentadas. / Relato de experiência | Reforçou a necessidade de treinamento, infraestrutura adequada e reabilitação comunitária, destacando a falta de padronização nos serviços e políticas fragmentadas. |

|    |               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 2015 / Inglês | Nancy Sharby et al. / Decreasing Health Disparities for People with Disabilities through Improved Communication Strategies and Awareness | Identificar barreiras de comunicação em cuidados de saúde para pessoas com deficiência nos EUA e propor estratégias para redução de desigualdades. | Revisão Sistemática da literatura em MEDLINE e CINAHL, avaliando estudos de 2005-2014 sobre barreiras e estratégias de comunicação em saúde.                                                                                                                    | Melhorias sugeridas incluem treinamento de profissionais, adaptação de equipamentos médicos e foco no atendimento centrado no paciente para aumentar a inclusão. |
| 11 | 2016 / Inglês | Balogh et al. / Organising healthcare services for persons with an intellectual disability                                               | Avaliar intervenções organizacionais para melhorar os cuidados de saúde de pessoas com deficiência intelectual.                                    | Revisão sistemática incluindo <i>CENTRAL</i> , <i>MEDLINE</i> , <i>EMBASE</i> , <i>CINAHL</i> e outros, de abril de 2006 a setembro de 2015. Revisão de ensaios clínicos randomizados avaliando intervenções de saúde para pessoas com deficiência intelectual. | Estratégias que aumentaram a intensidade de cuidados reduziram problemas comportamentais, mas há evidências limitadas sobre outros impactos.                     |
| 12 | 2017 / Inglês | Collins et al. / Global services and support for children with                                                                           | Identificar lacunas em políticas e serviços globais para crianças                                                                                  | Revisão narrativa de políticas e programas globais,                                                                                                                                                                                                             | Intervenções precoces e apoio aos cuidadores melhoram resultados de inclusão social e saúde, destacando                                                          |

|    |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | developmental delays and disabilities: Bridging research and policy gaps.                                                                                              | com atrasos de desenvolvimento.                                                                                                | analisando evidências sobre lacunas e boas práticas.                                                                                       | a importância do treinamento e acesso universal.                                                                                                                     |
| 13 | 2018 / Português | Thalita Evaristo Couto Dias / Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Minas Gerais: Análise da Qualidade do Cuidado sob a Perspectiva de Usuários e Acompanhantes | Analisar a qualidade do cuidado na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Minas Gerais, segundo usuários e acompanhantes | Estudo observacional transversal com 871 usuários, utilizando o instrumento <i>Quality of Care Scale</i> e análise psicométrica dos dados. | Identificou baixa qualidade no eixo "Acesso" e necessidade de melhoria em tempo de espera, oferta local de serviços e suporte intersetorial para atividades sociais. |
| 14 | 2020 / Português | Aline M. Condessa <i>et al.</i> / Atenção odontológica especializada para pessoas com deficiência no Brasil: perfil dos Centros de                                     | Analisar os serviços odontológicos especializados para pessoas com deficiência no Brasil.                                      | Análise dos dados do PMAQ-CEO (Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade). Estudo transversal                                             | Identificou lacunas de acessibilidade e recomendou eliminar barreiras físicas e atitudinais nos serviços.                                                            |

|    |                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | especialidades odontológicas                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 2020 / Inglês    | Anne Kavanagh <i>et al.</i> /Improving health care for disabled people in COVID-19 and beyond: Lenssons from Australia and England      | Explorar como o COVID-19 impactou pessoas com deficiência e propor melhorias futuras para políticas de saúde.           | Relato de experiência / Análise qualitativa comparativa de respostas de diferentes países      | O estudo enfatiza a necessidade de respostas governamentais coordenadas e melhor coleta de dados sobre deficiência para melhorar os resultados de saúde durante emergências de saúde. |
| 16 | 2018 / Português | Amorim et al. / Avanços e desafios na atenção à saúde de pessoas com deficiência na atenção primária no Brasil: uma revisão integrativa | Analisar fatores que facilitam ou dificultam a atenção integral à saúde de pessoas com deficiência na atenção primária. | Revisão integrative de literatura baseada em 30 estudos entre 2006-2016, com análise temática. | Capacitação profissional insuficiente e falta de acessibilidade perpetuam iniquidades; recomendou treinamento e reformas estruturais nos serviços de atenção primária.                |

|    |               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 2019 / Inglês | Pauline Heslop et al. / Implementing reasonable adjustments for disabled people in healthcare services                                | Examinar a aplicação de ajustes razoáveis em serviços de saúde no Reino Unido para melhorar o acesso de pessoas com deficiência. | Revisão narrativa de casos e auditorias de relatórios hospitalares, complementada por workshops com pacientes e profissionais.                                                                            | Ajustes como acessibilidade física, formatos de comunicação inclusiva e mudanças organizacionais foram fundamentais para a inclusão.                                                 |
| 18 | 2019 / Inglês | Jane L. Symons et al. / Improving care coordination in community physical rehabilitation: A qualitative study of the change framework | Explorar como um framework colaborativo melhora a coordenação de cuidados em serviços de reabilitação comunitários.              | Estudo qualitativo / O framework colaborativo promoveu interações sociais positivas e mudanças organizacionais que levaram a maior coordenação de cuidados, embora tenha requerido mais tempo e recursos. | O framework colaborativo promoveu interações sociais positivas e mudanças organizacionais que levaram a maior coordenação de cuidados, embora tenha requerido mais tempo e recursos. |

|    |               |                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 2019 / Inglês | Raju Dhakal,Christine C. Groves / Rehabilitation in Nepal                                             | Analisar o estado dos serviços de reabilitação no Nepal e propor estratégias para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços.                    | Revisão de literatura e análise de políticas nacionais e internacionais de reabilitação. Estudo descritivo.                                                                                                                          | O artigo pede estratégias baseadas em evidências para otimizar o acesso e a eficácia da reabilitação, o que poderia melhorar significativamente a qualidade de vida de indivíduos com deficiência no Nepal. |
| 20 | 2020 / Inglês | Justine Aenishänslin et al. / Experiences accessing and using rehabilitation services in Sierra Leone | Explorar experiências de acesso a serviços de reabilitação em Serra Leoa e propor soluções para barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência. | Estudo qualitativo. O estudo empregou análise de conteúdo qualitativa para explorar as experiências de indivíduos com deficiências físicas acessando serviços de reabilitação. As entrevistas foram conduzidas com 38 participantes. | Identificou custos, distância e falta de equipamentos adequados como desafios principais. Recomendou melhorias nos sistemas locais e financiamento comunitário.                                             |

|    |               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 2022 / Inglês | Dupuis Frédérique et al.Strategies to reduce waiting times in outpatient rehabilitation services                                                                            | Avaliar a eficácia de estratégias do redesenho de serviços para reduzir o tempo de espera em serviços de reabilitação ambulatorial. | Revisão sistemática de 19 estudos com análise narrativa e avaliação de qualidade metodológica utilizando ferramentas padronizadas. | Estratégias como autossolicitação, triagem expandida e mudança no modelo de atendimento reduziram tempos de espera e melhoraram a satisfação do paciente. |
| 22 | 2021 / Inglês | Mahmudul H. Al Imam et al. / Situation analysis of rehabilitation services for persons with disabilities in Bangladesh: identifying service gaps and scopes for improvement | Avaliar o estado dos serviços de reabilitação para pessoas com deficiência em Bangladesh.                                           | Estudo de situação. Análise de 36 documentos e entrevistas com 1102 provedores de reabilitação.                                    | Serviços de reabilitação estão concentrados em áreas urbanas; recomendou descentralização e maior investimento em treinamento e tecnologias assistivas.   |

|    |                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 2021 / Inglês       | Sandro Elisei et al /<br>Improving health care<br>accessibility for people<br>with complex<br>disabilities                                               | Melhorar as<br>possibilidades de<br>cuidado para pessoas<br>com deficiências<br>complexas, garantindo<br>oportunidades iguais no<br>acesso aos serviços de<br>saúde e superando as<br>desigualdades<br>existentes. | O artigo enfatiza inovações<br>organizacionais e gerenciais<br>para melhorar a<br>acessibilidade à saúde para<br>pessoas com deficiências<br>complexas, em vez de se<br>concentrar apenas em<br>soluções clínicas. | Treinamento para profissionais,<br>Implementação de um ambulatório<br>multispecialista no Instituto<br>Serafico, com espaços acessíveis e<br>instrumentos médicos adaptados. |
| 24 | 2022 / Inglês       | Skempes et al. /<br>Supporting government<br>policies to embed and<br>expand rehabilitation in<br>health systems in<br>Europe: A framework<br>for action | Desenvolver um<br>quadro de ações para<br>expandir e integrar<br>serviços de reabilitação<br>nos sistemas de saúde<br>europeus.                                                                                    | Revisão de literature temática<br>e consultas a especialistas em<br>3 workshops, analisando 135<br>documentos relevantes.                                                                                          | Propôs 48 ações políticas<br>organizadas em 6 domínios para<br>melhorar a governança,<br>financiamento e integração da<br>reabilitação nos sistemas de saúde.                |
| 25 | 2021 /<br>Português | Moretti, Patrícia /<br>Acesso à Rede de<br>Atenção à Saúde por                                                                                           | Analisar experiências<br>de pessoas com<br>deficiência intelectual                                                                                                                                                 | Pesquisa qualitativa com<br>observação participante e<br>análise de narrativas de 12                                                                                                                               | Identificou estigmatização e<br>violência institucional como<br>barreiras principais, propondo redes                                                                         |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Pessoas com Deficiência Intelectual                                                                                                                                                              | no acesso à Rede de Atenção à Saúde no Brasil.                                                                                                      | pessoas neurodiversas e seus cuidadores legais.                                      | de solidariedade para promover a inclusão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | 2022 / Inglês    | Ebenezer Dassah et al. / Health care providers' and persons with disabilities' recommendations for improving access to primary health care services in rural northern Ghana: A qualitative study | Identificar barreiras e propor estratégias para melhorar o acesso de pessoas com deficiência a serviços de saúde primários em áreas rurais de Gana. | Entrevistas qualitativas com 33 participantes e análise temática dos dados.          | O estudo identificou quatro temas para melhorar o acesso aos cuidados primários de saúde para pessoas com deficiências físicas na zona rural de Gana: 1) Tornar os cuidados de saúde mais acessíveis; 2) Aumentar a disponibilidade de prestadores e serviços; 3) Fornecer mais educação sobre navegação do sistema; 4) Melhorar o acesso a instalações e equipamentos de saúde para pessoas com deficiência. |
| 27 | 2023 / Português | Hadassah dos Reis Maia / Desafios e caminhos da implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com                                                                                                     | Examinar a implementação da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência no Amazonas,                                                                  | Pesquisa qualitativa com gestores, análise documental e entrevistas em profundidade. | Desafios incluem falta de recursos e planejamento estratégico; destacou-se a importância da articulação entre níveis de cuidado e envolvimento comunitário.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                            |                                                |  |  |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Deficiência no<br>Amazonas | identificando desafios<br>e melhores práticas. |  |  |
|--|--|----------------------------|------------------------------------------------|--|--|



A Análise de similitude identificou os vocábulos que aparecem em coocorrência nos resultados dos registros analisados na revisão de escopo. Isto significa que quanto maior for a conexão entre os vocábulos, maior a espessura das linhas que os ligam (Figura 9).



**Figura 9.** Análise de Similitude dos vocábulos mais recorrentes nos resultados dos registros analisados na revisão de escopo, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

A centralidade da palavra *pessoa* permanece na análise de similitude, no halo amarelo e, este vocábulo possui forte conexão com a palavra *acesso* no halo Vermelho, com a palavra *necessidade* no halo verde, com a palavra *cuidado* no halo azul e, por fim apresenta coocorrência com o vocábulo *identificar* no halo roxo.

A centralidade da palavra *pessoa*, no halo amarelo, reafirma sua importância no contexto da análise, estando diretamente conectada aos termos *acessibilidade*, *triagem*, *desafio*, *intelectual*, *rede*, *plano*, *pesquisa*, *estudo*, *enfrentar*, *dado* e *grupo*. Esses termos

indicam que a abordagem centrada na pessoa requer estratégias que garantam acessibilidade, triagem eficiente, enfrentamento de desafios e suporte por meio de uma rede bem estruturada. Além disso, a necessidade de dados, pesquisas e estudos é essencial para embasar decisões e melhorar os serviços da RCPD.

No halo vermelho, a relação entre as palavras acesso, melhorar, incluir, garantir, maior, principal, qualidade, reduzir, baixo e cuidador reforça a necessidade de assegurar a inclusão da PCD e de seus cuidadores nos serviços especializados, priorizando qualidade e reduzindo dificuldades no acesso. O termo reduzir sugere ações voltadas para a diminuição do tempo de espera e de barreiras no atendimento. A palavra qualidade, por sua vez, enfatiza que esse processo deve ser estruturado para proporcionar um serviço eficiente e humanizado.

O halo verde estabelece conexões entre necessidade, atendimento, programa, aumento, social, modelo, destacar, enfatizar, participante e atender. Esse conjunto evidencia a necessidade de ampliar o atendimento por meio de programas sociais e modelos inovadores, garantindo um aumento na cobertura e a participação ativa dos usuários. A relação com destacar e enfatizar sugere a importância de valorizar boas práticas e disseminar experiências bem-sucedidas dentro da RCPD.

No halo azul, a relação entre cuidado, profissional, sistema, treinamento e desenvolvimento aponta para a importância da capacitação e do desenvolvimento profissional para aprimorar o cuidado oferecido à PCD. A presença do termo sistema indica que essa capacitação deve ser incorporada de forma estruturada e contínua, garantindo um atendimento qualificado e alinhado às demandas do serviço.

Por fim, o halo roxo, composto pelos termos resultado, identificar, significativo e unidade, destaca a necessidade de identificar e mensurar os impactos das intervenções, garantindo resultados significativos. O conceito de unidade sugere a importância da integração entre os serviços, promovendo uma abordagem unificada e coordenada para a melhoria contínua do atendimento.

Diante dos principais resultados dos estudos analisados, foi possível elaborar um quadro síntese de recomendações das melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência (Quadro 4).

**Quadro 4.** Síntese recomendações das melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

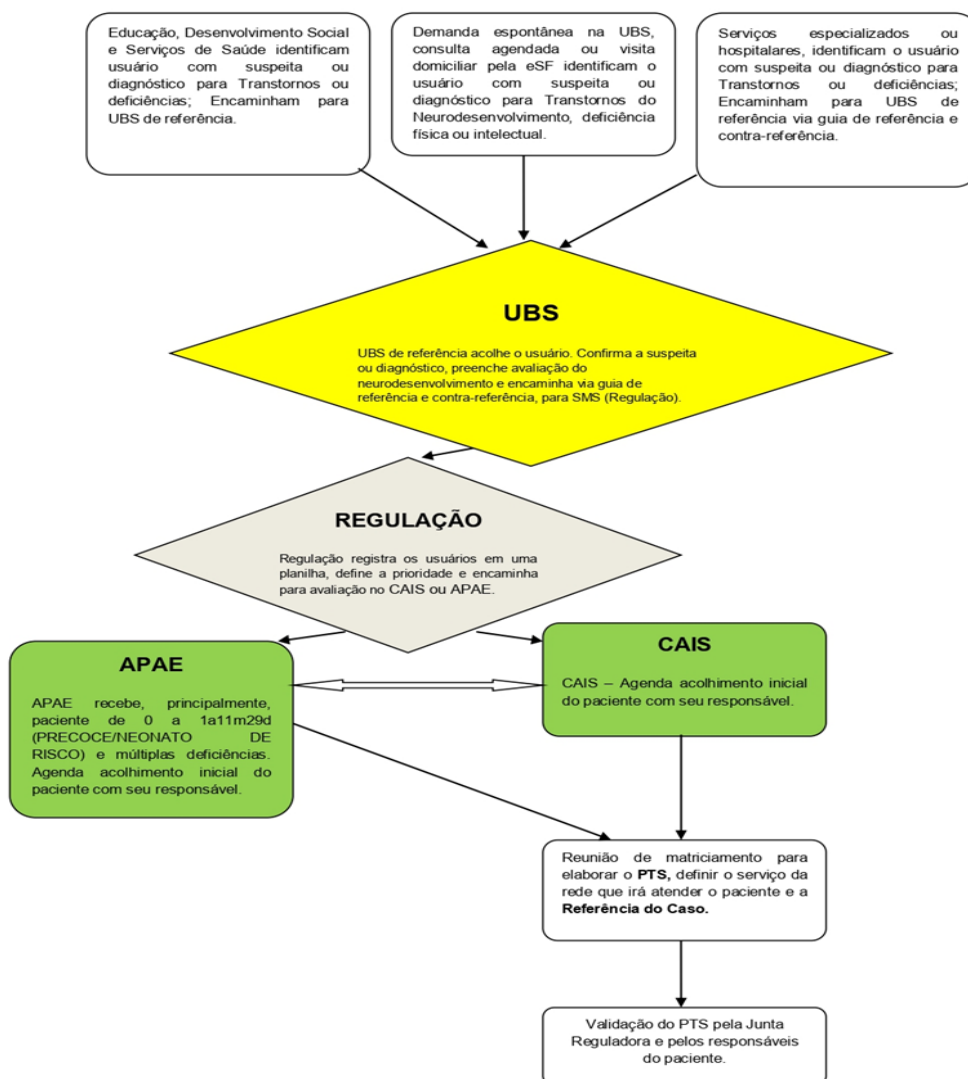
| <b>DOMÍNIO</b>                        | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acessibilidade Física                 | Garantir ambientes acessíveis, incluindo elevadores, rampas, banheiros adaptados e equipamentos médicos                                             |
| Acessibilidade Comunicacional         | Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e pessoas com deficiência, incluindo materiais acessíveis e treinamento em linguagem inclusiva. |
| Coordenação e Integração dos Serviços | Implementar um modelo de assistência coordenada para otimizar o fluxo de pacientes e evitar fragmentação nos atendimentos.                          |
| Capacitação Profissional              | Incorporar treinamento sobre atendimento a pessoas com deficiência na formação de profissionais de saúde, garantindo práticas mais humanizadas.     |
| Financiamento e Sustentabilidade      | Criar mecanismos de financiamento para garantir a continuidade dos serviços de reabilitação e aquisição de dispositivos assistivos.                 |
| Atendimento Central no Paciente       | Priorizar um modelo de cuidado personalizado, considerando as necessidades individuais e respeitando a autonomia do paciente.                       |
| Uso de Tecnologia e Inovação          | Investir em telemedicina, registros eletrônicos e dispositivos assistivos para melhorar a qualidade do atendimento                                  |

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engajamento da Comunidade      | Criar redes de apoio entre pacientes, familiares e profissionais para promoção e melhor adesão aos tratamentos        |
| Políticas Públicas e Regulação | Implementar políticas baseadas em evidências para fortalecer a governança e a regulação dos serviços de reabilitação. |
| Atenção Primária e Prevenção   | Integrar a reabilitação nos serviços de atenção primária para facilitar o acesso precoce aos cuidados                 |
| Mobilidade e Transporte        | Garantir transporte acessível para pessoas com deficiência chegarem aos serviços de saúde                             |
| Monitoramento e Avaliação      | Desenvolver indicadores de qualidade e avaliações periódicas para medir a efetividade dos serviços prestados          |

#### 4.1.2 Mapeamento gerencial da RCPD

O mapeamento gerencial da RCPD descreve todo o caminho percorrido pela pessoa com deficiência até que a demanda seja atendida ou solucionada e, ainda, descreve de forma gráfica os processos gerenciais da RCPD do Município de Lagoa Santa-MG, com o recorte tempo em setembro de 2024 antes da implementação de melhorias. A partir do estudo das normativas pertinentes a RCPD e da estrutura organizacional posta no arcabouço do Ministério da Saúde (MS), o mapeamento da RCPD do município de Lagoa Santa anterior a implementação (Figura 10).

**FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM LAGOA SANTA/MG**



Fonte: Grupo de Trabalho da Implantação do CAIS, 2023.

**Figura 10.** Mapeamento Gerencial da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

No município de Lagoa Santa, Minas Gerais, o fluxo de entrada na rede se inicia pela APS, que desempenha papel fundamental na investigação e encaminhamento dos casos. Deste modo, as etapas de entrada na RCPD são: identificação ou suspeita do caso, por profissionais da saúde, do bem-estar social, ou da educação.

Os processos estabelecidos na RCPD são: encaminhamentos para avaliação na APS; investigação dos casos suspeitos; intervenções interdisciplinares e intersetoriais; encaminhamento seguro e adequado para os serviços especializados. A etapa de saída da RCPD é constituída por: alta qualificada, transferência do cuidado e alta.

Em Lagoa Santa, foi desenvolvido um instrumento de avaliação do neurodesenvolvimento para orientar a avaliação e identificação dos casos. Seu preenchimento tornou-se obrigatório para a equipe de saúde da família (médico ou enfermeiro). Buscou-se, com a efetivação do instrumento de avaliação, aproximar a equipe da família, apresentar a PCD que reside em seu território, e fortalecer o vínculo entre o usuário, a família e a Atenção Primária à Saúde. Além de minimizar encaminhamentos inadequados que podem sobrecarregar os serviços especializados.

Este fluxo deveria garantir a investigação e intervenção prévia de todos os casos no nível primário de atenção, com o apoio da equipe multiprofissional. As equipes multiprofissionais na APS são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas do conhecimento e categorias profissionais. Elas operam de maneira complementar e integrada às outras equipes que atuam na APS.

No cenário atual da RCPD, a APS não executa, por diversos motivos, as investigação ou intervenções pertinentes, o que impacta notavelmente o acesso dos usuários aos serviços especializados e contribui para o aumento da demanda reprimida da RCPD. A regulação, por sua vez, é o segundo nível da rede e recebe os encaminhamentos da APS. Até julho de 2024, o município ainda realizava os encaminhamentos por meio de guias de referência e contrarreferência físicas, que eram recebidas pelo setor de regulação, via malotes. A partir de agosto, os encaminhamentos passaram a ser realizados via Sistema de Regulação do MS (SISREG).

Na regulação cada caso é avaliado, priorizado e direcionado ao serviço especializado mais adequado. Os serviços especializados na atenção secundária, que integram a RCPD em Lagoa Santa, são o Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), o Centro de Reabilitação (CREAB) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Cada um desses pontos de atenção desempenha um papel específico no atendimento à pessoa com deficiência.

No mapeamento atual da rede, os casos de longa duração, deficiência intelectual, transtornos do neurodesenvolvimento e distúrbios de aprendizagem, são encaminhados ao

CAIS, via regulação. Desta forma, o CAIS absorve toda a demanda enviada pela regulação no município de Lagoa Santa, oferecendo atendimento especializado e reabilitação para a maioria dos pacientes com deficiência. No que tange à regulação, o CREAB recebe encaminhamentos diretamente nas unidades CREAB Várzea e CREAB Vila Maria. Esse modelo descentralizado de regulação é conduzido por fisioterapeutas, que atuam como referências técnicas de cada serviço.

A APAE de Lagoa Santa integra a RCPD como o Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual (SERDI), e o Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA), seu foco é a assistência à saúde de neonatos de risco, promovendo a intervenção precoce com o objetivo de prevenir deficiências e possibilitar o diagnóstico e tratamento antecipados, especialmente para aqueles com maior vulnerabilidade, para que recebam a intervenção adequada desde os primeiros sinais de risco. A APAE contratualizou com a Secretaria de Saúde de Lagoa Santa, o quantitativo de 152 crianças, maiores de dois anos. Além de vagas destinadas aos neonatos de risco, respeitando as normativas SERDI/PIPA.

Cabe destacar que desde outubro de 2023, a Secretaria de Saúde do município, por meio da regulação, já atingiu o limite máximo da capacidade instalada para os pacientes maiores de dois anos, suspendendo novos encaminhamentos para essa faixa etária. Os Neonatos de Risco compreendem a faixa etária de 0 a 24 meses, onde o neonato apresenta critérios de risco, para o desenvolvimento de transtornos do neurodesenvolvimento. Para estes, os encaminhamentos continuam em curso, e a APAE acompanha 09 neonatos.

#### **Detalhamento da etapa de entrada:**

Considerou-se o diagnóstico ou o caso suspeito para deficiências, transtornos do neurodesenvolvimento ou distúrbios de aprendizagens.

- Em alguns casos, o encaminhamento pode ocorrer por meio de serviços educacionais que identificam dificuldades de aprendizado relacionadas à deficiência ou por demandas sociais que indicam a necessidade de acompanhamento especializado;
- Todos os encaminhamentos para avaliação na RCPD, sejam dos profissionais da saúde, bem-estar social ou dos profissionais da educação, são direcionados, obrigatoriamente, para a atenção primária. Este processo é fundamental para garantir o acesso a serviços

específicos, como terapias de reabilitação, suporte psicológico e assistência social;

- Atenção Primária preenche o instrumento de avaliação do neurodesenvolvimento, durante consulta médica ou de enfermagem, baseado em percepções clínicas e repostas do cuidador, e posteriormente encaminha para a regulação da Saúde;
- Na regulação o caso é avaliado, priorizado e direcionado ao serviço especializado mais adequado;
- A partir deste ponto, a pessoa com deficiência é referenciada aos serviços de atenção especializada, conforme o nível de complexidade exigido, através da Regulação.

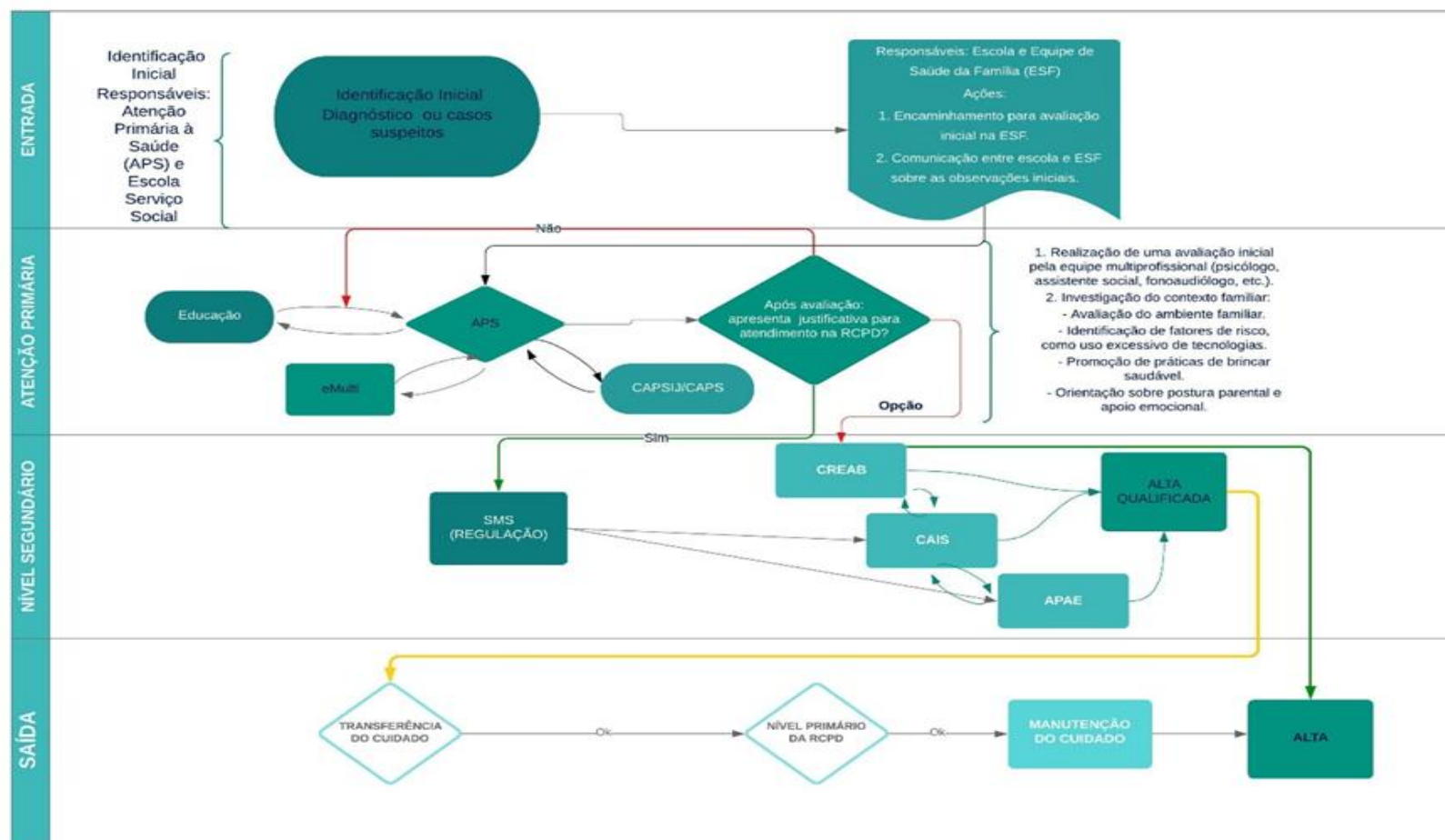
#### **Detalhamento da etapa de processo:**

- APAE e CAIS recebem os encaminhamentos correspondente ao perfil do serviço.
- Nos serviços especializados o usuário receberá reabilitação física e intelectual. A Rede oferece atendimento interdisciplinar, composto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogo, assistentes sociais, enfermeiros, médicos generalistas, pediatra, neuropediatra e outros profissionais. O objetivo é proporcionar suporte à reabilitação física e intelectual, promovendo o desenvolvimento de habilidades funcionais e autonomia.

#### **Detalhamento da etapa de saída:**

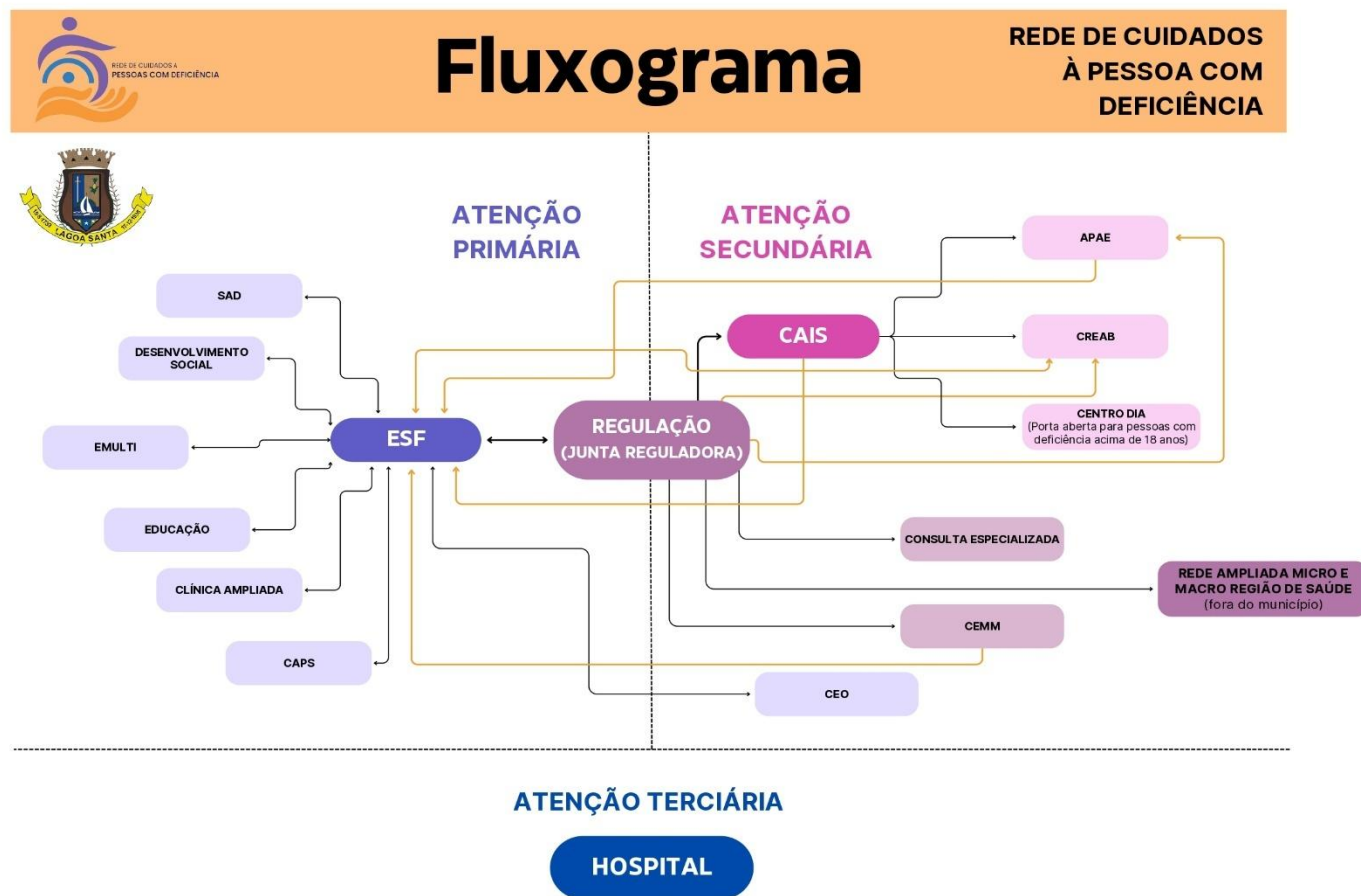
- Um dos grandes desafios da rede de cuidados em Lagoa Santa é a ausência de um processo de saída estruturada dos serviços de reabilitação. Sem critérios claros para a conclusão dos atendimentos, muitos usuários permanecem nos serviços por tempo indeterminado, enquanto outros aguardam por longo tempo, nas filas.

O atual cenário da RCPD no município de Lagoa Santa apresenta lacunas e necessidades de intervenções gerenciais para garantir o cuidado integrado e contínuo focado no bem-estar da PCD. Considerando todos estes elementos, foram elaborados dois novos instrumentos para nortear as ações dentro da rede, o novo desenho da distribuição dos serviços e o fluxograma de entrada (Apêndice F), os quais foram incorporados e publicados no Protocolo da Secretaria de Saúde (Figuras 11 e 12).



Fonte: a própria autora, 2024.

**Figura 11:** Melhorias no mapeamento Gerencial da RCPD do município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.



Fonte: a própria autora, 2024.

**Figura 12:** Serviços que compõem a RCPD, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

**Quadro 5.** Descrição dos passos, responsáveis e ações no fluxograma da RCPD, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| PASSO                                   | RESPONSÁVEIS                                           | AÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passo 1: Identificação Inicial          | Atenção Primária à Saúde (APS), Escola, Serviço Social | 1. Observação inicial por parte dos professores e profissionais de saúde da APS.<br>2. Registro dos sinais e sintomas apresentados pela criança/adolescente.                                                                                                                                                                               |
| Passo 2: Encaminhamento Inicial         | Escola e Equipes da atenção primaria à saúde.          | 1. Encaminhamento para avaliação inicial na ESF.<br>2. Comunicação entre escola e equipes da APS, sobre as observações iniciais.                                                                                                                                                                                                           |
| Passo 3: Avaliação e Acompanhamento     | Escola, ESF e Equipe Multiprofissional                 | 1. Realização de uma avaliação inicial pela equipe multiprofissional<br>2. Investigação do contexto familiar:<br><br>* Avaliação do ambiente familiar.<br>* Identificação de fatores de risco, como uso excessivo de tecnologias.<br>* Promoção de práticas de brincar saudável.<br>* Orientação sobre postura parental e apoio emocional. |
| Passo 4: Intervenções e Ações Conjuntas | Escola, ESF e Equipe Multiprofissional                 | 1. Implementação de intervenções educativas e terapêuticas.<br>2. Acompanhamento contínuo e regular da criança/adolescente.<br>3. Matriciamento:<br><br>* Apoio técnico e educacional para professores e profissionais da saúde.                                                                                                           |

|                                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                   | <p>*Capacitação contínua dos profissionais envolvidos.</p> <p>*Monitoramento das ações implementadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Passo 5: Reavaliação e Decisão sobre Encaminhamento     | Escola, ESF e Equipe Multiprofissional                            | <p>1. Reavaliação do progresso da criança/adolescente após intervenções.</p> <p>2. Decisão conjunta sobre a necessidade de encaminhamento para serviços especializados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Passo 6:<br>Encaminhamento para Serviços Especializados | ESF e equipe multiprofissional - via UBS                          | <p>1. Encaminhamento formal para serviços especializados se as intervenções anteriores não forem suficientes.</p> <p>2. Coordenação do acompanhamento contínuo entre serviços especializados e equipe de atenção primária.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Passo 7: Alta e Alta Qualificada                        | Equipe multiprofissional (CAIS, CREAB e APAE) e Junta Reguladora. | <p>1. Avaliação clínica e funcional final da PCD, com base no plano terapêutico inicial.</p> <p>2. Identificação das necessidades de continuidade de cuidados, como reabilitação, suporte domiciliar ou acompanhamento especializado.</p> <p>3. Discussão em equipe sobre o status da PCD e definição de critérios de alta (funcionalidade e autonomia adequadas, estabilização da condição).</p> <p>4. Alta Qualificada -Transferência do cuidado para os serviços de saúde do nível primário de atenção, quando o caso assim necessitar, até que possa receber alta para os cuidados do cuidador/autocuidado.</p> |

### **Detalhamento de particularidades do fluxo da RCPD de Lagos Santa:**

As regionais de saúde de Minas Gerais atuam como coordenadoras e integradoras dos serviços de saúde em suas respectivas áreas geográficas, organizando o fluxo de pacientes e serviços entre municípios. Belo Horizonte, como capital e centro de uma macrorregião de saúde, absorve grande parte dos atendimentos especializados e de alta complexidade pactuados com cidades vizinhas, como Lagoa Santa, que faz parte da microrregião de Vespasiano/Lagoa Santa (Figura 13).



**Figura 13.** Mapa das Regiões de Saúde da grande Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Esse processo de pactuação da referência é essencial para garantir a integralidade do cuidado, uma vez que os municípios menores frequentemente não dispõem de todos os serviços necessários para a demanda de sua população. Dessa forma, muitos atendimentos de média e alta complexidade que não podem ser realizados no município de Lagoa Santa são referenciados para Belo Horizonte e outras cidades da região, seguindo fluxos previamente estabelecidos entre as regionais de saúde.

São encaminhados ao CREAB de Belo Horizonte, os moradores de Lagoa Santa que possuem diversas demandas de saúde, especialmente aquelas que exigem cuidados mais especializados e que não podem ser oferecidos no município de origem. Contudo, estes indivíduos não foram inseridos na RCPD de Lagoa Santa e, da mesma maneira não deveriam perder o vínculo no município de residência, ademais deveriam ser acompanhados pela tanto pela APS quanto pelos serviços especializados da RCPD de Lagoa Santa.

O presente estudo evidenciou a situação precária do armazenamento de dados da RCPD, destacando que ao longo do tempo, muitos desses dados foram perdidos ou em alguns casos, sequer foram registrados. No mapeamento da rede de cuidados, observou-se uma falha no fluxo de informações e na continuidade do cuidado quando os munícipes de Lagoa Santa recebem alta hospitalar em hospitais da capital. Para incluir esta entrada e saída na regulação para o CREAB de BH é necessária uma articulação via Secretarias de Saúde Municipais e Estaduais, estabelecendo o fluxo correto para os casos específicos anteriormente mencionados.

Ademais, os pacientes são frequentemente direcionados ao CREAB de Belo Horizonte, sem a devida intervenção da regulação do município de origem. Esse descompasso gera uma lacuna significativa nos dados de saúde, comprometendo a integração dos serviços e a efetiva reinserção do paciente na rede de cuidados de seu município. Como resultado, o usuário muitas vezes não é devidamente identificado e acompanhado pelas equipes de saúde locais, o que prejudica a coordenação do cuidado e o planejamento de intervenções subsequentes.

Mapear o fluxo da RCPD de Lagoa Santa possibilitou apontar a fragmentação de dados e a ausência de comunicação entre diferentes níveis de atenção, que podem agravar a descontinuidade assistencial, especialmente em regiões que dependem de pactuações intermunicipais para a oferta de serviços especializados como é o caso do município que compõe o cenário desse estudo.

#### 4.1.3 Indicadores da RCPD

Até setembro de 2024, nenhum indicador foi mensurado ou acompanhado mensalmente/anualmente na RCPD do Município de Lagoa Santa, MG. Os dados de entrada, atendimento e saída são inseridos em uma planilha eletrônica do Excel® pelos funcionários administrativos da Secretaria de Saúde do município. A partir desta planilha foram elaborados os primeiros indicadores da RCPD, estabelecidos neste estudo, quais sejam: Taxa de acesso a RCPD, Número de casos não atendidos na RCPD, Tempo de espera para atendimento na RCPD e, Número de casos de alta qualificada da RCPD.

A planilha eletrônica vem sendo alimentada periodicamente desde 2022, embora tenham entradas ainda dos anos de 2009, 2014, 2017 e 2018 e, dispõe dos seguintes dados para os cálculos do estudo: sexo, idade, data da entrada na junta reguladora, data do primeiro atendimento/acolhimento, alta e justificativa de alta. Foram analisados 680 (100,0%) registros de indivíduos encaminhados à junta reguladora de Lagoa Santa, destes 492 (72,4%) são indivíduos do sexo masculino e 188 (27,6%) são do sexo feminino. A média de idade foi de 10 anos aproximadamente, variando entre 1 ano e 65 anos (DP=5,6).

Em relação ao acesso à RCPD de Lagoa Santa, destaca-se que não foi possível precisar a data de entrada na Rede de 48 (7,1%) indivíduos, uma vez que os mesmos foram inseridos via Centro de Especialidades Médicas e Multidisciplinares (CEMM) ou APAE. Destes, 9 indivíduos ainda não foram acolhidos na RCPD por não responderem à inúmeras tentativas de contato ou por mudança de domicílio para outro município. Os 39 restantes foram acolhidos na RCPD nos anos de 2023 e 2024.

Do total de registros analisados, 255 (37,5%) indivíduos ainda permanecem sem acolhimento na RCPD de Lagoa Santa (Tabela 1). Destes, 116 não foram acolhidos por não responderem à inúmeras tentativas de contato ou por não comparecerem aos agendamentos ou rejeitarem o atendimento ou foram devolvidos para a regulação encaminhar às Unidades Básicas de Saúde ou já estão em atendimento na APAE. Os demais 139 ainda aguardam o acolhimento na RCPD. A taxa de acesso à RCPD variou ao longo dos anos, considerando-se o período de 2020 a 2024, sendo a maior taxa de 64,5% em 2023 e a menor taxa de 11,6% em 2022 (Tabela 1). Não foram considerados os de 2009, 2014, 2017 e 2018 para o registro dos indicadores, uma vez que não retratam a realidade pois não havia registro sendo realizado de modo efetivo e regular, contudo estes casos se apresentam na planilha pois foram avaliados pela junta reguladora ou tiveram o primeiro atendimento a partir de 2020.

**Tabela 1.** Indicadores de taxa de acesso a RCPD e número de casos não atendidos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| VARIÁVEL                                         | ANOS  |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indivíduos sem acolhimento/atendimento na RCPD   | 8     | 7     | 8     | 127   | 102   |
| Indivíduos que realizaram o primeiro atendimento | 28    | 13    | 61    | 231   | 41    |
| Taxa de acesso a RCPD                            | 22,2% | 35,0% | 11,6% | 64,5% | 28,6% |

A média do tempo de espera para o acolhimento/primeiro atendimento na RCPD do indivíduos cadastrados na junta reguladora é de 278 dias aproximadamente, variando entre 0 e 2020 dias (DP=301,3). A média de dias do tempo de espera foi reduzindo ao longo dos anos no município do estudo (Tabela 2).

**Tabela 2.** Indicador do tempo de espera para o primeiro atendimento/acolhimento dos indivíduos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| ANOS | MÉDIA    | MÍNIMO | MÁXIMO | DESVIO PADRÃO |
|------|----------|--------|--------|---------------|
| 2020 | 980 dias | 860    | 1223   | 66            |
| 2021 | 624 dias | 495    | 800    | 105           |
| 2022 | 314 dias | 120    | 910    | 167           |
| 2023 | 177 dias | 0      | 1380   | 160           |
| 2024 | 97 dias  | 9      | 232    | 78            |

Até setembro de 2024 não há casos registrados de alta qualificada na RCPD de Lagoa Santa. Para a PCD, a alta qualificada envolve a transferência para o nível primário da rede de saúde, mas não significa que o cuidado esteja finalizado. O termo alta se refere, neste caso, com a garantir a continuidade do cuidado em outro nível, inclusive com um plano de cuidado estruturado e todas as informações e orientações para que o acompanhamento no nível primário seja eficaz.

#### **4.1.4 Oficina com os *Stakeholders***

Este estudo, em sua fase de pré-implementação, promoveu uma oficina com *stakeholders*, para identificar as lacunas, causas e efeitos da dificuldade de acesso da PCD à RCPS em Lagoa Santa e propor intervenções para mitigar os problemas detectados. No dia 02/09/2024 foi realizada uma oficina com a participação de dez *stakeholders*, sendo dois profissionais envolvidos nos processos de gestão; dois profissionais, de nível superior, integrantes da equipe multiprofissional e atuantes nos pontos de atenção da RCPD; dois profissionais da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (JRRCD); dois usuários da RCPD e dois familiares de PCD. Todos os *stakeholders* aceitaram participar da oficina e assinaram o TCLE.

Dentre os *stakeholders* participantes, nove eram do sexo feminino e um do sexo masculino, com média de idade de 39 anos. Do total, três eram enfermeiras, duas terapeutas ocupacional, duas fisioterapeutas, uma assistente social, uma auxiliar administrativa, e um professor. Nenhum dos profissionais possuíam especialização ou capacitação voltados ao cuidado à PCD e sete anos em média de vínculo na RCPD.

A oficina teve a duração de três horas e foi iniciada com a apresentação dos objetivos do estudo, o mapeamento atual dos processos gerenciais da RCPD e foram apresentadas as ferramentas de gestão que seriam utilizadas (diagrama de Ishikawa, *brainstorming* e matriz GUT) (Figura 14).



**Figura 14.** Apresentação do Fluxograma atual da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa e ferramentas de gestão a serem utilizadas na Oficina com os Stakeholders, Minas Gerais, Brasil, 2025.

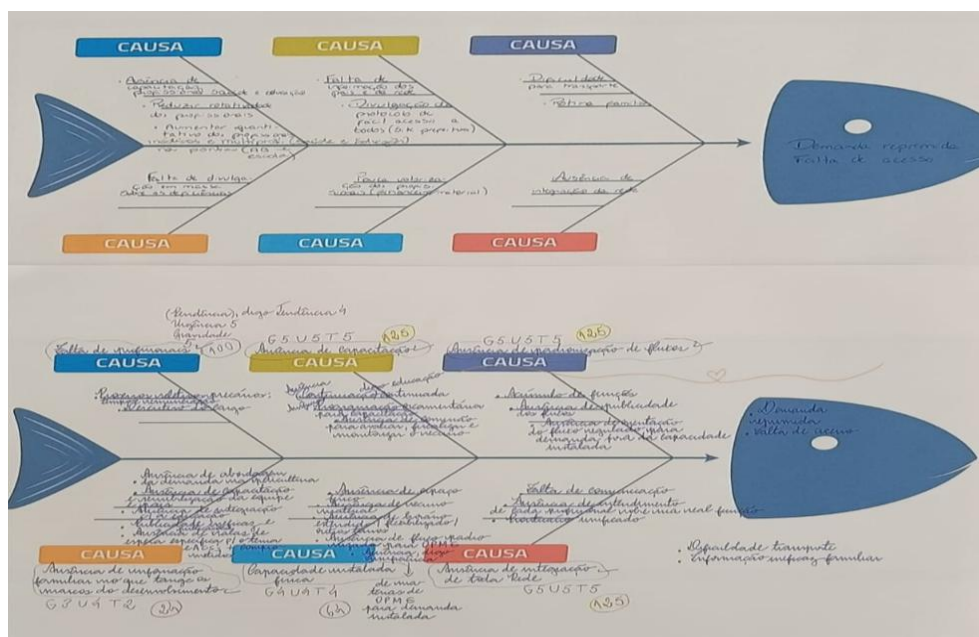
Os participantes foram divididos em dois subgrupos, de forma que cada grupo

contou com um profissional envolvido nos processos de gestão; um profissional, de nível superior, integrante da equipe multiprofissional e atuantes nos pontos de atenção da RCPD; um profissional da Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (JRRCD); um usuário da RCPD e um familiar de PCD. O intuito de dividi-los foi possibilitar um ambiente de discussão concentrado para a construção do Diagrama de Ishikawa, amplamente utilizado para identificar causas-raízes de problemas (Figura 15).



**Figura 15.** *Stakeholders* trabalhando em grupo na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

A primeira tarefa foi identificar as principais causas da falta de acesso da PCD aos serviços de saúde na RCPD. Os eixos analisados incluíram infraestrutura, gestão de recursos humanos, processos administrativos, comunicação entre as unidades da rede, e fatores externos como políticas públicas e financiamentos. Após ampla discussão, os grupos construíram os diagramas abaixo (Figura 14).



**Figura 16.** Diagramas de Ishikawa elaborados pelos grupos de Stakeholders na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Na sequência, os diagramas elaborados foram compilados em um único instrumento, com os problemas levantados e suas causas, os itens repetidos foram excluídos (Figura 17).



**Figura 17.** Diagrama de Ishikawa compilado pelos Stakeholders na Oficina, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

A segunda etapa da oficina envolveu uma dinâmica de *brainstorming*, na qual os participantes foram estimulados a propor soluções para os problemas identificados na fase anterior. As soluções sugeridas abrangiam:

- Necessidade de padronização dos processos de atendimento;
- Criação de estratégias para capacitar continuamente os profissionais e estimular a empatia para o cuidado prestado às pessoas com deficiência;
- Melhoria nos processos de comunicação entre os pontos de atenção;
- Necessidade de novos processos seletivos/concursos para contratação de profissionais;
- Educação em saúde para os cuidadores sobre o desenvolvimento infantil;
- Aumentar a capacidade dos serviços através do horário estendido;
- Adequar os ambientes para o atendimento infantil;
- Valorização profissional, plano de carreira e melhoria salarial para reduzir a rotatividade dos profissionais.

Na sequência, a Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) foi apresentada aos participantes para auxiliar na priorização das intervenções. Cada solução proposta foi avaliada de acordo com sua gravidade, o impacto que a questão causa, urgência que fala sobre a necessidade de intervenção imediata, e tendência que é a probabilidade de que a situação piore se não for resolvida (Quadro 6).

**Quadro 6.** Ações estabelecidas como prioritárias pelos *stakeholders* para a melhoria da RCPD do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                    | <b>G</b> | <b>U</b> | <b>T</b> | <b>RESULTADO</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| Estratégias para melhoria da comunicação/integração da rede: (implementar sistemas de informação, padronizar e divulgar os fluxos, treinamento em comunicação interdisciplinar | 5        | 5        | 5        | 125              |
| Capacitação dos profissionais com estímulo à empatia para o atendimento ao público citado.                                                                                     | 5        | 5        | 5        | 125              |
| Padronizar/publicar os fluxos da rede.                                                                                                                                         | 5        | 5        | 5        | 125              |
| Contratação de profissionais.                                                                                                                                                  | 5        | 5        | 4        | 100              |
| Adequação do espaço para o atendimento infantil (criar um ambiente lúdico, paredes coloridas, brinquedos, jogos e livros infantis).                                            | 4        | 4        | 4        | 64               |
| Implementação de horário estendido.                                                                                                                                            | 4        | 4        | 4        | 64               |
| Educação em saúde para familiares sobre o desenvolvimento infantil, a importância do estímulo, tempo de qualidade e o brincar livre de telas.                                  | 3        | 4        | 2        | 24               |

As intervenções que receberam as maiores pontuações pela aplicação da matriz GUT foram: comunicação e integração efetiva dos serviços da rede a capacitação e sensibilização dos profissionais, e a padronização dos fluxos de atendimento. As ações com 125 pontos foram implementadas neste estudo. Embora as ações de 64 a 100 pontos sejam prioritárias, a pesquisadora não possui governabilidade total em relação ao orçamento do município para a implementação destas melhorias e, por este motivo até o fim deste estudo, tais ações não foram passíveis de serem implementadas.

A oficina realizada foi fundamental para promover uma análise colaborativa e profunda dos desafios enfrentados pela RCPD. O envolvimento de profissionais, usuários e familiares garantiu uma visão multidimensional das questões relacionadas ao acesso e à qualidade do atendimento.

As principais intervenções priorizadas, refletem a necessidade urgente de ações

coordenadas e estruturadas e a oficina serviu como um ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias que visam, não apenas à resolução de problemas imediatos, mas também à criação de um ambiente mais inclusivo e eficiente para o atendimento à pessoa com deficiência.

#### 4.1.5 Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança

A avaliação da prontidão organizacional para mudanças foi realizada nos dias 7 e 8 de novembro de 2024, durante o Primeiro Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do município. Os profissionais membros da rede foram convocados para participar do seminário e, convidados, a contribuir com a pesquisa, respondendo a um formulário no *Google Forms*, com acesso via Qrcode (Figura 18).



Fonte: Autoria própria, 2025

**Figura 18.** QRcode para acessar o formulário POM, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

Responderam ao formulário do *google forms* com o instrumento POM 78 profissionais, dos quais 18 não concordaram em participar do estudo e um formulário encontrava-se incompleto, sendo excluído. Participaram 59 (100,0%) profissionais da RCPD de Lagoa Santa, dos quais a maior proporção foi de enfermeiros com 13 (22,0%)

profissionais e 13 (22,0%) fisioterapeutas, seguidos de 9 (15,3%) médicos, 5 (8,5%) psicólogos, 5 (8,5%) assistentes sociais, 4 (6,8%) fonoaudiólogo, 3 (5,1%) agentes comunitários de saúde, 2 (3,4%) terapeutas ocupacionais e os demais 1(1,7%) de cada profissão sendo agente administrativo, chefe do departamento de atenção primária, educador físico, gerente operacional de clínica médica e pedagoga.

Do total de respondentes, 41 (69,5%) eram do sexo feminino, com idade média de 39 anos, variando entre 24 e 65 anos (DP=7,89). Em relação às características profissionais, o tempo médio de formação dos participantes foi de 10 anos, variando entre 1 e 20 anos (DP=5,80) e o tempo médio de atuação na RCPD foi de 5 anos, variando de 1 a 24 anos (DP=5,49).

Na avaliação da POM, destacou-se, na dimensão necessidades de serviço, o item com a maior média, referente à melhoria da qualidade das sessões em grupo, no qual 45 participantes (76,3%) concordam totalmente.

Na dimensão **necessidades de treinamento**, 22 participantes (37,3%) concordaram totalmente que o serviço precisa de treinamento para aumentar a participação do cliente no tratamento, sendo esse o item com a maior média.

Em relação às pressões por mudanças, o item com a maior média revelou que 50 participantes (84,7%) concordam totalmente que as atuais pressões para a realização de mudanças no programa vêm dos clientes do programa de tratamento.

Com relação à dimensão **funcionários**, o item com maior média foi representado por 47 respondentes (79,7%) que concordam totalmente que é necessária uma equipe de suporte maior para atender às necessidades do serviço.

Na dimensão **treinamento**, o item com maior média reflete que 28 profissionais (47,5%) discordam totalmente da afirmação de que a prioridade nesse serviço é a formação de pessoal e a educação continuada.

Na dimensão **qualidade dos funcionários – crescimento**, o item com maior média demonstra que 30 profissionais (50,8%) concordam totalmente que conseguem se atualizar regularmente e melhorar suas habilidades.

Avaliando a dimensão **influência**, o item com maior média indica que 44 participantes (74,6%) frequentemente compartilham seus conhecimentos sobre novas ideias de atuação com outros funcionários.

Sobre **adaptabilidade**, a maior média foi expressa no item: “Você está disposto a

tentar novas ideias, mesmo que alguns funcionários sejam relutantes”, no qual 37 participantes (62,7%) concordam totalmente com a afirmativa.

**Atitudes no trabalho – esgotamento** apresentou sua maior média, com 33 profissionais (55,9%) concordando totalmente com o item: “Você se sente sobrecarregado pela burocracia.”

Na dimensão **satisfação**, a maior média reflete que 50 respondentes (84,7%) concordam totalmente com o item: “Você valoriza muito o trabalho que faz aqui.”

Em relação à **satisfação com o treinamento**, 34 participantes (57,6%) discordam totalmente de terem ficado satisfeitos com o treinamento oferecido nas oficinas disponíveis durante o último ano.

Na dimensão utilização do treinamento, a maior média indica que 21 participantes (35,6%) responderam "sempre" ao item: “Nos últimos anos, com que frequência você adotou (para o uso cotidiano) as novas intervenções ou técnicas aprendidas nos *workshops*?”

**Quadro 7.** Distribuição das respostas no instrumento Avaliação da Prontidão Organizacional para Mudança (n=59), Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| <b>AVALIAÇÃO POM (Prontidão Organizacional para Mudança)</b><br>Responda as perguntas, baseando-se no serviço em que trabalha e nos fatores que podem ser facilitadores ou barreiras para aquisição do conhecimento |                                    |                                      |                         |                         |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | <b>CONCORDA TOTALMENTE</b><br>n(%) | <b>CONCORDA PARCIALMENTE</b><br>n(%) | <b>INDECISO</b><br>n(%) | <b>DISCORDA</b><br>n(%) | <b>Média dos Itens</b> |
| <b>NECESSIDADES DO SERVIÇO</b> - Seu serviço precisa de orientação/suporte adicional para:                                                                                                                          |                                    |                                      |                         |                         |                        |
| 1- Avaliar as necessidades do cliente                                                                                                                                                                               | 46 (78,0%)                         | 7 (11,9%)                            | 1 (1,7%)                | 5 (8,5%)                | 4,59                   |
| 2- Utilizar serviços para atender às necessidades                                                                                                                                                                   | 39 (66,1%)                         | 16 (27,1%)                           | 1 (1,7%)                | 3 (5,1%)                | 4,54                   |
| 3- Aumentar a participação dos clientes no programa de tratamento                                                                                                                                                   | 40 (67,8%)                         | 7 (11,9%)                            | 8 (13,6%)               | 4 (6,8%)                | 4,40                   |
| 4- Medir o desempenho do cliente.                                                                                                                                                                                   | 40 (67,8%)                         | 6 (10,2%)                            | 1 (1,7%)                | 12 (20,3%)              | 4,25                   |
| 5- Melhorar a qualidade das sessões em grupo                                                                                                                                                                        | 45 (76,3%)                         | 8 (13,6%)                            | 3 (5,1%)                | 3 (5,1%)                | 4,61                   |
| 6- Melhorar a qualidade geral das orientações.                                                                                                                                                                      | 39 (66,1%)                         | 16 (27,1%)                           | 2 (3,4%)                | 2 (3,4%)                | 4,55                   |
| 7- Usar avaliações de clientes para orientar decisões clínicas e do programa de tratamento.                                                                                                                         | 38 (64,4%)                         | 7 (11,9%)                            | 10 (16,9%)              | 4 (6,8%)                | 4,33                   |
| 8- Usar as avaliações dos clientes para documentar a efetividade do programa de tratamento                                                                                                                          | 38 (64,4%)                         | 10 (16,9%)                           | 2 (3,4%)                | 9 (15,3%)               | 4,30                   |
| <b>NECESSIDADES DO TREINAMENTO</b> - Você precisa de mais treinamento para:                                                                                                                                         |                                    |                                      |                         |                         |                        |
| 9- Avaliar os problemas e as necessidades do cliente                                                                                                                                                                | 27 (45,8%)                         | 16 (27,1%)                           | 0 (0,0%)                | 16 (27,1%)              | 3,91                   |
| 10- Aumentar a participação do cliente no tratamento                                                                                                                                                                | 22 (37,3%)                         | 20 (33,9%)                           | 16 (27,1%)              | 1 (2,7%)                | 4,06                   |
| 11- Monitorar o progresso do cliente                                                                                                                                                                                | 23 (39,0%)                         | 10 (16,9%)                           | 8 (13,6%)               | 18 (30,5%)              | 3,64                   |

|                                                                                                         |            |            |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 12- Melhorar o relacionamento com os clientes                                                           | 19 (32,2%) | 15 (25,4%) | 0 (0,0%)   | 25 (42,4%) | 3,47 |
| 13- Ajudar o cliente a entender seus problemas e encontrar formas de resolvê-los                        | 33 (55,9%) | 11 (18,6%) | 0 (0,0%)   | 15 (25,4%) | 4,05 |
| 14- Melhorar o controle comportamental dos clientes                                                     | 19 (32,2%) | 25 (42,4%) | 2 (3,4%)   | 13 (22,0%) | 3,84 |
| 15- Melhorar a atenção dos clientes durante a atividades em grupo                                       | 21 (35,6%) | 14 (23,7%) | 9 (15,3%)  | 15 (25,4%) | 3,69 |
| 16- Utilizar avaliações computadorizadas com os clientes.                                               | 26 (44,1%) | 12 (20,3%) | 0 (0,0%)   | 21 (35,6%) | 3,72 |
| <b>PRESSÕES POR MUDANÇA - As atuais pressões para que sejam realizadas mudanças no programa vêm de:</b> |            |            |            |            |      |
| 17- Clientes no programa de tratamento                                                                  | 50 (84,7%) | 6 (10,2%)  | 2 (3,4%)   | 1 (1,7%)   | 4,77 |
| 18- Funcionários do serviço                                                                             | 30 (50,8%) | 18 (30,5%) | 5 (8,5%)   | 6 (10,2%)  | 4,22 |
| 19- Supervisores ou gerentes do serviço                                                                 | 39 (66,1%) | 6 (10,2%)  | 11 (18,6%) | 3 (5,1%)   | 4,37 |
| 20- Membros do governo (ou de agências)                                                                 | 20 (33,9%) | 9 (15,3%)  | 9 (15,3%)  | 21 (35,6%) | 3,47 |
| 21- Grupos de ação da comunidade                                                                        | 42 (71,2%) | 11 (18,6%) | 3 (5,1%)   | 3 (5,1%)   | 4,61 |
| 22- Agências de fomento ou supervisão à ciência                                                         | 18 (30,5%) | 15 (25,4%) | 10 (16,9%) | 16 (27,1%) | 3,59 |
| 23- Autoridades de licenciamento ou homologação                                                         | 16 (27,1%) | 10 (16,9%) | 18 (30,5%) | 15 (25,4%) | 3,45 |
| <b>FUNCIONÁRIOS</b>                                                                                     |            |            |            |            |      |
| 24- Existem profissionais suficientes aqui para atender às necessidades dos clientes                    | 9 (15,3%)  | 6 (10,2%)  | 0 (0,0%)   | 44 (74,6%) | 2,66 |
| 25- É necessária uma maior equipe de suporte para ajudar a atender às necessidades do serviço.          | 47 (79,7%) | 10 (16,9%) | 0 (0,0%)   | 2 (3,4%)   | 4,72 |

|                                                                                                                 |            |            |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 26- A grande rotatividade de funcionários é um problema para este serviço                                       | 43 (72,9%) | 3 (5,1%)   | 10 (16,9%) | 3 (5,1%)   | 4,45 |
| 27- Os profissionais aqui são capazes de passar tempo suficiente com os clientes                                | 3 (5,1%)   | 18 (30,5%) | 1 (1,7)    | 37 (62,7%) | 2,77 |
| 28. A equipe de suporte aqui tem as habilidades necessárias para realizar seu trabalho.                         | 21 (35,6%) | 21 (35,6%) | 2 (3,4%)   | 15 (25,4)  | 3,81 |
| 29. A equipe clínica aqui é bem treinada.                                                                       | 11 (18,6%) | 28 (47,5%) | 5 (8,5%)   | 15 (25,4%) | 3,59 |
| <b>TREINAMENTO</b>                                                                                              |            |            |            |            |      |
| 30- Formação de pessoal e educação continuada são prioridades neste serviço.                                    | 23 (39,0%) | 6 (10,2%)  | 2 (3,4%)   | 28 (47,5%) | 3,40 |
| 31. Você aprendeu novas habilidades ou técnicas em uma conferência profissional no ano passado.                 | 10 (16,9%) | 14 (23,7%) | 2 (3,4%)   | 33 (55,9%) | 3,01 |
| 32. O orçamento da instituição permite que os funcionários participem de conferências profissionais a cada ano. | 2 (3,4%)   | 9 (15,3%)  | 13 (22,0%) | 35 (59,3%) | 2,62 |
| 33- Este serviço sedia programas de treinamento regularmente.                                                   | 4 (6,8%)   | 8 (13,6%)  | 3 (5,1%)   | 44 (74,6%) | 2,52 |
| <b>QUALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - CRESCIMENTO</b>                                                                 |            |            |            |            |      |
| 34- Este serviço incentiva e financia o crescimento profissional                                                | 10 (16,9%) | 9 (15,3%)  | 6 (10,2%)  | 34 (57,6%) | 2,91 |
| 35- Você lê sobre novas técnicas e informações de tratamento a cada mês                                         | 26 (44,1%) | 26 (44,1%) | 1 (1,7%)   | 6 (10,2%)  | 4,22 |

|                                                                                                                              |            |            |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 36- Você tem oportunidades suficientes para manter suas habilidades de atendimento atualizadas todo mês                      | 9 (15,3%)  | 20 (33,9%) | 10 (16,9%) | 20 (33,9%) | 3,30 |
| 37- Você lê regularmente artigos de periódicos profissionais ou livros sobre intervenções baseadas em evidência científicas? | 27 (45,8%) | 16 (27,1%) | 3 (5,15)   | 13 (22,0%) | 3,96 |
| 38- Você consegue atualizar-se regularmente e melhorar suas habilidades.                                                     | 30 (50,8%) | 18 (30,5%) | 5 (8,5%)   | 6 (10,2%)  | 4,22 |
| <b>INFLUÊNCIA</b>                                                                                                            |            |            |            |            |      |
| 39- Você, frequentemente, compartilha seu conhecimento sobre novas ideias de atuação com outros funcionários.                | 44 (74,6%) | 11 (18,6%) | 1 (1,7%)   | 3 (5,1%)   | 4,62 |
| 40. A equipe, geralmente, considera você uma valiosa fonte de informação.                                                    | 29 (49,2%) | 21 (35,6%) | 7 (11,9%)  | 2 (3,4%)   | 4,30 |
| 41. Outros funcionários pedem seu conselho com frequência sobre os procedimentos do programa.                                | 32 (54,2%) | 15 (25,4%) | 10 (16,9%) | 2 (3,4%)   | 4,30 |
| 42- Outros funcionários geralmente perguntam sua opinião sobre orientação e problemas de tratamento                          | 33 (55,9%) | 12 (20,3%) | 4 (6,8%)   | 10 (16,9%) | 4,15 |
| 43- Você geralmente influencia nas decisões de outros funcionários                                                           | 34 (57,6%) | 12 (20,3%) | 7 (11,9%)  | 6 (10,2%)  | 4,25 |
| 44- Você é visto como um líder por outros funcionários                                                                       | 25 (42,4%) | 20 (33,9%) | 8 (13,6%)  | 6 (10,2%)  | 4,08 |
| <b>ADAPTABILIDADE</b>                                                                                                        |            |            |            |            |      |

|                                                                                               |            |            |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 45- Você está disposto a tentar novas ideias, mesmo que alguns funcionários sejam relutantes. | 37 (62,7%) | 19 (32,2%) | 1 (1,7%)   | 2 (3,4%)   | 4,55 |
| 46- Aprender e utilizar novos procedimentos é fácil para você                                 | 32 (54,2%) | 24 (40,7%) | 1 (1,7%)   | 2 (3,4%)   | 4,45 |
| 47- Você é algumas vezes muito cauteloso ou muito devagar para fazer mudanças                 | 3 (5,1%)   | 30 (50,8%) | 11 (18,6%) | 15 (25,4%) | 3,35 |
| 48- Você é capaz de se adaptar rapidamente quando precisa mudar o foco                        | 32 (54,2%) | 18 (30,5%) | 1 (1,7%)   | 8 (13,6%)  | 4,25 |
| <b>ATITUDES NO TRABALHO - ESGOTAMENTO</b>                                                     |            |            |            |            |      |
| 49- Você se sente sobrecarregado pela burocracia                                              | 33 (55,9%) | 22 (37,3%) | 1 (1,7%)   | 3 (5,1%)   | 4,44 |
| 50- Você se sente como se não fizesse diferença                                               | 6 (10,2%)  | 10 (16,9%) | 15 (25,4%) | 28 (47,5%) | 2,89 |
| 51- Você sente como se fosse um fardo vir ao trabalho                                         | 4 (6,8%)   | 7 (11,9%)  | 3 (5,1%)   | 45 (76,3%) | 2,49 |
| 52- Você se sente deprimido.                                                                  | 12 (20,3%) | 11 (18,6%) | 3 (5,1%)   | 33 (55,9%) | 3,03 |
| 53- Você se sente cansado                                                                     | 25 (42,4%) | 24 (40,7%) | 4 (6,8%)   | 6 (10,2%)  | 4,15 |
| 54- Você se sente desiludido e ressentido.                                                    | 6 (10,2%)  | 8 (13,6%)  | 13 (22,0%) | 32 (54,2%) | 2,79 |
| <b>SATISFAÇÃO</b>                                                                             |            |            |            |            |      |
| 55. Você está satisfeito com o seu trabalho atual.                                            | 32 (54,2%) | 23 (39,0%) | 3 (5,1%)   | 1 (1,7%)   | 4,45 |
| 56. Você gostaria de encontrar um emprego em outro lugar.                                     | 2 (3,4%)   | 22 (37,3%) | 9 (15,3%)  | 26 (44,1%) | 3,00 |
| 57. Você se sente valorizado (feliz) pelo trabalho que faz.                                   | 20 (33,9%) | 25 (42,4%) | 11 (18,6%) | 3 (5,1%)   | 4,05 |

|                                                                                                                                           |               |                   |                  |                        |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 58. Você gosta das pessoas com quem trabalha.                                                                                             | 31 (52,5%)    | 17 (28,8%)        | 1 (1,7%)         | 10 (16,9%)             | 4,16           |                    |
| 59. Você valoriza muito o trabalho que faz aqui.                                                                                          | 50 (84,7%)    | 7 (11,9%)         | 1 (1,7%)         | 1 (1,7%)               | 4,79           |                    |
| 60. Você tem orgulho de contar aos outros onde você trabalha.                                                                             | 36 (61,0%)    | 18 (30,5%)        | 4 (6,8%)         | 1 (1,7%)               | 4,50           |                    |
| SATISFAÇÃO COM O TREINAMENTO                                                                                                              |               |                   |                  |                        |                |                    |
| 61. Você ficou satisfeito com o treinamento oferecido nas oficinas disponíveis para você durante o último ano.                            | 15 (25,4%)    | 6 (10,2%)         | 4 (6,8%)         | 34 (57,6%)             | 3,03           |                    |
| 62. Você ficou satisfeito com as oportunidades de treinamento disponíveis para você durante o último ano.                                 | 8 (13,6%)     | 13 (22,0%)        | 2 (3,4%)         | 36 (61,6%)             | 2,88           |                    |
| UTILIZAÇÃO DO TREINAMENTO                                                                                                                 | Nunca<br>n(%) | Raramente<br>n(%) | Às vezes<br>n(%) | Frequentemente<br>n(%) | Sempre<br>n(%) | Média dos<br>itens |
| 63- Quando você comparece a “workshops” com que frequência aplica as novas intervenções ou técnicas aprendidas?                           | 9 (15,3%)     | 4 (6,8%)          | 8 (13,6%)        | 17 (28,8%)             | 21 (35,6%)     | 3,62               |
| 64- Seus clientes estão interessados ou dão uma boa resposta às novas ideias ou aos materiais de tratamento aprendidos?                   | 2 (3,4%)      | 11 (18,6%)        | 16 (27,1%)       | 14 (23,7%)             | 16 (27,1%)     | 3,52               |
| 65- Nos últimos anos, com que frequência você adotou (para o uso cotidiano) as novas intervenções ou técnicas aprendidas nos “workshops”? | 2 (3,4%)      | 1 (1,7%)          | 19 (32,2%)       | 16 (27,1%)             | 21 (35,6%)     | 3,89               |

A maior pontuação da POM ocorreu na dimensão Necessidade de Serviço, com 44 pontos, demonstrando que os profissionais possuem maior disposição para mudança neste aspecto. Por outro lado, a menor pontuação se deu na dimensão Treinamento, com 28 pontos, revelando menor prontidão relacionada aos treinamentos (Quadro 8).

**Quadro 8.** Pontuação da Prontidão Organizacional para mudança por dimensão do instrumento POM, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| <b>DIMENSÃO - POM</b>                    | <b>PONTUAÇÃO</b> |
|------------------------------------------|------------------|
| Necessidade de Serviço                   | 44 Pontos        |
| Necessidade de Treinamento               | 37 Pontos        |
| Pressões por Mudança                     | 40 Pontos        |
| Funcionários                             | 36 Pontos        |
| Treinamento                              | 28 Pontos        |
| Qualidade dos Funcionários – Crescimento | 37 Pontos        |
| Influência                               | 42 Pontos        |
| Adaptabilidade                           | 41 Pontos        |
| Atitudes no Trabalho – Esgotamento       | 32 Pontos        |
| Satisfação                               | 41 Pontos        |
| Satisfação com o treinamento             | 29 Pontos        |
| Utilização do treinamento                | 36 Pontos        |

#### **4.1.6 Plano de Melhorias**

A implementação da ciência na prática da RCPD em Lagoa Santa, Minas Gerais, será realizada seguindo o Plano de Melhoria da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, que foi desenvolvido utilizando as diretrizes do CFIR (Apêndice E).

A implementação do Plano de Melhoria da Qualidade da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa será estruturada com base nos cinco domínios do CFIR, a saber:

1. Características da Intervenção

2. Características Internas
3. Características Externas
4. Características dos Indivíduos Envolvidos
5. Processo de Implementação

Cabe destacar que ao final da construção do Plano de Melhorias, o documento foi disponibilizado e apresentado em uma oficina com os *Stakeholders* com o intuito de discutir a viabilidade e o desenvolvimento das ações prioritárias do Plano.

#### **4.1.7 Segunda oficina com os *Stakeholders***

A segunda oficina com os *stakeholders* ocorreu de modo presencial, realizada no dia 29 de janeiro de 2025, com duração de duas horas e trinta minutos e foi realizada em espaço reservado para esta finalidade no Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa. Estiveram presentes somente os *stakeholders* e a pesquisadora principal (Figura 19). Houve, inicialmente, o resgate dos resultados da primeira oficina, garantindo, possibilitando assim a continuidade entre as etapas. Seu objetivo principal foi a apresentação do Plano de Melhorias, com as ações prioritárias a serem implementadas e oportunizar a realização de sugestões e críticas ao Plano.



**Figura 19.** Apresentação do Plano de Melhorias da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa na Oficina com os Stakeholders, Minas Gerais, Brasil, 2025.

A segunda oficina foi realizada em cinco etapas, a saber: memória dos resultados da oficina anterior, apresentação do plano de melhorias, espaço para proposição de alterações pelos *stakeholders*, aprovação do plano de melhorias. Cabe destacar que os *stakeholders* não sugeriram melhorias ou alterações no Plano de Melhorias da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa.

#### 4.1.8 Melhorias Implementadas na RCPD de Lagoa Santa, Minas Gerais

Nos dias 7 e 8 de novembro de 2024, foi realizado o Primeiro Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência de Lagoa Santa/MG (Figura 20), promovido pela mestranda Amanda Rezende Silva de Oliveira no âmbito da pesquisa intitulada "Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG".



**Figura 20.** Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

O seminário contou com 251 participantes nos dois dias de evento, incluindo gestores e profissionais de saúde, que receberam certificados e foram convidados a participar ativamente do processo de transformação e aprimoramento da RCPD (Figura 21). Este evento teve cobertura e ampla divulgação pela Prefeitura de Lagoa Santa, sendo considerado de grande valor pelos gestores municipais, que reconheceram a relevância da iniciativa para fortalecer os cuidados às pessoas com deficiência no município.



**Figura 21.** Profissionais de saúde e gestores presentes no I Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

A mesa de abertura do seminário foi composta por autoridades locais, incluindo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a diretora da Atenção Primária. Essa composição ressaltou a importância da articulação entre diferentes atores e instâncias para garantir o sucesso da implementação das melhorias propostas. Fazendo jus à ciência da implementação, o seminário demonstrou a relevância de convidar os pares, convencer lideranças e buscar apoiadores para assegurar o respaldo político e gerencial necessário ao sucesso das ações.

Durante o evento, foi apresentado o novo fluxo da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), um dos produtos desenvolvidos na pesquisa, que busca reorganizar e integrar os serviços para torná-los mais acessíveis, acolhedores e funcionais. O seminário também teve como objetivo capacitar os profissionais de saúde e lideranças para o novo fluxo e fortalecer o pertencimento dos profissionais e usuários à rede, sensibilizando-os sobre o papel de cada um na consolidação de uma rede mais eficiente e inclusiva.

Com o intuito de promover uma identidade para a RCPD e mobilizar os envolvidos, a mestrandia propôs a criação de uma logomarca (Figura 22) que será utilizada no âmbito do município para todos os impressos, campanhas de saúde e demais processos necessários à RCPD de Lagoa Santa. Essa iniciativa visa sensibilizar, motivar e engajar profissionais e usuários, além de conferir maior visibilidade às ações desenvolvidas.



**Figura 22.** Identidade visual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

O seminário evidenciou a importância da mobilização de diferentes *stakeholders*, para o alinhamento estratégico e apoio gerencial e político para a implementação de melhorias na RCPD. Assim, a iniciativa representa um marco no fortalecimento da gestão e no aprimoramento dos serviços voltados às pessoas com deficiência em Lagoa Santa/MG.

Outras melhorias desenvolvidas no âmbito da pesquisa foram a elaboração, publicação e divulgação do novo Protocolo de Atendimento da Rede (Apêndice F) e a Campanha Brincar sem Telas (Apêndice G). A partir da observação do campo de pesquisa

e do diagnóstico da rede, percebeu-se a necessidade de aprimoramento dos processos de encaminhamento e atendimento da rede de cuidados.

Em Lagoa Santa, MG, a análise dos fluxos e encaminhamentos revelou uma quantidade expressiva de casos de crianças escolares referenciadas à RCPD, sem dados clínicos pertinentes, sem a devida avaliação do contexto familiar e sem critérios estabelecidos.

A cultura de encaminhamento sem critérios claros levou a diversas consequências negativas, como a sobrecarga dos serviços especializados da RCPD, diagnósticos e medicalizações equivocadas, estigmatização precoce de crianças, com impacto em seu desenvolvimento futuro, aumento dos custos para o sistema de saúde e educação, e falta de ações preventivas e educativas para os pais e cuidadores.

Nesse contexto, tornou-se evidente a necessidade de intervenções gerenciais para reverter esse cenário, garantindo que as crianças recebam os encaminhamentos adequados e que suas necessidades sejam avaliadas de forma holística. Diante dessa necessidade, a autora, em busca de conhecimentos teóricos e práticos, participou da seleção e foi selecionada para o curso "Atualizações em Competências Clínicas para o Cuidado de Enfermagem na Primeira Infância", uma parceria entre o Coren-MG e a Universidade Federal de Minas Gerais (Anexo 4). As atualizações, conhecimentos e materiais adquiridos nas aulas do curso de 176 horas, serviram de base para a formulação do protocolo de atendimento, direcionando ações e condutas clínicas pertinentes para implementações eficazes no atendimento da rede.

A campanha "Brincar sem Telas" surge como uma resposta, buscando conscientizar as famílias e profissionais sobre a importância de avaliar o tempo excessivo nas telas, promover a interação familiar e ressaltar a importância do brincar no desenvolvimento infantil.

## **5. DISCUSSÃO**

Os achados do estudo em questão apontaram para uma RCPD pouco estruturada em termos de processos gerenciais, necessitando de aprimoramentos nos fluxos e, especialmente, na qualificação dos profissionais que atuam no primeiro atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de garantir o acesso equitativo à PCD. Esses desafios,

que foram elencados de forma contundente entre os *Stakeholders* incluem a ausência de fluxos padronizados e a comunicação precária entre os diferentes níveis de atenção.

A dissertação desenvolvida por este estudo evidencia diversos problemas estruturais na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) em Lagoa Santa, como a desorganização nos fluxos assistenciais, deficiências na estrutura física, lacunas na capacitação profissional e limitações no acesso aos serviços. Esses desafios prejudicam a oferta de cuidados integrais e equitativos, refletindo uma realidade presente em outros contextos nacionais e internacionais.

No Brasil, encontramos situações semelhantes no Amazonas, onde barreiras geográficas e a fragmentação dos serviços de saúde dificultam a efetividade da rede, especialmente em regiões remotas<sup>(34)</sup>. Estudos internacionais apontam que essas dificuldades são comuns em países de renda baixa e média, em Bangladesh, fatores como a distribuição inadequada de serviços, a insuficiência de profissionais especializados e a dependência de financiamento privado comprometem o acesso aos cuidados de reabilitação<sup>(34)</sup>. De forma parecida, em Madagascar, identificou-se barreiras como a escassez de profissionais capacitados e a desconexão entre cuidados agudos e a reabilitação comunitária, enfatizando a necessidade de estratégias robustas para a coordenação dos serviços<sup>(35)</sup>.

No contexto da América Latina, um estudo realizado no México demonstrou que, apesar de legislações favoráveis, a falta de integração na rede de reabilitação e a ausência de dados sobre necessidades não atendidas reduzem a efetividade do sistema. Contudo, iniciativas como a criação de pequenos centros de reabilitação de primeiro nível ampliaram a capacidade de atendimento em 60%, sugerindo que intervenções direcionadas podem mitigar esses desafios<sup>(36)</sup>.

Em outras regiões do mundo, desafios equivalentes são enfrentados, ao analisar o contexto árabe, identifica-se transporte inadequado, custos elevados e o estigma social como fatores que dificultam o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde<sup>(37)</sup>. Continuando o entendimento sobre assunto em âmbito internacional, no Nepal, a ausência de reabilitação integrada e de capacitação especializada agrava a assistência, especialmente em áreas rurais. Mesmo com os avanços de um plano de 10 anos para reabilitação, o país ainda carece de infraestrutura essencial e equipamentos de apoio<sup>(9)</sup>.

Nos Estados Unidos, apesar de avanços legislativos como a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA), persistem lacunas no atendimento, o uso insuficiente de equipamentos acessíveis em unidades de saúde, barreiras na comunicação e a ausência de equipamentos adaptados como entraves críticos<sup>(38-39)</sup>. De igual maneira, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, a organização dos serviços para pessoas com deficiência intelectual ainda é deficiente, com falta de integração entre equipes de saúde e cuidados comunitários. Esses estudos indicam que modelos centrados na comunidade podem reduzir barreiras estruturais e promover maior acessibilidade<sup>(40)</sup>.

Por outro lado, iniciativas bem-sucedidas mostram possibilidades de superação desses desafios, como o sistema Kaiser Permanente, na Califórnia, que implementou redes integradas e centradas no paciente, eliminando barreiras e promovendo acessibilidade universal. Essas experiências sugerem que a reorganização dos serviços e a coordenação entre diferentes níveis de cuidado podem ser estratégias eficazes para superar os desafios enfrentados pela RCPD em Lagoa Santa, contribuindo para um atendimento mais equitativo e inclusivo<sup>(41)</sup>.

Em Serra Leoa desafios como transporte precário, custos elevados e falta de equipamentos para reabilitação, ressaltam a necessidade de adotar modelos de baixo custo que ampliem o acesso aos serviços. Condições afins são observadas no Brasil onde 70% dos Centros de Especialidades Odontológicas carecem de acessibilidade física adequada e não possuem protocolos claros para priorizar casos mais complexos, comprometendo a qualidade do atendimento<sup>(42-43)</sup>.

A ausência de dados consistentes e de planejamento estratégico é destacada como uma barreira ao desenvolvimento de redes sustentáveis, como apontado no relatório da ONU. Essa lacuna compromete a integração entre setores e níveis de cuidado, elemento considerado essencial para superar desafios. Cenário que reforça a necessidade de políticas públicas baseadas em dados e maior investimento de recursos públicos<sup>(34)</sup>.

Em contraste ao cenário encontrado no município de Lagoa Santa em Minas Gerais, Brasil, o modelo *Hub & Spoke*, utilizado pelo *Seraphic Institute* na Itália, demonstrou sucesso ao integrar assistência multidisciplinar e regionalizar os cuidados, promovendo maior acessibilidade para pessoas com deficiência<sup>(34-35,8)</sup>. Contudo, as barreiras financeiras, físicas e atitudinais podem ser percebidas no município que compõe o cenário do estudo e, também afetam o acesso de pessoas com deficiência à serviços de saúde em Gana, país em

desenvolvimento como o Brasil, dificultando o percurso no sistema e o alcance de uma assistência efetiva<sup>(44-46)</sup>.

Além disso, os desafios locais da RCPD em Lagoa Santa, como falta de integração da rede e capacitação, estão alinhados com esses cenários. No Reino Unido, os ajustes estruturais e a melhoria da comunicação são considerados fundamentais para um atendimento que reconheça as especificidades dessa população, enquanto *frameworks* colaborativos têm sido eficazes na coordenação de serviços de reabilitação em comunidades<sup>(44-46)</sup>.

A carência de acessibilidade estrutural e capacitação adequada prejudica diretamente a qualidade do atendimento, perpetuando desigualdades, como observado em Lagoa Santa e em outros contextos do Brasil. Nas Unidades Básicas de Saúde, práticas inadequadas mantêm um ciclo de iniquidades históricas, cenário também destacado em pesquisas sobre a necessidade de tecnologias assistivas e treinamentos adequados para profissionais. Contudo, abordagens sem foco no usuário podem criar novas barreiras ao invés de solucioná-las<sup>(47)</sup>.

Adicionalmente, o estigma institucional persiste como um fator limitante em políticas globais, voltadas especialmente para crianças com atrasos de desenvolvimento. Assim, estratégias como monitoramento contínuo, empoderamento de cuidadores e capacitação são sugeridas como formas de superar essas barreiras. Em Minas Gerais, os usuários da RCPD relatam tempos de espera elevados e ausência de serviços nas proximidades de suas residências, reforçando a necessidade de ampliar a cobertura e otimizar os processos para melhorar o atendimento<sup>(48-49)</sup>.

Na Europa, o mesmo estigma institucional associado à falta de educação sobre deficiência é reconhecido como uma barreira importante, exigindo políticas públicas voltadas ao treinamento contínuo e à sensibilização para garantir a inclusão e promover mudanças estruturais mais amplas<sup>(50)</sup>.

Conforme estudo sobre o acesso da PCD na APS, a qualificação dos profissionais de saúde e a desarticulação da rede são, de fato, os entraves mais críticos para o acolhimento das pessoas com deficiência dificultando o estabelecimento de vínculos de confiança e acesso aos serviços especializados no âmbito do SUS<sup>(51)</sup>. A inclusão e o cuidado integral de pessoas com deficiência têm sido um desafio persistente no contexto das redes de assistência social e de saúde, especialmente em localidades com carências estruturais e organizacionais,

como observado na RCPD em Lagoa Santa, Minas Gerais. A falta de acesso adequado aos serviços e a demanda reprimida por cuidados são fatores que têm impactado diretamente a qualidade de vida dessa população e, tais fatores têm sido mencionados na literatura como desafios estruturais/gerenciais que precisam ser enfrentados<sup>(51)</sup>.

Por meio do diagnóstico situacional da RCPD de Lagoa Santa foi possível perceber a desarticulação entre as esferas envolvidas, o que culmina na desassistência, na longa espera para atendimentos e nos encaminhamentos equivocados, comprometendo o acesso à integralidade do cuidado. Contudo, sabe-se que o sucesso de uma rede de cuidados depende de uma articulação eficiente entre as partes envolvidas, bem como da implementação de fluxos padronizados que facilitem a gestão de casos e promovam uma comunicação eficaz entre os serviços da rede<sup>(6)</sup>. Esses elementos são essenciais para a consolidação de uma rede coesa e integrada, onde a capacitação e a comunicação se tornam ferramentas centrais para a melhoria da qualidade do atendimento, adaptados às realidades regionais, garantindo que as intervenções sejam mais eficazes e sustentáveis<sup>(51)</sup>.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a APS é a porta de entrada para todos os casos de suspeita ou confirmação PCD no âmbito do SUS, sendo responsável pela investigação inicial, intervenção adequada e inclusão na RCPD<sup>(5)</sup>. Deste modo, a literatura destaca a importância da qualificação contínua dos profissionais de saúde, especialmente para o acolhimento e reconhecimento dos casos, reiterando a necessidade de intervenções educacionais permanentes para aprimorar a adesão dos profissionais de saúde às práticas recomendadas<sup>(53)</sup>.

A falta de capacitação, a escassez de profissionais, a alta carga de trabalho e a visão equivocada de que a APS não integra os cuidados voltados a esse público são fatores que influenciam essa ausência de intervenção no nível primário<sup>(51)</sup>. A formação contínua dos profissionais é crucial para otimizar o uso dos recursos disponíveis, especialmente em contextos de escassez de recursos, como é o caso da rede de saúde local<sup>(10)</sup>. Ainda nesta perspectiva, a ausência de protocolos claros resulta em duplicação de esforços e na perda de continuidade do cuidado, o que pode ser mitigado com a implementação de um sistema de fluxos unificados<sup>(10)</sup>.

Além disso, a fragmentação da rede, identificada como um dos principais desafios, reflete a falta de uma integração eficaz entre os serviços. Uma rede verdadeiramente integrada deve ser caracterizada por uma coordenação eficiente entre os diferentes níveis de

complexidade, com trocas constantes de informações e planos de cuidados centrados nas necessidades dos pacientes<sup>(54)</sup>. A ausência dessa integração não apenas compromete a qualidade do atendimento, mas também dificulta o uso eficiente dos recursos, resultando em uma assistência desconexa e ineficaz.

Neste sentido, a avaliação da Rede de cuidados, contemplando as percepções de gestores, profissionais de saúde e usuários, emerge como uma abordagem fundamental para a identificação de áreas de melhoria. A avaliação holística dos serviços de saúde, que considere tanto os aspectos físicos quanto as construções sociopsicológicas dos envolvidos, contribui para a reformulação das práticas e a melhoria da qualidade da assistência <sup>(53,55-56)</sup>.

Em termos teóricos, as discussões levantadas durante a oficina em Lagoa Santa podem ser interpretadas à luz do modelo de Redes de Atenção à Saúde (RAS). Uma rede integrada requer fluxos de comunicação eficientes entre os níveis de complexidade e foco na continuidade do cuidado, princípios que, atualmente, não são observados na rede local<sup>(6)</sup>. Para restaurar o equilíbrio desse sistema, as intervenções propostas visam fortalecer a capacitação, padronização e integração dos serviços, alinhando-se a modelos teóricos de implementação, como a tradução do conhecimento e o *framework* CFIR, que oferecem uma estrutura robusta para abordar as complexidades da organização dos serviços de saúde<sup>(57-58)</sup>.

Assim, a oficina realizada em Lagoa Santa teve sucesso em identificar as causas dos problemas e propor soluções práticas para os desafios da RCPD, evidenciando a importância de uma gestão coordenada e integrada para promover um atendimento mais eficiente, equitativo e inclusivo. Ademais, associados aos achados da primeira oficina, as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência evidenciadas pela revisão de escopo, foi possível elaborar um Plano de Melhorias que implementa as evidências científicas na prática profissional voltada à gestão da RCPD, podendo gerar impactos significativos que serão avaliados à posteriori. Além disso, a capacitação realizada durante o seminário revelou impactos positivos na prontidão organizacional para mudanças, indicando que ações educativas são fundamentais para a sustentabilidade das melhorias implementadas.

Conforme observado, a integração dos serviços é um recurso obrigatório para melhorar a acessibilidade e a qualidade do atendimento, a importância de fluxos bem definidos e de uma abordagem centrada no paciente. Em Lagoa Santa, avanços foram registrados com o mapeamento gerencial e a reorganização dos fluxos da RCPD, o que

demonstra o potencial de iniciativas locais<sup>(41)</sup>. No entanto, a educação contínua de profissionais de saúde, com foco em práticas inclusivas e culturalmente competentes, foi identificada componente de transformação. Além disso, a capacitação dos profissionais de saúde para promover um atendimento humanizado e centrado no paciente<sup>(59,39)</sup>.

Já o financiamento sustentável é imprescindível para garantir a expansão e a continuidade dos serviços de reabilitação, deste modo, o planejamento financeiro bem estruturado é indispensável para assegurar a equidade no atendimento. Em contrapartida a dependência de recursos privados compromete a eficiência do sistema<sup>(42-43)</sup>. A redução de filas de espera é outro ponto-chave, com estratégias de triagem ativa e modificações no modelo de atendimento, sendo adaptáveis a outros contextos<sup>(8,60)</sup>.

Por fim, o engajamento da pessoa, família e comunidade, assegura que políticas sejam mais inclusivas e adequadas às necessidades da população. Pressiona e estimula a criação de políticas inclusivas que abranjam não apenas as necessidades de saúde, mas também as sociais e educacionais. A implementação dessas recomendações pode ser determinante para otimizar os serviços da RCPD em Lagoa Santa, promovendo um atendimento mais eficiente e equitativo para pessoas com deficiência<sup>(50,36,56,44)</sup>.

Apesar das diversas melhorias, fundamentadas em evidência científica que foram implementadas na RCPD de Lagoa Santa, ainda persistem desafios, especialmente relacionados à alocação de recursos humanos e financeiros. A ausência de fluxos organizados e a fragmentação dos serviços dificultavam a integralidade do cuidado, comprometendo a reabilitação e inclusão social das pessoas com deficiência. Como apontado no estudo, superar tais barreiras depende de um esforço conjunto entre gestores, profissionais e sociedade.

Cabe destacar que esse estudo, além de responder às necessidades locais, alinha-se aos ODS, como a redução das desigualdades e a promoção da saúde e bem-estar, demonstrando que a implementação de melhorias na RCPD de Lagoa Santa é urgente e viável, desde que sustentada por estratégias inovadoras, monitoramento contínuo e colaboração efetiva entre todos os atores envolvidos. Nesse sentido, o monitoramento contínuo de todo o processo possibilitará medir a eficácia das políticas públicas e ajustar intervenções.

Os indicadores criados e mensurados para esse estudo representam ferramentas indispensáveis para monitorar e avaliar a eficácia do Plano de Melhorias. Esses dados

ajudam a verificar se as intervenções estão promovendo impactos reais no acesso aos serviços e na qualidade do atendimento, como preconizam as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência.

Este estudo possui limitações quanto à avaliação do impacto das melhorias realizadas na RCPD de Lagoa Santa, Minas Gerais, contudo os achados foram contundentes para afirmar os aspectos positivos que as melhorias trouxeram, diminuindo as lacunas nos processos gerenciais e lançando luz sobre um grupo da população vulnerável e constantemente à margem do sistema de saúde. Sugere-se a realização de novos estudos que possibilitem avaliar os impactos e efetividade das ações de melhorias realizadas na Rede.

## **6. CONCLUSÃO**

O estudo realizado evidenciou que a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) de Lagoa Santa/MG enfrentava desafios estruturais e gerenciais que dificultavam a efetiva implementação dos achados científicos na prática assistencial. A ausência de fluxos bem definidos, a fragmentação dos serviços, a carência de capacitação profissional e a falta de articulação entre os pontos de atenção foram alguns dos principais entraves identificados na etapa de pré-implementação.

A partir da aplicação dos princípios da Ciência da Implementação e da Tradução do Conhecimento, foi possível desenvolver e iniciar a implementação de um plano de melhorias voltado para a otimização dos processos gerenciais da RCPD. A integração entre diferentes atores – gestores, profissionais de saúde, usuários e familiares – proporcionou uma abordagem colaborativa e participativa, permitindo que as soluções propostas fossem contextualizadas às necessidades locais e exequíveis dentro da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir da elaboração do Plano de Melhorias, foram implementados melhores práticas embasadas em evidência científica, como novos fluxos gerenciais da RCPD, realizada a capacitação com os profissionais de saúde, elaborado e aplicado o protocolo de atendimento, elaborada a campanha “Brincar sem telas” e criada uma identidade visual para a RCPD do município de Lagoa Santa, Minas Gerais. Apesar dos desafios inerentes à implementação de mudanças em sistemas de saúde, é possível transpor barreiras estruturais e organizacionais quando se empregam metodologias baseadas em evidências e alinhadas à realidade prática. Entretanto, cabe ressaltar que este trabalho teve como escopo a

identificação dos desafios, o mapeamento das fragilidades e a proposição de soluções viáveis, cabendo às futuras ações garantir a consolidação e a sustentabilidade das melhorias sugeridas e as já implementadas.

O caráter profissional do Mestrado em Enfermagem Assistencial possibilitou aproximação direta entre a academia e a prática, favorecendo uma intervenção em tempo real na gestão dos serviços e promovendo benefícios concretos para os usuários do SUS, neste caso, as pessoas com deficiência e seus familiares. Dessa forma, este estudo reafirma a importância da ciência da implementação como ferramenta essencial para a qualificação da assistência, o fortalecimento das políticas públicas e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil.

A etapa de avaliação, no que tange especialmente à primeira avaliação de indicadores após a implementação das melhorias é essencial para o acompanhamento e refinamento das ações prioritárias do Plano de Melhorias da RCPD e deverá ser realizada de forma sistematizada e periodizada, considerando as complexidades inerentes à implementação de intervenções organizacionais e à avaliação de seus impactos.

Nesse sentido, destaca-se que há a intenção clara de prosseguir com as avaliações e oficinas após o período formal do curso, garantindo o acompanhamento longitudinal das intervenções propostas. Essa perspectiva evidencia o compromisso com a sustentabilidade das ações e com a consolidação de uma RCPD mais efetiva, integrada e inclusiva, alinhada às necessidades da população atendida. Além disso, o seguimento do Plano de Melhorias poderá ser enriquecido por futuras colaborações acadêmicas e institucionais, consolidando as bases para o aprimoramento contínuo da RCPD em Lagoa Santa.

## **7. PRODUTO**

O produto dessa dissertação é o Plano de Melhoria da Qualidade da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais.

São subprodutos desta dissertação:

1. Construção do diagnóstico situacional da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - Relatório Técnico apresentado ao Secretário de Saúde e aos Diretores de Atenção Primária e Regulação (Apêndice H).
2. Elaboração do fluxograma, publicado em nota técnica em 2024 (Apêndice F).
3. Protocolo de Atendimento da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência do

Município de Lagoa Santa: Transtornos do Neurodesenvolvimento, publicado no website oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, no link <https://www.lagoasanta.mg.gov.br/downloads/file/32138-anexo-2-protocolo-rcpd-rede-de-cuidados-a-pessoa-com-deficiencia> (Anexo 3).

4. Seminário para capacitação dos profissionais sobre a rede implantada através do fluxograma elaborado em etapa anterior (Anexo 5).
5. Campanha Brincar sem Telas, publicada nas mídias sociais da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, no link <https://www.instagram.com/p/DCR9U0VsUG5/?igsh=eGE1MXg2MHg3cmll> (Anexo 6).

O diagnóstico situacional da Rede permite propor soluções para os desafios enfrentados. O novo fluxograma aprimora processos administrativos e organizacionais, representando inovação técnica. O plano de melhorias propõe mudanças baseadas em evidências para otimização gerencial. O protocolo publicado contribui para a produção técnica em enfermagem e saúde pública. O seminário com os profissionais reflete a formação continuada, promovendo capacitação e qualificação. A campanha “Brincar sem telas” exemplifica a transferência de conhecimento para a sociedade, ampliando o alcance da pesquisa. Este projeto possui alcance municipal e pode atingir níveis regionais e nacionais, com melhorias implementadas como referência para uma RCPD interligada, garantindo acesso universal aos PCDs e seus familiares.

## REFERÊNCIAS

1. Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos [Internet]. Brasília: Nações Unidas; 1948 [acesso em 2023 Abr 20]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>.
2. Brasil. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. [Internet]. Brasília, DF: Presidente da República; 2023 [acesso em 2023 Mai 05]. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm).
3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das regras nas redes do Sistema Único de Saúde [Internet]. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2017 [acesso em 2023 Out 10]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003\\_03\\_10\\_2017ARQUIVO.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017ARQUIVO.html).
4. Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial da Saúde 2008. Cuidados de saúde primários: agora mais que nunca [Internet]. Lisboa: Ministério da Saúde; 2008 [acesso em 2024 Out 05]. Disponível em: [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43949/9789244563731\\_por.pdf](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43949/9789244563731_por.pdf).
5. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 22 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica [Internet]. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2017 [acesso em 2024 Out 05]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436\\_22\\_09\\_2017.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html).
6. Mendes EV. Redes de saúde. 2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011. 549 p. [Internet]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes\\_de\\_atencao\\_saude.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_de_atencao_saude.pdf).
7. Machado WC, Pereira JS, Schoeller SD, Júlio LC, Martins MM, Figueiredo NM. Integralidade na rede de cuidados da pessoa com deficiência. Texto contexto - enferm. [Internet]. 2018 [acesso em 2024 Out 05]; 27(3): e4480016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-07072018004480016>.
8. Elisei S, Camanni G, Di Maolo F. Improving health care accessibility for people with complex disabilities. Psychiatr Danub. [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 11]; 33(Suppl 11): 96-99. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862900/>.
9. Dhakal R, Groves CC. Rehabilitation in Nepal. Phys Med Rehabil Clin N Am. [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 10]; 30(4): 787-794. Available from: 10.1016/j.pmr.2019.07.004.

10. Mota PH. Implementação da Rede de Cuidados para pessoas com deficiência: contexto, valores e níveis de cuidados [Tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/T.6.2020.tde-11032020-132928>.
11. Santos NG. Desigualdade e pobreza: análise da condição de vida da pessoa com deficiência a partir dos indicadores sociais brasileiros [Tese]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2020. Disponível em: <https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13404>.
12. Minas Gerais. Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.272, de 24 de outubro de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência SUS-MG e dá outras providências [Internet]. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; 2012 [acesso em 2023 Mar 10]. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/774193850/Deliberacao-1272-2012-ESTABELECE-A-REDE-DE-MG-1>.
13. CONASS. Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais 2020-2023 [Internet]. Brasília (DF): Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 2020 [acesso em 2023 Mar 10]. Disponível em: <https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2021/04/08-02-Plano-Estadual-de-Saude-de-Minas-Gerais-2020-2023.pdf>
14. Lagoa Santa. Decreto nº 4.879, de 13 de abril de 2023. Implementa a Política de Atenção à Pessoa com Deficiência no âmbito do Município de Lagoa Santa [Internet]. Lagoa Santa: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa; 2023 [acesso em 2023 Set 07]. Disponível em: <https://www.lagoasanta.mg.gov.br/downloads/category/717-decretos-2023?download=26933:decreto-n-4-879-de-13-de-abril-de-2023&start=220>.
15. Castro AM. Rede formal, rede invisível e rede existencial: encontros cartográficos nas múltiplas redes de cuidado às pessoas com deficiência em uma capital brasileira [Dissertação]. Campo Grande: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3876>.
16. Martins CF, Albuquerque MS, Oliveira RS, Miranda GM. Análise da Política de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência em uma capital da Região Nordeste do Brasil . Physis [Internet]. 2023 [citado em 2024 Dez 03]; 33: e33062. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333062>.
17. Merhy EE. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: Merhy EE, Onocko R, editors. Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: Editora Hucitec; 1997. p. 71-112. Disponível em: [https://digitalrepository.unm.edu/lasm\\_pt/145/](https://digitalrepository.unm.edu/lasm_pt/145/).

18. Issa FM. Acesso à rede de cuidados em saúde da pessoa com deficiência em um município de fronteira [Dissertação]. Foz do Iguaçu: Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2022. Disponível em: <https://tede.unioeste.br/handle/tede/6384>.
19. Figaro FB. Mulheres em cadeira de rodas e a relação com a deficiência adquirida: problemas, superações e possibilidades [Dissertação]. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo; 2022. Disponível em: <http://tede.metodista.br/jspui/handle/tede/2265>.
20. Carneiro JD. Rede de cuidados à pessoa com deficiência: o direito à saúde bucal e a implementação da assistência odontológica especializada [Tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2023. Disponível em: 10.21118/apgs.v14i2.12731.
21. Sousa RB, Melo MS, Alves JS, Cavalcante FS Neto, Lopes JS, Santos ES, et al. Atuação do assistente social frente à pessoa com deficiência: revisão integrativa. Rev Científica Acertte. [Internet]. 2023 [acesso em 2024 Jan 24]; 3(2): e32120. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/acertte.v3i2.120>.
22. Geraldo JP. Políticas públicas, o acesso ao cuidado e aos serviços de saúde e de assistência social de Campo Grande/MS: percepção da pessoa com deficiência, cuidadores e gestores [Dissertação]. Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5660>.
23. Rosa CM, Michelon M, Rodrigues F, Folmer V. Implicações histórico-políticas na atual constituição da Educação Especial. CLCS. [Internet]. 2023 [acesso em 2024 Set 21]; 16(11): 28957-28977. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/revconv.16n.11-250>.
24. Santos MF, Friche AA, Lemos SM. Atenção à pessoa com deficiência: composição das equipes e distribuição geográfica do componente especializado em reabilitação. CoDAS. [Internet]. 2021 [acesso em 2024 Jan 24]; 33(1): e20190184. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/W7TD5y7PxDQCmJVgTGrtSVf/>.
25. Silva RS, Fernandes JG, Dantas LAA, Miranda MM, Medeiros AC, Sureira TM, et al. Tradução do conhecimento no cuidado às doenças crônicas não transmissíveis: estudo piloto. Rev Atenção Saúde. 2023;21:e20238890. Disponível em: <https://doi.org/10.13037/ras.vol21.e20238890>.
26. Pereira RP. Eficácia clínica e prática baseada em evidências: avaliação de atitudes, competências e práticas. Repositório UM. Portugal: Editora Científica; 2021. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/72449>.

27. Proctor E, Silmere H, Raghavan R, Hovmand P, Aarons G, Bunger A, et al. Outcomes for implementation research: conceptual distinctions, measurement challenges, and research agenda. *Adm Policy Ment Health*. 2011 Mar;38(2):65-76. Available from: 10.1007/s10488-010-0319-7.
28. Weiner BJ, Lewis MA, Linnan LA. Using organization theory to understand the determinants of effective implementation of worksite health promotion programs. *Health Educ Res*. 2009 Apr;24(2):292-305. Available from: 10.1093/her/cyn019.
29. Ribeiro RL, Macêdo DF, Santos DG. Aplicação de ferramentas da qualidade para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade: estudo de caso no IFAL. *Diversitas J*. 2021;6(2):2478-2490. Disponível em: 10.17648/diversitas-journal-v6i2-1385.
30. Sousa AR, Santos GL, Salbego C, Santana TS, Félix ND, Santana RF, et al. Management technology for implementing the Systematization of Nursing Care. *Rev. Esc. Enferm. USP*. [Internet]. 2022 [cited 2023 Mai 17]; 56: e20220028. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0028en>.
31. Lehman WE, Greener JM, Simpson DD. Assessing organizational readiness for change. *J Subst Abuse Treat*. [Internet]. 2002 [cited 2024 Dez 03]; 22(4): 197–209. Available from: 10.1016/s0740-5472(02)00233-7.
32. Rampazzo L, De Angeli M, Serpelloni G, Simpson DD, Flynn PM. Italian survey of organizational functioning and readiness for change: a cross-cultural transfer of treatment assessment strategies. *Eur Addict Res*. [Internet]. 2006 [cited 2024 Nov 28]; 12(4): 176-181. Available from: 10.1159/000094419.
33. Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos [Internet]. Brasília: Conselho Nacional de Saúde; 2012 [acesso em 2023 Mar 03]. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466\\_12\\_12\\_2012.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html).
34. Maia HR. Desafios e caminhos da implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Amazonas [Dissertação]. Manaus: Fundação Oswaldo Cruz; 2023. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/59376>.
35. Shakespeare T, Officer A. World report on disability. *Disabil Rehabil*. 2011;33(17-18):1491. Available from: 10.3109/09638288.2011.590392.
36. Guzman JM, Salazar EG. Disability and rehabilitation in Mexico. *Am J Phys Med Rehabil*. [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 11]; 93(1 Suppl 1): S36-8. Available from: 10.1097/PHM.0000000000000019.

37. Kronfol NM. Health services to groups with special needs in the Arab world: a review. *East Mediterr Health J.* [Internet]. 2012 [cited 2025 Jan 10]; 18(12): 1247-1253. Available from: 10.26719/2012.18.12.1247.
38. Lagu T, Iezzoni LI, Lindenauer PK. The axes of access--improving care for patients with disabilities. *N Engl J Med.* [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 10]; 370(19): 1847-51. Available from: 10.1056/NEJMs1315940.
39. Sharby N, Martire K, Iversen MD. Decreasing health disparities for people with disabilities through improved communication strategies and awareness. *Int J Environ Res Public Health.* [Internet]. 2015 [cited 2024 Nov 28]; 12(3): 3301-3316. Available from: 10.3390/ijerph120303301.
40. Balogh R, McMorris CA, Lunskey Y, Ouellette-Kuntz H, Bourne L, Colantonio A, et al. Organising healthcare services for persons with an intellectual disability. *Cochrane Database Syst Rev.* [Internet]. 2016 [cited 2025 Jan 09]; 4(4): CD007492. Available from: 10.1002/14651858.CD007492.
41. Sandel ME, Appelman J, Kotch MJ, Biter-Mundt G, Lal N, Samuels S, et al. The California Kaiser Permanente Health System: Evolving to meet the needs of people with disabilities. *Disabil Health J.* [Internet]. 2010 [cited 2024 Dez 12]; 3(4): 240-244. Available from: 10.1016/j.dhjo.2010.07.003.
42. Aenishänslin J, Amara A, Magnusson L. Experiences accessing and using rehabilitation services for people with physical disabilities in Sierra Leone. *Disabil Rehabil.* [Internet]. 2020 [cited 2025 Jan 1]; 44(1): 34-43. Available from: 10.1080/09638288.2020.1755375.
43. Condessa AM, Lucena EH, Figueiredo N, Goes PS, Hilgert JB. Atenção odontológica especializada para pessoas com deficiência no Brasil: perfil dos centros de especialidades odontológicas, 2014. *Epidemiol Serv Saúde.* [Internet]. 2020 [acesso em 2025 Jan 10]; 29(5): e2018154. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500001>.
44. Dassah E, Aldersey HM, McColl MA, Davison C. Health care providers' and persons with disabilities' recommendations for improving access to primary health care services in rural northern Ghana: A qualitative study. *PLoS One.* [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 10]; 17(9). Available from: 10.1371/journal.pone.0274163.
45. Heslop P, Turner S, Read S, Tucker J, Seaton S, Evans B. Implementing reasonable adjustments for -disabled people in healthcare services. *Nurs Stand.* [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 10]; 34(8): 29-34. Available from: 10.7748/ns.2019.e11172.
46. Symons J, Jamison J, Denning J, Murray L, Pearson S. Improving care coordination in community physical rehabilitation: A qualitative study of the change framework. *Int*

- J Care Coord. [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 10]; 22(3-4): 140-147. Available from: 10.1177/2053434519895423.
47. Amorim EG, Liberali R, Medeiros OM Neta. Avanços e desafios na atenção à saúde de pessoas com deficiência na atenção primária no Brasil: uma revisão integrativa. *Holos*. [Internet]. 2018 [acesso em 2024 Dez 26]; 1: 224-236. Disponível em: 10.15628/holos.2018.5775.
  48. Dupuis F, Déry J, Lucas de Oliveira FC, Pecora AT, Gagnon R, Harding K, et al. Strategies to reduce waiting times in outpatient rehabilitation services for adults with physical disabilities: A systematic literature review. *J Health Serv Res Policy*. [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 10]; 27(2): 157-167. Available from: 10.1177/13558196211065707.
  49. Evaristo TC. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: Avaliação no Contexto Brasileiro [Dissertação]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2018. Disponível em: [https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/52137/1/Thalita%20Evaristo\\_Dissertac%CC%A7a%CC%83o.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/52137/1/Thalita%20Evaristo_Dissertac%CC%A7a%CC%83o.pdf).
  50. Skempes D, Kiekens C, Malmivaara A, Michail X, Bickenbach J, Stucki G. Supporting government policies to embed and expand rehabilitation in health systems in Europe: A framework for action. *Health Policy*. [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 28]; 126(3): 158-172. Available from: 10.1016/j.healthpol.2021.06.014.
  51. Macedo MS, Almeida MM, Arce VA. Desafios e perspectivas relacionados à ampliação do acesso da pessoa com deficiência à atenção básica. *Rev. Baiana Saúde Pública*. [Internet]. 2023 [acesso em 2025 Jan 11]; 47(1): 258-268. Disponível em: <https://doi.org/10.22278/2318-2660.2023.v47.n1.a3760>.
  52. Al Imam MH, Jahan I, Das MC, Muhit M, Akbar D, Badawi N, et al. Situation analysis of rehabilitation services for persons with disabilities in Bangladesh: identifying service gaps and scopes for improvement. *Disabil Rehabil*. [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 10]; 44(19): 5571-5584. Available from: 10.1080/09638288.2021.1939799.
  53. Pereira KS. Concepção de um serviço odontológico hospitalar multidisciplinar para pacientes com deficiência ou necessidades especiais no Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins [Dissertação]. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52406>
  54. Frontera WR. The World Health Organization disability action plan. *Am J Phys Med Rehabil*. [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 10]; 93(9): 737. Available from: 10.1097/PHM.0000000000000183.

55. Coughlin TA, Long SK, Graves JA. Does Managed Care Improve Access to Care for Medicaid Beneficiaries with Disabilities? A national study. *Inquiry*. [Internet]. 2008 [cited 2025 Jan 11]; 45(4): 395-407. Available from: [10.5034/inquiryjrnl\\_45.04.395](https://doi.org/10.5034/inquiryjrnl_45.04.395).
56. Khan F, Amatya B, Mannan H, Burkle FM Jr, Galea MP. Rehabilitation in Madagascar: Challenges in implementing the World Health Organization Disability Action Plan. *J Rehabil Med*. [Internet]. 2015 [cited 2025 Jan 10]; 47(8): 688-96. doi: [10.2340/16501977-1995](https://doi.org/10.2340/16501977-1995).
57. Damshroder LJ, Aron DC, Keith RE, Kirsh SR, Alexander JA, Lowery JC. Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science. *Implement Sci* [Internet]. 2009 [cited 2025 Jan 11]; 4(50). Available from: <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50>.
58. Collins PY, Pringle B, Alexander C, Darmstadt GL, Heymann J, Huebner G, et al. Global services and support for children with developmental delays and disabilities: Bridging research and policy gaps. *PLoS Med*. [Internet]. 2017 [cited 2025 Jan 10]; 14(9): e1002393. Available from: [10.1371/journal.pmed.1002393](https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002393).
59. Kavanagh A, Dickinson H, Carey G, Llewellyn G, Emerson E, Disney G, et al. Improving health care for disabled people in COVID-19 and beyond: Lessons from Australia and England. *Disabil Health J*. [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 11]; 14(2): 101050. Available from: [10.1016/j.dhjo.2020.101050](https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2020.101050).
60. Ribeiro KS, Barroso RB, Ramos BG, Ferrari FP, Saldanha JHS, Silva SL, et al. Redecin Brasil: a construção metodológica de um estudo multicêntrico para avaliação da rede de cuidados à pessoa com deficiência. *Interface (Botucatu)*. [Internet]. 2021 [acesso em 2023 Jun 09]; 25: e200767. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.200767>.

**APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS  
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE GESTÃO, PROFISSIONAIS DA  
REDE, PROFISSIONAIS DA JUNTA REGULADORA DA RCPD**

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(TCLE)**

**PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE GESTÃO,  
PROFISSIONAIS DA REDE E PROFISSIONAIS DA JUNTA REGULADORA DA RCPD**

Título do Projeto: Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da  
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG

Pesquisador Responsável: Amanda Rezende Silva de Oliveira.

Instituição: Universidade Federal Fluminense – MPEA/UFF

Telefone e e-mail para contato do Pesquisador: (31) 98824-1319

e-mail: amandarso@id.uff.com

Nome do Participante: \_\_\_\_\_.

O(A) Sr.<sup>(a)</sup> está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência em Lagoa Santa/MG, de responsabilidade da pesquisadora Amanda Rezende Silva de Oliveira.

O contexto da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG aponta para a necessidade de fortalecer e estabelecer uma rede de qualidade no município. A pesquisa para qual esta sendo convidado a participar objetiva de forma geral avaliar os resultados da implementação de um plano de melhorias nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais. Trará contribuições para o acesso da pessoa com deficiência nos pontos de atenção da rede, qualidade na assistência prestada, apoio gerencial e integração entre os serviços,

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), e conta com a anuência Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa. Ressaltamos que as exigências éticas apresentadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (36), que dispõe sobre as diretrizes e normas das pesquisas científicas envolvendo seres humanos serão cumpridas em sua totalidade.

Sua participação no estudo consiste em participar das oficinas e atividades propostas nas reuniões com suas opiniões, percepções e contribuições acerca da RCPD. Os participantes irão participar de oficinas mediante o aceite e assinatura neste termo. Destaca-se que todos os envolvidos terão voz ativa nas oficinas, incluindo os usuários. As oficinas terão a duração média de duas horas e trinta.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

As oficinas terão a duração média de duas horas e trinta minutos e serão realizadas em espaço reservado para esta finalidade no Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa e estarão presentes somente os participantes e a pesquisadora principal. As oficinas serão realizadas em três etapas, a saber: definição do problema e causa raiz, proposição de melhorias, priorização das ações.

Será preservado o sigilo de sua colaboração e informações prestadas, e poderá desistir de sua participação a qualquer momento. Os riscos dessa pesquisa estão relacionados a exposição dos participantes em discussões sensíveis sobre o processo de trabalho e exposição não intencional de informações confidenciais. Para mitigar esses riscos, será seguido rigoroso protocolo ético, protegendo a privacidade dos participantes.

Para tal os participantes não terão, em nenhum momento da pesquisa, sua identidade ou qualquer informação pessoal reveladas ou relacionadas as suas respostas. Nas oficinas, as respostas serão dos grupos e não pessoais e/ou individuais, o conjunto de falas e colocações dos participantes serão trabalhadas de modo a constuir as ferramentas propostas nesta etapa. Os TCLEs assinados e outros documentos do estudo serão arquivados em local seguro de conhecimento e acesso exclusivos da pesquisadora principal por cinco anos e após este período serão destruídos.

Como benefício da pesquisa, os participantes poderão colaborar com a melhoria do seu próprio processo de trabalho, atuando de forma ativa e sendo escutados em seus anseios e sugestões. Portanto, a pesquisa pode aumentar a motivação dos funcionários e o engajamento, pois os desafiará intelectualmente e oferecerá uma oportunidade de contribuição significativa para o avanço do conhecimento em relação à RCPD. Os resultados deste estudo serão divulgados em eventos acadêmicos ou revistas científicas, sem qualquer identificação dos participantes, preservando o anonimato. Os dados coletados não serão utilizados para outras pesquisas. Salientamos que os participantes não terão gastos inerentes à participação na pesquisa, transporte e alimentação serão oferecidos pela pesquisadora nos dias das oficinas. Serão tomadas todas as providências éticas e de segurança para impedir danos imediatos ou tardios aos participantes. Caso ocorram a pesquisadora principal assumirá total responsabilidade e buscará as formas cabíveis e legais para o ressarcimento dos participantes lesados. Ressalto que a pesquisadora principal estará disponível para sanar eventuais dúvidas acerca das oficinas, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

Celular/Whatsapp: (21) 99769-8644, Telefone fixo: (21) 2629-9310

E-mail: **etica.ret@id.uff.br**

Eu, \_\_\_\_\_, declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Lagoa Santa-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

**APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  
USUÁRIOS DA RCPD E FAMILIARES DE PCD**

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(TCLE)**

**USUÁRIOS DA RCPD E FAMILIARES DE PCD**

Título do Projeto: Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG

Pesquisador Responsável: Amanda Rezende Silva de Oliveira.

Instituição: Universidade Federal Fluminense – MPEA/UFF

Telefone e e-mail para contato do Pesquisador: (31) 98824-1319 e-mail: amandarso@id.uff.com

Nome do Participante: \_\_\_\_\_.

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência em Lagoa Santa/MG, de responsabilidade da pesquisadora Amanda Rezende Silva de Oliveira.

O contexto da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG aponta para a necessidade de fortalecer e estabelecer uma rede de qualidade no município. A pesquisa em que você está sendo convidado a participar quer avaliar os resultados da implementação de um plano de melhorias nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais. Trará contribuições para o acesso da pessoa com deficiência e qualidade dos serviços de saúde do município.

Este estudo avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), e conta com a autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa para sua realização. Reforçamos que seguimos todas as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (36), que dispõe sobre as diretrizes e normas das pesquisas científicas envolvendo seres humanos.

Sua participação no estudo consiste em participar das oficinas e atividades propostas nas reuniões com suas opiniões, percepções e contribuições acerca da RCPD. Para participar das oficinas você precisa aceitar e assinar este termo, podendo desistir a qualquer momento sem nenhum prejuízo.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

Todos os envolvidos terão voz ativa nas oficinas, incluindo os usuários. As oficinas terão a duração média de duas horas e trinta minutos e serão realizadas em espaço reservado para esta finalidade no Centro Administrativo da Prefeitura de Lagoa Santa e estarão presentes somente os participantes e a pesquisadora principal. As oficinas serão realizadas em três etapas: definição do problema e causa raiz, proposição de melhorias, priorização das ações.

Será preservado o sigilo de sua colaboração e informações prestadas, e poderá desistir de sua participação a qualquer momento. Os riscos dessa pesquisa estão relacionados a exposição dos participantes em discussões sensíveis a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e exposição não intencional de informações confidenciais.

Para diminuir ou evitar esses riscos, será seguido rigoroso protocolo, protegendo a privacidade dos participantes. Em nenhum momento da pesquisa, sua identidade ou qualquer informação pessoal sua será revelada ou relacionada às suas respostas. Nas oficinas, as respostas serão dos grupos e não pessoais e/ou individuais. Este e outros documentos do estudo serão arquivados em local seguro de conhecimento e acesso exclusivos da pesquisadora principal por cinco anos e após este período serão destruídos.

Como benefício da pesquisa, você poderá colaborar com a melhoria da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do município de Lagoa Santa, atuando de forma ativa e sendo escutado em seus anseios e sugestões. Os resultados deste estudo serão divulgados em eventos acadêmicos ou revistas científicas, sem qualquer identificação dos participantes, preservando o anonimato. Os dados coletados não serão utilizados para outras pesquisas.

Salientamos que você não terá gastos com sua participação na pesquisa. O transporte e alimentação serão oferecidos pela pesquisadora nos dias das oficinas. Serão tomadas todas as providências éticas e de segurança para impedir danos imediatos ou tardios aos participantes. Caso ocorram a pesquisadora principal assumirá total responsabilidade e buscará as formas cabíveis e legais para o ressarcimento dos participantes lesados. Ressalto que a pesquisadora principal estará disponível para sanar eventuais dúvidas acerca das oficinas, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

Celular/Whatsapp: (21) 99769-8644, Telefone fixo: (21) 2629-9310

E-mail: **etica.ret@id.uff.br**

Eu, \_\_\_\_\_, declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Lagoa Santa-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

**APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA  
PROFISSIONAIS, DE NÍVEL SUPERIOR, INTEGRANTES DA EQUIPE  
MULTIPROFISSIONAL E ATUANTES NOS PONTOS DE ATENÇÃO DA RPCD**

**TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(TCLE)**

**PROFISSIONAIS, DE NÍVEL SUPERIOR, INTEGRANTES DA EQUIPE  
MULTIPROFISSIONAL E ATUANTES NOS PONTOS DE ATENÇÃO DA RPCD**

Título do Projeto: Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG

Pesquisador Responsável: Amanda Rezende Silva de Oliveira.

Instituição: Universidade Federal Fluminense – MPEA/UFF

Telefone e e-mail para contato do Pesquisador: (31) 98824-1319 e-mail: amandarso@id.uff.com

Nome do Participante: \_\_\_\_\_.

O(A) Sr.<sup>(a)</sup> está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa Estudo de Implementação de Melhorias nos Processos Gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência em Lagoa Santa/MG, de responsabilidade da pesquisadora Amanda Rezende Silva de Oliveira.

O contexto da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa/MG aponta para a necessidade de fortalecer e estabelecer uma rede de qualidade no município. A pesquisa para qual esta sendo convidado a participar objetiva de forma geral avaliar os resultados da implementação de um plano de melhorias nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais. Trará contribuições para o acesso da pessoa com deficiência nos pontos de atenção da rede, qualidade na assistência prestada, apoio gerencial e integração entre os serviços,

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), e conta com a anuência Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa. Ressaltamos que as exigências éticas apresentadas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (36), que dispõe sobre as diretrizes e normas das pesquisas científicas envolvendo seres humanos serão cumpridas em sua totalidade.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

Sua participação consiste em responder ao formulário online com perguntas para caracterização dos profissionais (categoria profissional, tempo de formação, tempo na RCPD, sexo e idade) e perguntas do instrumento que avalia a Prontidão Organizacional para Mudança, via Google Forms. Para a avaliação da prontidão organizacional para mudanças (POM), os profissionais da equipe multiprofissional que estiverem participando do encontro mensal do programa de educação permanente (PEP), no período de coleta de dados do estudo, serão convidados a participar da pesquisa respondendo a um formulário no *Google forms* que estará disponível para acesso por meio de um QRcode durante o PEP. Os PEPs são realizados na Unidade Gestora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, (Mensalmente). Todos os profissionais de nível superior da rede são convidados a participar de todos os PEPs oferecidos. O tempo médio para preenchimento do formulário é 20 minutos.

Os riscos dessa pesquisa estão relacionados a exposição dos participantes em temas sensíveis sobre o processo de trabalho e exposição não intencional de informações confidenciais. Para mitigar esses riscos, será seguido rigoroso protocolo ético, protegendo a privacidade dos participantes. Para tal os participantes não terão, em nenhum momento da pesquisa, sua identidade ou qualquer informação pessoal reveladas ou relacionadas as suas respostas. As suas respostas serão anônimas e não será solicitada qualquer informação pessoal que o identifique, garantindo sigilo e incógnita sobre a autoria. Será preservado o sigilo de sua colaboração e informações prestadas, e poderá desistir de sua participação a qualquer momento.

Contudo, destaca-se que não será possível garantir confidencialidade absoluta dos dados, levando em consideração que esta etapa ocorrerá em formulário online, aumentando a possibilidade de violação de informações. Para minimizar tais riscos relacionados ao ambiente virtual, será utilizado conexões seguras (HTTPS) para proteger a transmissão e o armazenamento de informações e uma vez concluída a coleta de dados, será realizado o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem". Após o download dos dados do estudo, eles serão arquivados em dispositivo local e seguro de conhecimento e acesso exclusivo da pesquisadora principal por cinco anos e após este período serão destruídos. Como benefício da pesquisa, os participantes poderão colaborar com a melhoria do seu próprio processo de trabalho, atuando de forma ativa e sendo escutados em seus anseios e sugestões. Portanto, a pesquisa pode aumentar a motivação dos funcionários e o engajamento, pois os desafiará intelectualmente e oferecerá uma oportunidade de contribuição significativa para o avanço do conhecimento em relação à RCPD. Os resultados deste estudo serão divulgados em eventos acadêmicos ou revistas científicas, sem qualquer identificação dos participantes, preservando o anonimato. Os dados coletados não serão utilizados para outras pesquisas.

Rubrica do pesquisador e participante: \_\_\_\_\_.

Salientamos que os participantes não terão gastos inerentes à participação na pesquisa, transporte e alimentação serão oferecidos pela pesquisadora nos dias das oficinas. Serão tomadas todas as providências éticas e de segurança para impedir danos imediatos ou tardios aos participantes. Caso ocorram a pesquisadora principal assumirá total responsabilidade e buscará as formas cabíveis e legais para o ressarcimento dos participantes lesados. Ressalto que a pesquisadora principal estará disponível para sanar eventuais dúvidas acerca das oficinas, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas:

Celular/Whatsapp: (21) 99769-8644, Telefone fixo: (21) 2629-9310

E-mail: **etica.ret@id.uff.br**

Eu, \_\_\_\_\_, declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Lagoa Santa-MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do participante ou responsável legal)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso)

## APÊNDICE D

### Protocolo Revisão de Escopo

#### PROTOCOLO DE REVISÃO DE ESCOPO

#### **Boas práticas gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: protocolo de *scoping review***

##### **RESUMO**

**Objetivo:** mapear na literatura científica evidências sobre as boas práticas nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. **Método:** revisão de escopo conduzida pela metodologia do *Joana Briggs Institute* (JBI) e *checklist Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-analyses for scoping review* (PRISMA-ScR), utilizando a questão de pesquisa elaborada pelo acrônimo PCC: “quais são as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência?”. As buscas serão conduzidas em seis bases de dados e outras bibliotecas para literatura cinzenta. Na estratégia de busca em todas as bases, serão pesquisadas palavras relacionadas nos títulos, resumo e assunto. Os dados serão apresentados em forma de quadros e nuvem de palavras geradas pelo *software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (IRAMUTEQ), além de um resumo descritivo que mostrará como os resultados se relacionam com o objetivo e com a pergunta da revisão.

**Descritores:** Pessoas com Deficiência; Serviços de Saúde para Pessoas com Deficiência; Gestão em Saúde.

## INTRODUÇÃO

A saúde é um direito universal e fundamental do indivíduo, família e coletividade. Amparado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela constituição de 1988. A Lei nº 8.080 de 1990, delibera sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a disposição e a operacionalização do então instituído Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS é um sistema regido pelo poder público, regionalizado, organizado hierarquicamente, que oferece ações e serviços de saúde em todo território nacional<sup>(1-2)</sup>.

Buscando garantir a integralidade do cuidado as Redes de Atenção à saúde (RAS) surgem como arranjos organizativos de diferentes densidades tecnológicas, ações e serviços de saúde que integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão devem oferecer acesso a assistência qualificada<sup>(3-4)</sup>. Trata-se da melhor estratégia para superar os desafios e integrar os sistemas de saúde<sup>(3)</sup>.

Dentre as diversas RAS existentes no Sistema Único de Saúde, a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) se propõe a aumentar a oferta e a qualidade dos cuidados prestados às pessoas com deficiência por meio de diferentes estratégias para o alcance de uma rede de serviços efetiva, integrada e articulada<sup>(1)</sup>. Para o estabelecimento de uma RCPD efetiva é necessário garantir a articulação entre os componentes de atenção à saúde (Atenção Básica, atenção especializada, atenção hospitalar e urgência e emergência), fluxos assistenciais eficientes, disseminados e, regulados, educação permanente operante e continua, informações epidemiológicas estabelecidas, fomentar práticas inclusivas para a pessoa com deficiência<sup>(1)</sup>.

Apesar da necessidade de efetiva articulação, a RCPD tem sido fragmentada com serviços não interligados, gerando assim, os vazios assistenciais que vitimam as pessoas com deficiência. Além das ausências de serviços nos territórios, tem-se a dificuldade criada pela especificidade de cada serviço. A ausência ou desarticulação dos serviços de saúde comprometem o bem-estar físico e emocional dos pacientes e seus familiares<sup>(4-5)</sup>. Vale ressaltar que a ausência de participação de todos os atores nos espaços de decisão impede que suas potencialidades e fragilidades sejam discutidas e alinhadas sob as diversas óticas de uma rede de atenção à saúde<sup>(6-7)</sup>.

Pesquisas sobre a temática, em diversas regiões do Brasil, apresentam em seus desfechos similaridades ao afirmarem que as RCPDs não conseguem oferecer o

preconizado nas normativas. A persistente desarticulação da RCPD impossibilita o acesso da pessoa com deficiência à assistência integral, interdisciplinar e intersetorial comprometendo sua reabilitação e inclusão social<sup>(5-7)</sup>.

Para tanto, é necessário reconhecer as boas (ou melhores) práticas relacionadas aos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Foi realizada uma busca preliminar em 26 de setembro de 2023 nos seguintes recursos informacionais: *Prospero Systematic review*, *Open Science Framework* (OSF). Os resultados da busca preliminar não identificaram revisões sistemáticas ou de escopo e/ou protocolos de revisão de escopo atuais ou em andamento sobre o tema e, ainda, que existem estudos primário sobre o tópico garantindo a exequibilidade desta revisão. Assim, o objetivo deste estudo é mapear na literatura científica evidências sobre as boas práticas nos processos gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

## **MÉTODO**

Revisão de escopo a ser desenvolvida com base nas recomendações do *Joana Briggs Institute* (JBI), seguindo as etapas propostas pelo método, a saber: definir e alinhar o objetivo e a questão de pesquisa; desenvolver e alinhar os critérios de inclusão com o objetivo e a questão de pesquisa; descrever a abordagem planejada para a busca, seleção, extração de dados e apresentação de evidências; buscar as evidências; selecionar as evidências; extrair as evidências; analisar as evidências; apresentar os resultados e; resumir as evidências em relação ao objetivo da revisão de escopo, realizando conclusões e observando as implicações das descobertas. Realizou-se o registro da revisão de escopo na plataforma *Open Science Framework* (OSF), onde o mesmo pode ser consultado na íntegra através do DOI 10.17605/OSF.IO/VPDMW.

### **Pergunta da revisão**

Aplicou-se o acrônimo PCC que se refere a População, Conceito e Contexto, tal estratégia foi adotada para formular a questão de pesquisa da revisão de escopo. “Quais são as melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência?” Na qual P (público-alvo): Pessoa com deficiência; C (conceito): melhores práticas relacionadas a gestão; C (contexto): rede de cuidados à pessoa com deficiência (Figura 1).

|                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POPULAÇÃO</b> | Pessoas com deficiência                                                                                                                                                                       |
| <b>CONCEITO</b>  | Melhores práticas relacionadas a gestão das redes de cuidado, especialmente quando apresentar implementação de melhorias nos processos gerenciais. (Características, avaliação e resultados). |
| <b>CONTEXTO</b>  | Perspectivas que abranjam as redes de cuidado à pessoas com deficiência e seus variados cenários.                                                                                             |

**Figura 1** - Mnemônico PCC para a formulação da questão de pesquisa da revisão de escopo. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2023

### **Critério de elegibilidade**

Por se tratar de uma revisão de escopo o presente protocolo adotará critério de inclusão abrangente, não considerando recorte temporal, local ou idiomático. Artigos duplicados serão excluídos e contabilizados apenas uma vez.

Para a população serão incluídos estudos primários ou secundários relacionados à pessoa com deficiência, independente da deficiência ou idade, que abordem boas práticas vinculadas ao contexto as redes de cuidado às pessoas com deficiência e seus variados cenários. Serão excluídas publicações sobre cuidados prestados à pessoa com deficiência visto que essas fontes não seriam apropriadas para atender ao objetivo da revisão.

### **Tipos de fontes**

A presente revisão de escopo considerará delineamentos de estudos observacionais descritivos e analíticos, séries de casos, relatos de casos individuais, pesquisas qualitativas, além de experimentos e ensaios clínicos. Assim como documentos de organizações relevantes, relatórios do governo, como manuais, políticas e diretrizes de prática clínica relacionados ao conceito, já citado, desta revisão de escopo. Contemplará ainda, estudos pré e pós-intervenção e estudos de séries temporais interrompidas, coortes e estudos de caso-controle. Serão consideradas revisões sistemáticas e metanálises, além de teses, dissertações e artigos de opinião. Resumos de eventos, cartas e editoriais serão excluídos. Desta forma espera-se o retorno de materiais e evidências variadas, os quais contribuirão para a construção de um diagnóstico em relação ao tema proposto.

## Estratégia de pesquisa

A estratégia de busca inicial foi construída com o auxílio de uma bibliotecária, a busca e a seleção dos estudos serão realizadas em três fases distintas, a saber: 1) Busca de palavras-chave em títulos e resumos; 2) Utilização das palavras-chave para busca em uma base de dados e; 3) Busca nas bases de dados estabelecidas e aplicação dos critérios de elegibilidade. As fases um e dois auxiliaram na construção da estratégia/expressão de busca a ser utilizada na terceira fase. A primeira fase de busca se dará por palavras contidas no título e resumo, e dos termos de assunto que descrevem os artigos. Na segunda fase, as palavras-chave e os termos de assuntos identificados na fase anterior, serão utilizados para a pesquisa completa em outras bases. Ao final, a busca foi realizada com descritores dos vocabulários controlados (Descritores em Ciências da Saúde – DeCS; *Medical Subject Headings Section* – MeSH e *EMTREE*), palavras-chave e suas variações contidas nos títulos, resumos e assunto dos documentos. A estratégia de busca será adaptada para cada base de dados e não serão aplicados filtros (Figura 2).

| Bu<br>sca | ESTRATÉGIA DE BUSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resultado |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #1        | ("redes de atenção" OR "Network of care" OR "serviços de saúde" OR "Health Services" OR "Atenção à Saúde" OR "Delivery of Health Care" OR "Atención a la Salud")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.160    |
| #2        | ("pessoas com deficiência" OR "People with Disabilities" OR "Personas con Discapacidad" OR "Disabled Persons" OR "Serviços de Saúde para Pessoas com Deficiência" OR "Health Services for Persons with Disabilities" OR "Servicios de Salud para Personas con Discapacidad" OR "red asistencial para personas con discapacidad" OR "Rede de Cuidados para a Pessoa com Deficiência" OR "Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência")                                                                   | 6.750     |
|           | ("Administração de Serviços de Saúde" OR "Health Services Administration" OR "Administración de los Servicios de Salud" OR "Gerencia de los Servicios de Salud" OR "Gerencia de Servicios de Salud" OR "Gestión de los Servicios de Salud" OR "Gestión de Servicios de Salud" OR "Administração de Serviços de Saúde" OR "Gerência de Serviços de Saúde" OR "Gerência dos Serviços de Saúde" OR "Gestão de Serviços de Saúde" OR "Gestão dos Serviços de Saúde" OR "Administration, Health Services") |           |

|    |          |       |
|----|----------|-------|
| #3 |          | 1.482 |
| #4 | #1 AND 2 | 1.658 |
| #5 | #3 AND 4 | 33    |

**Figura 2** - Estratégia de busca para recuperação das publicações nas bases de dados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2023

Serão utilizadas as seguintes bases de dados para a revisão: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (Medline) via *Pubmed*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Web of Science* (WOS), *Scopus* e *Excerpta Medica Database* (Embase) via Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Para contemplação da literatura cinzenta, será utilizada a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da CAPES, para documentos governamentais a Biblioteca Virtual em Saúde Ministério da Saúde (BVS MS), e para documentos não publicados o Google Acadêmico.

### Seleção de evidências

Os resultados das buscas serão exportados para o *software* gestor de referência *Endnote Web*, onde serão excluídas as duplicatas e, para o *software* gestor de revisão *Rayyan* onde será gerenciada a seleção dos estudos que comporão a revisão de escopo, ambos online e gratuitos. A seleção das evidências será realizada por dois revisores, treinados previamente, que irão selecionar os artigos individualmente, com cegamento de pares, em máquinas distintas, sem interferências ou conhecimento sobre a seleção do outro revisor. Inicialmente, será realizada a leitura dos títulos e resumos pela dupla de revisores independentes, buscando estudos que atendam os critérios de elegibilidade. Os estudos selecionados serão lidos na íntegra para excluir os que não atenderem à pergunta da revisão.

Havendo divergências entre os dois revisores no processo de seleção, tais discordâncias serão levadas ao terceiro revisor independente, com expertise no tema, para o parecer final. Os trabalhos não contemplados, por oposição aos critérios de inclusão, serão

apontados no relatório final. Os achados do processo de busca e inclusão do estudo serão relatados na íntegra de forma descritiva e reflexiva. Para garantir qualidade e transparência do estudo os resultados serão apresentados em um fluxograma de *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews e Meta-analyses for scoping review* (PRISMA-ScR).

### **Extração de dados**

Os estudos elegíveis serão recuperados em sua plenitude e analisados por um revisor independente com a leitura integral dos textos. Para extração dos dados da literatura incluída na revisão de escopo, será empregada uma planilha no *Excel*, desenvolvida pelos autores, contemplando informações específicas conforme a recomendação do JBI *Manual for Evidence Synthesis*.

Os dados extraídos da literatura selecionada serão: autoria, ano de publicação, país onde o estudo foi desenvolvido, objetivos, desenho do estudo, população e amostra, resultados, boas práticas indicadas na gestão da rede de atenção às pessoas com deficiência e conclusões.

### **Análise e apresentação dos dados**

Os dados serão apresentados em forma de quadros e nuvem de palavras geradas pelo *software Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires* (IRAMUTEQ), além de um resumo descritivo que mostrará como os resultados se relacionam com o objetivo e com a pergunta da revisão.

## **REFERÊNCIAS**

1. Ribeiro KSQS, Saldanha JHS, Zanela ÂK, Ferrari FP, Freitas GKF, Barroso RB, et al.. Avaliação da implantação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Sistema Único de Saúde: um estudo de casos múltiplos. Cad Saúde Pública. 2023;39(5):e00186122. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT186122>
2. Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº
3. 8.080 de 19 de setembro de 1990 [Internet]. Brasília: Presidência da República;1990 [citado 2023 Mar 07]. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/18080.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18080.htm)

4. Mendes EV. As redes de atenção à saúde. 2ª ed. [Internet]. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011[citado 2023 Jul 10]. Disponível em: [https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Redes\\_Atencao\\_Saude\\_Eugenio\\_2ed.pdf](https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/11/Redes_Atencao_Saude_Eugenio_2ed.pdf)
5. Tofani LFN, Furtado LAC, Guimarães CF, Feliciano DGCF, Silva GR da, Bragagnolo LM, et al.. Caos, organização e criatividade: revisão integrativa sobre as Redes de Atenção à Saúde. *Ciênc saúde coletiva*. 2021Oct;26(10):4769–82. <https://doi.org/10.1590/1413-812320212610.261020>
6. Maciel FJ, Friche AA de L, Januário GC, Santos MFN, Reis RA, Oliveira Neto R de, et al.. Análise espacial da atenção especializada na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: o caso de Minas Gerais. *CoDAS*. 2020;32(3):e20180104. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202018104>
7. Mota PHS. Implementação da Rede de Cuidados à pessoa com deficiência: contexto, valores e níveis do cuidado [tese de doutorado]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2020 doi: <https://doi.org/10.11606/T.6.2020.tde-11032020-132928>
8. Santos NG. Desigualdade e pobreza: análise da condição de vida da pessoa com deficiência a partir dos indicadores sociais brasileiros [tese de doutorado na internet]. Londrina: Universidade Estadual de Londrina; 2020 [citado 2023 Mar 10]. Disponível em: [https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id\\_trabalho=9986496](https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=9986496)
9. Peters MDJ, Godfrey C, McInerney P, Munn Z, Tricco AC, Khalil, H. Chapter 11: Scoping Reviews (2020 version). In: Aromataris E, Munn Z, editors. *JBIManual for Evidence Synthesis* [Internet]. Adelaide: JBI; 2020 [citado 2023 Ago 10]. Disponível em: <https://synthesismanual.jbi.glo>

## APÊNDICE E



REDE DE CUIDADOS À  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Plano de melhoria da qualidade

# Rede de cuidados à pessoa com deficiência

do município de Lagoa Santa  
Minas Gerais

Amanda Rezende silva de Oliveira  
Maithê de Carvalho



Secretaria de  
Saúde



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**  
CONSTRUINDO UMA CIDADE CADA DIA MELHOR

# **PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA MINAS GERAIS**

## **1. INTRODUÇÃO**

Para o estabelecimento de uma Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) efetiva é necessário garantir a articulação entre os componentes de atenção à saúde, atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar e urgência e emergência (Brasil, 2017). Além dessa articulação, é necessário estabelecer e regular os fluxos assistenciais, desenvolver estratégias que viabilizem a educação permanente entre os pontos de atenção, construir mecanismos que apresentem informações epidemiológicas da sua região de abrangência e, fomentar práticas inclusivas para a pessoa com deficiência (Minas Gerais, 2014).

Apesar da necessidade de efetiva articulação, a RCPD tem sido fragmentada com serviços não interligados. Assim, gerando os vazios assistenciais que vitimam as pessoas com deficiência. Além das ausências por questões territoriais as dificuldades, são, também, criadas pela especificidade de cada serviço. A ausência ou desarticulação dos serviços de saúde comprometem o bem-estar físico e emocional dos pacientes e seus familiares. A falta de oferta adequada dos serviços de saúde impõe às famílias preocupações e desafios constantes, além de significativa pressão financeira.

Dessa forma, percebe-se que o sistema não foi construído visando as necessidades da população PcD e que, possivelmente, estes não tiveram voz no momento do planejamento e implantação da política. Vale ressaltar que a ausência de participação de todos os atores nos espaços de decisão impede que suas potencialidades e fragilidades sejam discutidas e alinhadas sob as diversas óticas de uma rede de atenção à saúde (Mota, 2020). Pesquisas sobre a temática, em diversas regiões do Brasil, apresentam em seus desfechos similaridades ao afirmarem que as RCPDs não conseguem oferecer o preconizado nas normativas (Santos, 2020; Mota, 2020).

O presente plano de melhorias para a RCPD de Lagoa Santa poderá garantir melhorias de qualidade nos processos da rede. Compreender o contexto e os processos gerenciais de determinada RCPD apresenta-se como ação imprescindível para o alcance de

uma rede de serviços integrada, articulada e efetiva, e por consequência, a inclusão social e a assistência qualificada para as PcDs e familiares.

## 2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em Lagoa Santa, Minas Gerais, uma rede de cuidados para pessoas com deficiência enfrenta os desafios de uma rede desarticulada com dificuldades para o acesso da pessoa com deficiência. Para abordar essas questões, um plano de melhoria será desenvolvido com base no CFIR, utilizando estratégias que incluem a melhoria da comunicação e integração da rede, capacitação e empatia, padronização de fluxos, contratação de profissionais e adequação do espaço físico para atendimento infantil, além da implantação do horário estendido.

## 3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA RCPD

A partir do estudo das normativas pertinentes a RCPD e da estrutura organizacional posta no arcabouço do Mistério da Saúde (MS), o mapeamento atual da RCPD do município de Lagoa Santa, apresentou inconformidades e ausências de elementos essenciais para garantia de acesso e integralidade do cuidado.

Foram analisados 680 (100,0%) registros de indivíduos encaminhados à junta reguladora de Lagoa Santa, destes 492 (72,4%) são indivíduos do sexo masculino e 188 (27,6%) são do sexo feminino. A média de idade foi de 10 anos aproximadamente, variando entre 1 ano e 65 anos (DP=5,6).

Em relação ao acesso à RCPD de Lagoa Santa, destaca-se que não foi possível precisar a data de entrada na Rede de 48 (7,1%) indivíduos, uma vez que os mesmos foram inseridos via Centro de Especialidades Médicas e Multidisciplinares (CEMM) ou APAE. Destes, 9 indivíduos ainda não foram acolhidos na RCPD por não responderem à inúmeras tentativas de contato ou por mudança de domicílio para outro município. Os 39 restantes foram acolhidos na RCPD nos anos de 2023 e 2024.

Do total de registros analisados, 255 (37,5%) indivíduos ainda permanecem sem acolhimento na RCPD de Lagoa Santa (Tabela 1). Destes, 116 não foram acolhidos por não responderem à inúmeras tentativas de contato ou por não comparecerem aos agendamentos ou rejeitarem o atendimento ou foram devolvidos para a regulação encaminhar às Unidades Básicas de Saúde ou já estão em atendimento na APAE. Os demais 139 ainda aguardam o acolhimento na RCPD.

A taxa de acesso à RCPD variou ao longo dos anos, considerando-se o período de 2020 a 2024, sendo a maior taxa de 64,5% em 2023 e a menor taxa de 11,6% em 2022 (Tabela 1).

**Tabela 1.** Indicadores de taxa de acesso a RCPD e número de casos não atendidos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| Variável                                         | ANOS  |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Indivíduos sem acolhimento/atendimento na RCPD   | 8     | 7     | 8     | 127   | 102   |
| Indivíduos que realizaram o primeiro atendimento | 28    | 13    | 61    | 231   | 41    |
| Taxa de acesso a RCPD                            | 22,2% | 35,0% | 11,6% | 64,5% | 28,6% |

A média do tempo de espera para o acolhimento/primeiro atendimento na RCPD dos indivíduos cadastrados na junta reguladora é de 278 dias aproximadamente, variando entre 0 e 2020 dias (DP=301,3). A média de dias do tempo de espera foi reduzindo ao longo dos anos no município do estudo (Tabela 2).

**Tabela 2.** Indicador do tempo de espera para o primeiro atendimento/acolhimento dos indivíduos na RCPD do Município de Lagoa Santa por ano, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| Anos | Média    | Mínimo | Máximo | Desvio Padrão |
|------|----------|--------|--------|---------------|
| 2020 | 980 dias | 860    | 1223   | 66            |
| 2021 | 624 dias | 495    | 800    | 105           |
| 2022 | 314 dias | 120    | 910    | 167           |
| 2023 | 177 dias | 0      | 1380   | 160           |
| 2024 | 97 dias  | 9      | 232    | 78            |

O Plano de Melhorias foi desenvolvido a partir das boas práticas no gerenciamento da RCPD descritas por meio da revisão de escopo, bem como o mapeamento do fluxo gerencial da Rede, a definição dos indicadores, e a identificação das causas e efeitos dos problemas elencados na oficina com os *stakeholders*. Por fim, a avaliação da POM, o diagnóstico situacional da rede e a listagem de ações prioritárias para implementação de melhorias (Quadro 1 e 2).

**Quadro 1.** Ações estabelecidas como prioritárias pelos *stakeholders* para a melhoria da RCPD do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

| AÇÃO                                                                                                                                                                           | G | U | T | RESULTADO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|
| Estratégias para melhoria da comunicação/integração da rede: (implementar sistemas de informação, padronizar e divulgar os fluxos, treinamento em comunicação interdisciplinar | 5 | 5 | 5 | 125       |
| Capacitação dos profissionais com estímulo à empatia para o atendimento ao público citado.                                                                                     | 5 | 5 | 5 | 125       |
| Padronizar/publicar os fluxos da rede.                                                                                                                                         | 5 | 5 | 5 | 125       |
| Contratação de profissionais.                                                                                                                                                  | 5 | 5 | 4 | 100       |
| Adequação do espaço para o atendimento infantil (criar um ambiente lúdico, paredes coloridas, brinquedos, jogos e livros infantis).                                            | 4 | 4 | 4 | 64        |
| Implementação de horário estendido.                                                                                                                                            | 4 | 4 | 4 | 64        |
| Educação em saúde para familiares sobre o desenvolvimento infantil, a importância do estímulo, tempo de qualidade e o brincar livre de telas.                                  | 3 | 4 | 2 | 24        |

**Quadro 2.** Síntese recomendações das melhores práticas relacionadas à gestão da rede de cuidados à pessoa com deficiência, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2025.

| <b>DOMÍNIO</b>                        | <b>RECOMENDAÇÃO</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acessibilidade Física                 | Garantir ambientes acessíveis, incluindo elevadores, rampas, banheiros adaptados e equipamentos médicos                                             |
| Acessibilidade Comunicacional         | Melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e pessoas com deficiência, incluindo materiais acessíveis e treinamento em linguagem inclusive. |
| Coordenação e Integração dos Serviços | Implementar um modelo de assistência coordenada para otimizar o fluxo de pacientes e evitar fragmentação nos atendimentos.                          |
| Capacitação Profissional              | Incorporar treinamento sobre atendimento a pessoas com deficiência na formação de profissionais de saúde, garantindo práticas mais humanizadas.     |
| Financiamento e Sustentabilidade      | Criar mecanismos de financiamento para garantir a continuidade dos serviços de reabilitação e aquisição de dispositivos assistivos.                 |
| Atendimento Central no Paciente       | Priorizar um modelo de cuidado personalizado, considerando as necessidades individuais e respeitando a autonomia do paciente.                       |
| Uso de Tecnologia e Inovação          | Investir em telemedicina, registros eletrônicos e dispositivos assistivos para melhorar a qualidade do atendimento                                  |

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engajamento da Comunidade      | Criar redes de apoio entre pacientes, familiares e profissionais para promoção e melhor adesão aos tratamentos        |
| Políticas Públicas e Regulação | Implementar políticas baseadas em evidências para fortalecer a governança e a regulação dos serviços de reabilitação. |
| Atenção Primária e Prevenção   | Integrar a reabilitação nos serviços de atenção primária para facilitar o acesso precoce aos cuidados                 |
| Mobilidade e Transporte        | Garantir transporte acessível para pessoas com deficiência chegarem aos serviços de saúde                             |
| Monitoramento e Avaliação      | Desenvolver indicadores de qualidade e avaliações periódicas para medir a efetividade dos serviços prestados          |

O Plano de Melhorias foi desenvolvido com todos estes constituintes, constituiu-se como um guia para a implementação de melhorias, bem como para a avaliação das melhorias implementadas.

#### 4. COMPONENTES DO CFIR

A implementação será estruturada com base nos cinco domínios do CFIR: 1. Características da Intervenção; 2. Características Internas; 3. Características Externas; 4. Características dos Indivíduos Envolvidos; 5. Processo de Implementação.

##### 1. Características da Intervenção

As propriedades da intervenção que podem facilitar ou dificultar a sua implementação, incluindo a complexidade, a adaptabilidade e a força da evidência.

- Fonte da Evidência: foi possível apresentar propostas de implementação parciais antes da finalização da revisão de escopo, pois o estudo também está respaldado pelas políticas nacionais sobre cuidados à pessoa com deficiência. Desta forma, as propostas parciais serão melhoradas por estudos, encontrados na revisão, que apresentarem boas práticas relacionadas a implementação da rede.

- Complexidade: Embora a implementação envolva múltiplas ações integração da rede, padronização de fluxos, capacitação de profissionais, e outras, essas mudanças são vistas como viáveis, com impacto positivo esperado na eficiência da rede de cuidados.

- Adaptabilidade: As estratégias, que serão apresentadas, poderão ser ajustadas de acordo com os recursos e particularidades de cada ponto de atenção da rede em Lagoa Santa, em outro município ou estado do país. Percebo que após findar a revisão de escopo será possível indicar sua adaptabilidade em contextos internacionais.

##### 2. Características Internas

Fatores internos de organização e de rede de serviços que podem afetar a implementação, como cultura organizacional, infraestrutura e comunicação interna.

- Cultura Organizacional: A rede de saúde de Lagoa Santa apresenta forte tradição de manter individualizado cada ponto de atenção, o que piora com a ausência de estratégias formais para comunicação e integração interdisciplinar. A padronização dos fluxos de trabalho, por meio de protocolos bem definidos, ajudará a superar barreiras culturais e operacionais.

- Recursos: A implementação de sistemas de informação para melhorar a comunicação entre os profissionais será um desafio devido à infraestrutura tecnológica limitada. No

entanto, a secretaria de saúde iniciou o processo e apresenta-se disposta a investir em tecnologia e capacitação.

- **Prontidão para a Implementação:** Há apoio da gestão local para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência, padronização dos fluxos, a criação de ambientes adequados para o atendimento infantil, capacitação, e a capacitação em comunicação interdisciplinar.

### 3. Características Externas

Fatores externos à rede, como políticas públicas, pressão externa e necessidades da comunidade.

- **Necessidades da Comunidade:** Famílias cobram, inclusive por meio de ações no Ministério Público, o fim da demanda reprimida, apresentam a necessidade de ambientes de atendimento mais acolhedores e lúdicos, além de educação em saúde para melhorar o desenvolvimento infantil.

- **Pressão Política e Regulatória:** As políticas de atenção à pessoa com deficiência no Brasil, como o Plano Viver sem Limite e as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (incluir novas, 2024), impulsionam a implementação dessas mudanças.

### 4. Características dos Indivíduos Envolvidos

Refere-se aos profissionais de saúde e à sua capacidade, conhecimento e atitude em relação à implementação da intervenção.

- **Capacitação e Empatia:** Será necessário um programa de treinamento para capacitar os profissionais de saúde em conhecimentos técnicos, comunicação interdisciplinar e no desenvolvimento de empatia para atendimento de pessoas com deficiência.

- **Atitudes e Crenças:** Muitos profissionais reconhecem a importância de implementar melhorias para a rede. A avaliação da POM trará respostas sobre a prontidão dos profissionais para as mudanças que serão implementadas.

### 5. Processo de Implementação

Estratégias para garantir o sucesso da implementação, incluindo planejamento, execução e monitoramento.

- **Planejamento:** Será necessário a criação de um grupo de trabalho interdisciplinar para planejar e coordenar as ações. O grupo será composto por gestores, profissionais de saúde e representantes do usuário.
- **Treinamento em Comunicação Interdisciplinar:** Um treinamento focado em comunicação eficaz entre diferentes áreas de atuação será oferecido a todos os profissionais envolvidos. O objetivo é garantir que os fluxos de trabalho padronizados sejam compreendidos e seguidos por todos.
- **Sistemas de Informação:** A efetivação do novo sistema de informação, já implantado, será crucial para a integração da rede de cuidados. Isso permitirá a troca eficiente de dados entre diferentes unidades de atendimento e facilitará a continuidade dos cuidados para pessoas com deficiência. O deslocamento de um profissional para acompanhar as diversas fontes geradoras de informações será indispensável para o alcance de dados fidedignos.
- **Padronização e Divulgação dos Fluxos:** Os fluxos de atendimento padronizados serão estabelecidos e amplamente divulgados entre os profissionais, garantindo que todos saibam como proceder em diferentes cenários de atendimento.
- **Adequação do Espaço para Atendimento Infantil:** As unidades de atendimento serão adaptadas para incluir espaços lúdicos com paredes coloridas, brinquedos, jogos e livros infantis. Isso criará um ambiente mais acolhedor para crianças com deficiência.
- **Educação em Saúde para Familiares:** Serão realizadas oficinas, campanhas e produção de materiais educativos para famílias.

Serão percorridas na sequência as propostas para implementação das melhorias, prioritárias, identificadas pelos stakeholders.

## 5. PLANO DE MELHORIAS

- **Plano de Melhorias comunicação e a integração na rede de saúde**

Melhorar a comunicação e a integração na rede de saúde é essencial para garantir que os serviços sejam eficientes e bem coordenados entre diferentes níveis de atenção. A Implementação de sistemas de informação interoperáveis, a interoperabilidade entre diferentes sistemas de informação em saúde é crucial para integrar e compartilhar informações dentro da rede:

➤ O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) integrado: que permite a visualização e atualização do histórico de saúde em tempo real.

➤ Integração de dados: entre atenção primária, secundária e terciária, evitando duplicação de exames, erros, e atrasos no tratamento.

Uso de ferramentas de comunicação instantânea e plataformas colaborativas, ferramentas que permitem uma comunicação direta e rápida entre os profissionais de saúde, como plataformas de mensagens seguras, podem facilitar o compartilhamento de informações de maneira ágil:

➤ Aplicativos como WhatsApp Business: (com medidas de segurança de dados em conformidade com a LGPD) podem ser adaptados para o ambiente de saúde, facilitando a comunicação entre profissionais. Evitando o uso de aparelhos e WhatsApp do profissional.

➤ Portais colaborativos: como o Microsoft Teams que permitem reuniões remotas e a troca de informações e documentos de forma organizada.

➤ Ampliar o uso da Telemedicina e Telessaúde: esses serviços não apenas ampliam o alcance da assistência médica, mas também facilitam a consulta e comunicação entre diferentes níveis de cuidado.

A capacitação e treinamento em comunicação interdisciplinar para garantir uma comunicação eficiente, é essencial investir em treinamento interdisciplinar.

➤ Treinamento contínuo dos profissionais de saúde em práticas de comunicação clara: Ferramentas como SBAR (Situação, Contexto, Avaliação e Recomendação) podem ser úteis para melhorar a transferência de informações entre equipes.

➤ Reuniões clínicas, multiprofissional: regulares e interativas para discussão de casos, alinhamento de protocolos e decisões de tratamento e condutas colaborativas.

➤ Criação de grupos de trabalho (GT): com participação ativa de gestores, profissionais de saúde e representantes de pacientes, para garantir que os processos de comunicação sejam revisados e melhorados continuamente.

Criação de protocolos unificados de atendimento e fluxos de trabalho, estabelecimento e divulgação de protocolos padronizados e fluxos de trabalho ajudam a garantir que todos os níveis de atenção dentro da RCPD estejam alinhados:

➤ Protocolos clínicos: baseados em melhores práticas e evidências científicas, permitem que os profissionais saibam como proceder em cada situação e quando encaminhar o paciente para níveis mais especializados.

➤ Planos de cuidados integrados: que detalham a trajetória de atendimento do paciente e promovam o engajamento de todos os profissionais envolvidos, podem ser úteis para evitar duplicidade de ações ou tratamentos/reabilitações incoerentes.

Melhoria na governança e gestão da RCPD, a governança colaborativa é essencial para assegurar que todos os pontos da rede de saúde estejam bem coordenados:

➤ Centralização da gestão de informação: por meio de plataformas como o e-SUS e/ou outros sistemas de saúde, garantindo o monitoramento contínuo de fluxos e permitindo ajustes conforme a demanda. O município de Lagoa Santa aderiu recentemente o Sistema de Regulação – SISREG do Ministério da Saúde.

➤ Estabelecimento de mecanismos de feedback e auditorias contínuas: com uso de indicadores de desempenho para identificar falhas na comunicação ou na integração dos serviços. Participação ativa dos usuários no processo de comunicação, o empoderamento do indivíduo e sua participação ativa no cuidado de sua saúde ajudam a melhorar a eficiência da rede:

➤ Propiciar a educação em saúde da PCD e seu cuidador: para que compreendam sua condição e saibam como transitar pela RCPD de forma mais eficiente, reduzindo o número de idas desnecessárias aos serviços e melhorando o autocuidado.

Tecnologias de Saúde Digital e Inteligência Artificial o uso de inteligência artificial (IA) e outras ferramentas de automação pode melhorar a comunicação e a tomada de decisões na rede de saúde:

➤ Sistemas de suporte à decisão clínica: Aplicativos podem ajudar os profissionais a tomar decisões mais rápidas e informadas, reduzindo erros e agilizando o atendimento. Como por exemplo o TEDI. O TEDI é um aplicativo para triagem de alterações do desenvolvimento e comportamento de crianças de 1 a 65 meses e de fatores de risco no contexto familiar. Um trabalho da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), já validado. <https://tedi.medicina.ufmg.br>

- Plano de Melhorias para aprimorar a capacitação dos profissionais e estimular a empatia no atendimento ao público com deficiência (PCD).

A criação de um programa de educação permanente é essencial para garantir que os profissionais da saúde se mantenham atualizados com as melhores práticas no cuidado à PCD. Isso pode incluir:

➤ Treinamentos regulares interdisciplinares: sobre diagnóstico e intervenção precoce, especialmente voltados à prevenção de deficiências e acompanhamento de transtornos do neurodesenvolvimento. O Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA) já oferece um excelente modelo, e ele pode ser ampliado para incluir novos protocolos terapêuticos.

➤ Uso de tecnologias assistivas e adaptações no atendimento: com foco em acessibilidade comunicacional, como a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e outras formas de comunicação alternativa. A formação técnica deve ser complementada com o desenvolvimento de competências emocionais, principalmente a empatia, que é fundamental para a humanização do atendimento. Isso pode ser alcançado por meio de:

➤ Treinamentos em inteligência emocional: e abordagens centradas no paciente, estimulando a compreensão das experiências e desafios vividos por pessoas com deficiência.

➤ Sessões de simulação realística: que permitam aos profissionais vivenciar situações cotidianas do ponto de vista de uma pessoa com deficiência, como limitações de mobilidade, comunicação e acesso ao ambiente.

➤ Criação de diretrizes locais para o atendimento inclusivo: que abordem a importância de ambientes acessíveis, com foco em barreiras arquitetônicas, tecnológicas e atitudinais.

➤ Adoção de um modelo de cuidado centrado na pessoa: onde os profissionais de saúde e demais setores estabeleçam planos de cuidado personalizados, respeitando as especificidades e capacidades individuais de cada PCD.

➤ Estímulo à participação das famílias e da comunidade: no processo de atendimento e reabilitação, garantindo um suporte integral que envolva a rede de apoio da pessoa com deficiência. Implementar um programa onde a capacitação técnica e o desenvolvimento da empatia estejam alinhados, promovendo não apenas a saúde física, mas o bem-estar psicológico e social dos usuários.

- Plano de Melhorias para Padronização dos Fluxos de Atendimento na RCPD

A padronização dos fluxos de atendimento é essencial para garantir a continuidade e a integralidade do cuidado. A estratégia proposta envolve a criação de protocolos clínicos e diretrizes operacionais que devem ser amplamente disseminados na rede. Etapas para padronização dos fluxos:

➤ Mapeamento dos processos existentes: a partir do diagnóstico situacional e mapeando apresentados é possível identificar gargalos e oportunidades de melhoria.

➤ Desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências: elaborar guias e protocolos clínicos padronizados. As diretrizes devem ser construídas em colaboração com equipes multiprofissionais, garantindo uma abordagem integral.

➤ Adoção de um modelo de cuidado centrado na pessoa: onde os profissionais de saúde e demais setores estabeleçam planos de cuidado personalizados, respeitando as especificidades e capacidades individuais de cada PCD.

➤ Estímulo à participação das famílias e da comunidade: no processo de atendimento e reabilitação, garantindo um suporte integral que envolva a rede de apoio da pessoa com deficiência. Implementar um programa onde a capacitação técnica e o desenvolvimento da empatia estejam alinhados, promovendo não apenas a saúde física, mas o bem-estar psicológico e social dos usuários.

- Plano de Melhorias para Padronização dos Fluxos de Atendimento na RCPD

A padronização dos fluxos de atendimento é essencial para garantir a continuidade e a integralidade do cuidado. A estratégia proposta envolve a criação de protocolos clínicos e diretrizes operacionais que devem ser amplamente disseminados na rede. Etapas para padronização dos fluxos:

➤ Mapeamento dos processos existentes: a partir do diagnóstico situacional e mapeando apresentados é possível identificar gargalos e oportunidades de melhoria.

➤ Desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências: elaborar guias e protocolos clínicos padronizados. As diretrizes devem ser construídas em colaboração com equipes multiprofissionais, garantindo uma abordagem integral.

- Treinamento Contínuo dos Profissionais de Saúde e da Rede Intersetorial.

A capacitação contínua é necessária para garantir que os profissionais estejam aptos a executar as diretrizes padronizadas e para melhorar a articulação entre os diferentes níveis de cuidado.

➤ Programas de educação permanente: desenvolver um plano de capacitação para profissionais da saúde, educação e assistência social, com base na Educação Permanente em Saúde. Este treinamento deve incluir conteúdos como: manejo de casos de PCD, ferramentas

de comunicação inclusiva (como Libras), uso de tecnologias assistivas e trabalho interdisciplinar.

➤ Simulações práticas e estudos de caso: simulações práticas e análises de estudos de caso reais para que os profissionais possam aplicar os protocolos padronizados em situações realistas.

➤ Monitoramento e feedback contínuo: estabelecer um sistema de avaliação contínua, que inclua supervisão e feedback dos gestores da saúde para garantir a aplicação prática das diretrizes e identificar áreas que precisam de ajustes.

- Divulgação e Engajamento da Comunidade e dos Profissionais:

A divulgação dos fluxos e protocolos padronizados é essencial para assegurar que toda a rede e a comunidade estejam alinhadas com os novos processos. A comunicação clara e o engajamento ativo da população são fatores-chave para o sucesso da implementação.

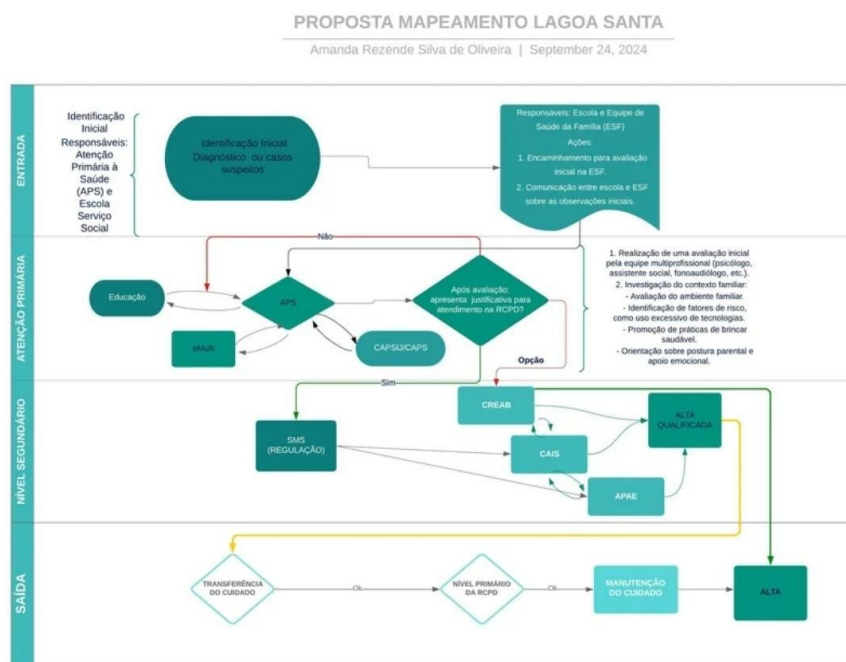
➤ Estratégias de divulgação e engajamento: campanhas informativas e educativas, campanhas de conscientização sobre a RCPD e os novos fluxos de atendimento, utilizando mídias locais, redes sociais e parcerias comunitárias. Essas campanhas devem ser voltadas tanto para os profissionais quanto para a população em geral, esclarecendo o papel de cada serviço e como acessar a rede de cuidados.

➤ Criação de materiais didáticos e manuais operacionais: Desenvolver manuais e guias ilustrativos com os novos protocolos, voltados para o público e os profissionais, com linguagem acessível. Esses materiais podem ser distribuídos digitalmente ou fisicamente nas unidades de saúde e demais serviços da RCPD.

➤ Engajamento da rede intersetorial: Estabelecer encontros periódicos entre os profissionais da saúde, educação e assistência social para garantir o alinhamento intersetorial. Essas reuniões podem servir como espaço de troca de experiências, identificação de desafios e aprimoramento das práticas colaborativas.

A implementação das estratégias mencionadas permitirá a Lagoa Santa otimizar o atendimento às pessoas com deficiência, garantindo maior eficiência na rede de cuidados e promovendo um ambiente de acolhimento e humanização.

Considerando todos estes elementos, foi elaborada uma proposta de melhoria no fluxograma, a ser incorporada nos documentos oficiais da Secretaria de Saúde do município de Lagoa Santa (Figura 1).



Fonte: a própria autora, 2024. Figura 1. Proposta de Melhorias no Mapeamento Gerencial da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

- Plano de Melhorias para Adequar os Espaços Físicos de Atendimento Infantil

Tornar os ambientes mais lúdicos e inclusivos para o cuidado de crianças com deficiência.

- Adaptação Física e Sensorial dos Espaços:

A adequação dos espaços deve garantir a acessibilidade completa, promovendo a inclusão física e sensorial de todas as crianças, independentemente de suas deficiências.

➤ **Acessibilidade física:** As áreas de circulação devem ser projetadas com rampas, corrimãos e pisos antiderrapantes, além de portas largas para facilitar o acesso de cadeiras de rodas.

➤ **Adaptação sensorial:** Para crianças com deficiência visual ou auditiva, os ambientes devem ser enriquecidos com contrastes de cores, sinalizações em Braille, e sinalizações visuais e auditivas. Além disso, os espaços devem contar com áreas de baixa estimulação sensorial para crianças com transtorno do espectro autista, proporcionando locais de descanso e relaxamento.

- **Inclusão de Elementos Lúdicos e Interativos:**

Ambientes lúdicos promovem o bem-estar, facilitam o desenvolvimento cognitivo e emocional e estimulam a participação da criança com o processo de cuidado. As áreas de atendimento infantil devem ser projetadas de modo que as crianças sejam incentivadas a explorar, interagir e aprender.

➤ **Espaços temáticos:** incorporar áreas temáticas com elementos visuais que atraiam o interesse das crianças, como painéis sensoriais, paredes interativas com texturas e cores vibrantes, e brinquedos acessíveis.

➤ **Brinquedos adaptados e interativos:** disponibilizar brinquedos que sejam acessíveis a todas as crianças, como blocos de montar com texturas diferentes, jogos interativos para crianças com limitações motoras, e brinquedos sonoros para deficientes visuais. A inclusão de recursos tecnológicos, como tablets com aplicativos educativos inclusivos, também é recomendada.

- **Parques lúdicos inclusivos:**

Criar áreas de recreação adaptadas com brinquedos inclusivos (balanços para cadeirantes, gangorras com apoio) e elementos de movimento que estimulam o desenvolvimento motor e cognitivo. Esses espaços devem ser seguros e projetados para promover a socialização entre as crianças com e sem deficiência.

➤ Espaços de convivência para as famílias: a criação de salas de espera acolhedoras e interativas, com materiais educativos e informativos sobre o desenvolvimento infantil e cuidados à pessoa com deficiência, pode promover maior envolvimento dos familiares.

➤ Programas comunitários e atividades recreativas inclusivas: Organizar oficinas, atividades recreativas e eventos comunitários que envolvam crianças, famílias e profissionais. Isso promove a conscientização e o fortalecimento do suporte social em torno da criança com deficiência.

A criação de ambientes lúdicos e inclusivos para o atendimento infantil a pessoas com deficiência em Lagoa Santa, Minas Gerais, requer uma abordagem integrada entre adaptações físicas e sensoriais, elementos lúdicos interativos, e envolvimento familiar e comunitário.

- Plano de Melhorias para Implementar Estratégias de Educação em Saúde Voltadas aos Familiares

A capacitação familiar é fundamental para garantir que os cuidadores compreendam as fases do desenvolvimento infantil e como contribuir para o progresso de suas crianças típicas ou atípicas.

➤ Grupos de Educação em Saúde para pais e cuidadores: criar programas regulares de capacitação, com sessões presenciais e virtuais, onde especialistas (psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais e outros) discutam o desenvolvimento infantil, marcos de crescimento, e como identificar sinais de atraso ou problemas relacionados às neurodivergências.

➤ Orientação prática: Oferecer oficinas práticas para familiares com foco no uso de atividades simples e rotineiras que estimulam o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Isso pode incluir dicas sobre como transformar tarefas diárias em oportunidades de aprendizado.

- Incentivo a Práticas de Estímulo e Tempo de Qualidade

O estímulo ao desenvolvimento infantil não deve ser restrito ao ambiente clínico ou escolar. É essencial que as famílias entendam a importância do tempo de qualidade, utilizando momentos cotidianos para incentivar o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional.

➤ Sessões de estimulação sensorial e interação: realizar oficinas de estimulação sensorial voltadas aos familiares, mostrando como diferentes materiais (como tecidos, brinquedos sonoros e objetos texturizados) podem ser utilizados em casa para estimular as habilidades sensoriais e motoras das crianças.

➤ Tempo de qualidade e vínculos afetivos: promover encontros onde profissionais de saúde expliquem o impacto do tempo de qualidade no desenvolvimento infantil, especialmente no vínculo emocional entre pais e filhos. A participação ativa nas brincadeiras, a leitura conjunta e as interações constantes com a criança ajudam a promover o bem-estar e o progresso no desenvolvimento.

- Orientações sobre o Uso Consciente de Telas e Promoção do Brincar Livre

A exposição excessiva a telas na infância tem sido associada a atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor. Para evitar isso, é essencial educar os pais sobre a importância do brincar livre, sem o uso de dispositivos eletrônicos.

➤ Campanhas educativas sobre os riscos do uso excessivo de telas: desenvolver uma série de materiais educativos (cartilhas, vídeos e postagens em redes sociais) alertando os pais sobre os impactos negativos do tempo excessivo em frente a telas, como diminuição da interação social e atraso no desenvolvimento da linguagem.

➤ Promoção do brincar livre: incluir nas sessões educativas discussões sobre o valor do brincar livre, mostrando como atividades simples e não estruturadas podem promover a criatividade, a socialização e o desenvolvimento motor. As famílias devem ser incentivadas a criar espaços seguros em casa para o brincar livre, e a explorar brinquedos que não dependam de tecnologia.

Ao longo da avaliação do cenário, para implementações de melhorias, observou-se a necessidade de implementar estratégias de educação em saúde para os familiares sobre o desenvolvimento infantil. Percebeu-se a relevância de empoderar as famílias com conhecimentos práticos e evidências científicas, para garantir o desenvolvimento adequado das crianças, minimizar diagnósticos equivocados e medicalizações desnecessárias (figura 2).



Figura 2. Folder da campanha Estímulo ao tempo de qualidade e o brincar sem telas, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, 2024.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. Venda proibida.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da Enfermeira Amanda Rezende Silva de Oliveira

## CONTATOS

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br)

Tel.: (31) 3688-1300

## ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO TÉCNICA

Amanda Rezende Silva de Oliveira, Maithê de Carvalho e Lemos Goulart

## REVISÃO TÉCNICA

## FICHA CATALOGRÁFICA

Lagoa Santa. Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Secretaria Municipal de Saúde.  
Plano de Melhoria da Qualidade para RCPD do Município de Lagoa Santa, 2024.

Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial- MPEA

Amanda Rezende Silva de Oliveira

2024

## REFERÊNCIAS

1. Aenishänslin J, Amara A, Magnusson L. Experiences accessing and using rehabilitation services for people with physical disabilities in Sierra Leone. *Disabil Rehabil.* [Internet]. 2020 [cited 2025 Jan 1]; 44(1): 34-43. Available from: 10.1080/09638288.2020.1755375.
2. Al Imam MH, Jahan I, Das MC, Muhit M, Akbar D, Badawi N, et al. Situation analysis of rehabilitation services for persons with disabilities in Bangladesh: identifying service gaps and scopes for improvement. *Disabil Rehabil.* [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 10]; 44(19): 5571-5584. Available from: 10.1080/09638288.2021.1939799.
3. Amorim EG, Liberali R, Medeiros OM Neta. Avanços e desafios na atenção à saúde de pessoas com deficiência na atenção primária no Brasil: uma revisão integrativa. *Holos.* [Internet]. 2018 [acesso em 2024 Dez 26]; 1: 224-236. Disponível em: 10.15628/holos.2018.5775.
4. Balogh R, McMorris CA, Lunskey Y, Ouellette-Kuntz H, Bourne L, Colantonio A, et al. Organising healthcare services for persons with an intellectual disability. *Cochrane Database Syst Rev.* [Internet]. 2016 [cited 2025 Jan 09]; 4(4): CD007492. Available from: 10.1002/14651858.CD007492.
6. Carneiro JD. Rede de cuidados à pessoa com deficiência: o direito à saúde bucal e a implementação da assistência odontológica especializada [Tese]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2023.
7. Castro AM. Rede formal, rede invisível e rede existencial: encontros cartográficos nas múltiplas redes de cuidado às pessoas com deficiência em uma capital brasileira [Dissertação]. Campo Grande: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 2021.
8. Collins PY, Pringle B, Alexander C, Darmstadt GL, Heymann J, Huebner G, et al. Global services and support for children with developmental delays and disabilities: Bridging research and policy gaps. *PLoS Med.* [Internet]. 2017 [cited 2025 Jan 10]; 14(9): e1002393. Available from: 10.1371/journal.pmed.1002393.
9. Condessa AM, Lucena EH, Figueiredo N, Goes PS, Hilgert JB. Atenção odontológica especializada para pessoas com deficiência no Brasil: perfil dos centros de especialidades odontológicas, 2014. *Epidemiol Serv Saúde.* [Internet]. 2020 [acesso em 2025 Jan 10]; 29(5): e2018154. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-49742020000500001>.
10. Coughlin TA, Long SK, Graves JA. Does Managed Care Improve Access to Care for Medicaid Beneficiaries with Disabilities? A national study. *Inquiry.* [Internet]. 2008 [cited 2025 Jan 11]; 45(4): 395-407. Available from: 10.5034/inquiryjrnl\_45.04.395.
11. Dassah E, Aldersey HM, McColl MA, Davison C. Health care providers' and persons with disabilities' recommendations for improving access to primary health care services

- in rural northern Ghana: A qualitative study. PLoS One. [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 10]; 17(9). Available from: 10.1371/journal.pone.0274163.
12. Deutsche Vereinigung für Rehabilitation. Lösungsmöglichkeiten der DVFR zur Überwindung von Problemen bei der Versorgung mit Hilfsmitteln [Internet]. 2009 [cited 2025 Jan 10]. Disponível em: <https://www.dvfr.de/rehabilitation-und-teilhabe/meldungen-aus-der-reha-landschaft/detail/artikel/loesungsoptionen-der-dvfr-zur-ueberwindung-von-problemen-bei-der-versorgung-mit-hilfsmitteln>.
  13. Dhakal R, Groves CC. Rehabilitation in Nepal. Phys Med Rehabil Clin N Am. [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 10]; 30(4): 787-794. Available from: 10.1016/j.pmr.2019.07.004.
  14. Dupuis F, Déry J, Lucas de Oliveira FC, Pecora AT, Gagnon R, Harding K, et al. Strategies to reduce waiting times in outpatient rehabilitation services for adults with physical disabilities: A systematic literature review. J Health Serv Res Policy. [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 10]; 27(2): 157-167. Available from: 10.1177/13558196211065707.
  15. Elisei S, Camanni G, Di Maolo F. Improving health care accessibility for people with complex disabilities. Psychiatr Danub. [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 11]; 33(Suppl 1): 96-99. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34862900/>.
  16. Evaristo TC. Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: Avaliação no Contexto Brasileiro [Dissertação]. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2018.
  17. Figaro FB. Mulheres em cadeira de rodas e a relação com a deficiência adquirida: problemas, superações e possibilidades [Dissertação]. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo; 2022.
  18. Frontera WR. The World Health Organization disability action plan. Am J Phys Med Rehabil. [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 10]; 93(9): 737. Available from: 10.1097/PHM.0000000000000183.
  19. Guzman JM, Salazar EG. Disability and rehabilitation in Mexico. Am J Phys Med Rehabil. [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 11]; 93(1 Suppl 1): S36-8. Available from: 10.1097/PHM.0000000000000019.
  20. Heslop P, Turner S, Read S, Tucker J, Seaton S, Evans B. Implementing reasonable adjustments for -disabled people in healthcare services. Nurs Stand. [Internet]. 2019 [cited 2025 Jan 10]; 34(8): 29-34. Available from: 10.7748/ns.2019.e11172.
  21. Issa FM. Acesso à rede de cuidados em saúde da pessoa com deficiência em um município de fronteira [Dissertação]. Foz do Iguaçu: Universidade Estadual do Oeste do Paraná; 2022.
  22. Kavanagh A, Dickinson H, Carey G, Llewellyn G, Emerson E, Disney G, et al. Improving health care for disabled people in COVID-19 and beyond: Lessons from

- Australia and England. *Disabil Health J.* [Internet]. 2021 [cited 2025 Jan 11]; 14(2): 101050. Available from: 10.1016/j.dhjo.2020.101050.
23. Khan F, Amatya B, Mannan H, Burkle FM Junior, Galea MP. Rehabilitation in Madagascar: Challenges in implementing the World Health Organization Disability Action Plan. *J Rehabil Med.* [Internet]. 2015 [cited 2025 Jan 10]; 47(8): 688-96. Available from: 10.2340/16501977-1995.
  24. Kronfol NM. Health services to groups with special needs in the Arab world: a review. *East Mediterr Health J.* [Internet]. 2012 [cited 2025 Jan 10]; 18(12): 1247-1253. Available from: 10.26719/2012.18.12.1247.
  25. Lagu T, Iezzoni LI, Lindenauer PK. The axes of access--improving care for patients with disabilities. *N Engl J Med.* [Internet]. 2014 [cited 2025 Jan 10]; 370(19): 1847-51. Available from: 10.1056/NEJMSb1315940.
  26. Lehman WE, Greener JM, Simpson DD. Assessing organizational readiness for change. *J Subst Abuse Treat.* [Internet]. 2002 [cited 2024 Dez 03]; 22(4): 197–209. Available from: 10.1016/s0740-5472(02)00233-7.
  27. Pereira RP. Eficácia clínica e prática baseada em evidências: avaliação de atitudes, competências e práticas. Repositório UM. Portugal: Editora Científica; 2021.
  28. Rampazzo L, De Angeli M, Serpelloni G, Simpson DD, Flynn PM. Italian survey of organizational functioning and readiness for change: a cross-cultural transfer of treatment assessment strategies. *Eur Addict Res.* [Internet]. 2006 [cited 2024 Nov 28]; 12(4): 176-181. Available from: 10.1159/000094419.
  29. Sandel ME, Appelman J, Kotch MJ, Biter-Mundt G, Lal N, Samuels S, et al. The California Kaiser Permanente Health System: Evolving to meet the needs of people with disabilities. *Disabil Health J.* [Internet]. 2010 [cited 2024 Dez 12]; 3(4): 240-244. Available from: 10.1016/j.dhjo.2010.07.003.
  30. Sharby N, Martire K, Iversen MD. Decreasing health disparities for people with disabilities through improved communication strategies and awareness. *Int J Environ Res Public Health.* [Internet]. 2015 [cited 2024 Nov 28]; 12(3): 3301-3316. Available from: 10.3390/ijerph120303301.
  31. Skempes D, Kiekens C, Malmivaara A, Michail X, Bickenbach J, Stucki G. Supporting government policies to embed and expand rehabilitation in health systems in Europe: A framework for action. *Health Policy.* [Internet]. 2022 [cited 2025 Jan 28]; 126(3): 158-172. Available from: 10.1016/j.healthpol.2021.06.014.
  32. Sousa AR, Santos GL, Salbego C, Santana TS, Félix ND, Santana RF, et al. Management technology for implementing the Systematization of Nursing Care. *Rev. Esc. Enferm. USP.* [Internet]. 2022 [cited 2023 Mai 17]; 56: e20220028. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0028en>.

## APÊNDICE F

### **PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA: TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO**

1ª Edição

Lagoa Santa/MG, 2024

2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA SANTA.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. Venda proibida. Versão eletrônica.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa.

## ELABORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E INFORMAÇÕES

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa Secretaria Municipal de Saúde

Av. Acadêmico Nilo Figueiredo, 2500 – Santos Dumont Lagoa Santa / MG

CEP: 33239-308

## CONTATOS

[www.lagoasanta.mg.gov.br](http://www.lagoasanta.mg.gov.br) Tel.:

(31) 3688-1300

## ORGANIZAÇÃO E EDIÇÃO TÉCNICA

Amanda Rezende Silva de Oliveira

## REVISÃO TÉCNICA

Rosielen dos Reis Medeiros de Meireles, Arianne Antunes de Souza Oliveira da Silva,  
Breno Aparecido Costa, Mariane Cristina Rios Silveira Oliveira

## FICHA CATALOGRÁFICA

Lagoa Santa. Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Secretaria Municipal de Saúde.  
Protocolo de Atenção à Pessoa com Deficiência do Município de Lagoa Santa, 2024, p?

## **PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO**

Considerando o Decreto nº 4879, de 13 de Abril de 2023, que implementa a Política de Atenção a Pessoa com Deficiência no âmbito do Município de Lagoa Santa/MG;

Este documento visa regulamentar a concessão de atendimentos aos usuários do SUS residentes no município de Lagoa Santa e municípios pactuados. Todos os usuários estão sujeitos às normas, procedimentos e critérios constantes nesse documento.

NOTA: Faz-se necessário a leitura e conhecimento do Protocolo de Atendimento do Centro de Reabilitação (CREAB). O qual direciona os fluxos de atendimento às deficiências físicas no município.

### **NORMAS PARA ACESSAR O SERVIÇO**

- O tratamento será oferecido para os moradores da cidade de Lagoa Santa/MG e municípios pactuados.

- Documentação necessária:

Encaminhamento multiprofissional, avaliação multiprofissional, data da solicitação, carimbo e assinatura do profissional responsável.

Relatório e descrição detalhada da avaliação, intervenções, duração das intervenções e resultados alcançados de todos os profissionais e serviços envolvidos.

Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Cópia do comprovante de residência.

Cópia do documento de identificação pessoal (RG e CPF) do paciente e do seu responsável legal, quando for o caso.

É de responsabilidade do paciente ou responsável a atualização de dados cadastrais na sua Unidade Básica de Saúde (UBS), como endereço e telefone.

### **APRESENTAÇÃO/ CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE**

#### **Transtornos do Neurodesenvolvimento**

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes de a criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social,

acadêmico ou profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento; por exemplo, indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual), e muitas crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) apresentam também um transtorno específico da aprendizagem. No caso de alguns transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto de excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos esperados. Por exemplo, o transtorno do espectro autista somente é diagnosticado quando os déficits característicos de comunicação social são acompanhados por comportamentos excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistência nas mesmas coisas.

#### 1. Deficiências Intelectuais

Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Especificar a gravidade atual:

(F70) Leve

(F71) Moderada

(F72) Grave

(F73) Profunda

(F88) Atraso Global do Desenvolvimento

(F79) Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não Especificada.

#### 2. Transtornos da Comunicação

(F80.2) Transtorno da Linguagem

(F80.0) Transtorno da Fala

(F80.81) Transtorno da Fluência com Início na Infância (Gagueira) Nota: Casos com início tardio são diagnosticados como 307.0 (F98.5) transtorno da fluência com início na idade adulta.

(F80.89) Transtorno da Comunicação Social (Pragmática)

(F80.9) Transtorno da Comunicação Não Especificado

#### 3. Transtorno do Espectro Autista

(F84.0) Transtorno do Espectro Autista

Especificar se: associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental especificar a gravidade atual.

Exigindo apoio muito substancial

Exigindo apoio substancial

Exigindo apoio

Especificar se: Com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, com catatonia.

4. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Determinar o subtipo:

(F90.2) Apresentação combinada

(F90.0) Apresentação predominantemente desatenta

(F90.1) Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva Especificar a gravidade atual: Leve, Moderada, Grave.

(F90.8) Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado

(F90.9) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Não Especificado

Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção, que repercutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade, da forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da escola na qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território.

Considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD)

a. Autismo Infantil: caracteriza-se por um comprometimento das relações interpessoais e diversas alterações de comunicação, de linguagem e de comportamento, inclusive estereotípias motoras.

b. Síndrome de Rett: ausência de atividade funcional com as mãos, isolamento, regressão da fala e das habilidades motoras adquiridas, comprometimento das relações sociais, do desenvolvimento mental e microcefalia progressiva.

ENCAMINHAMENTOS PARA REABILITAÇÃO

- Para ter acesso ao serviço de reabilitação o paciente deverá encaminhar seu pedido à sua ESF ou ser encaminhado por sua ESF.
- A ESF deverá aceitar apenas encaminhamentos originais e preenchidos corretamente.
- O encaminhamento deverá ser realizado por profissionais da equipe multiprofissional, respeitando as áreas de reabilitação contempladas na rede municipal.
- Não serão aceitos encaminhamentos sem avaliação e intervenção multiprofissional, ou por solicitação do familiar sem critério clínico.
- Não serão aceitos: cópias de encaminhamentos, fichas de encaminhamentos preenchidas de forma ilegível, inadequadas, com dados insuficientes, rasuradas, danificadas, de tal forma, que dificultem a correta identificação das informações necessárias.
- Encaminhamentos de profissionais da rede privada deverão ser avaliados pelo médico da UBS de sua abrangência para avaliação e acompanhamento do caso;
- Não será permitida a inclusão de mais de um encaminhamento por paciente na fila de espera, sendo indicada neste caso a união dos encaminhamentos em duplicidade.

Na ESF o pedido será submetido, por enfermeiro ou médico à avaliação do neurodesenvolvimento. A avaliação do neurodesenvolvimento, juntamente com os demais documentos, serão levados pelo paciente no primeiro atendimento para o serviço especializado responsável por sua reabilitação.

## ESTRATIFICAÇÃO DOS CASOS E ENCAMINHAMENTOS DENTRO DA REDE

Fluxograma para Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Anexo 1).

### Passo 1: Identificação Inicial

Responsáveis: Atenção Primária à Saúde (APS) e Escola

Ações:

1. Observação inicial por parte dos professores e profissionais de saúde da APS.
2. Registro dos sinais e sintomas apresentados pela criança/adolescente.

### Passo 2: Encaminhamento Inicial

Responsáveis: Escola e Equipe de Saúde da Família (ESF)

Ações:

1. Encaminhamento para avaliação inicial na ESF.
2. Comunicação entre escola e ESF sobre as observações iniciais.

### Passo 3: Avaliação e Acompanhamento

Responsáveis: Escola, ESF e Equipe Multiprofissional

Ações:

1. Realização de uma avaliação inicial pela equipe multiprofissional (psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, etc.).
2. Investigação do contexto familiar:
  - Avaliação do ambiente familiar.
  - Identificação de fatores de risco, como uso excessivo de tecnologias.
  - Promoção de práticas de brincar saudável.
  - Orientação sobre postura parental e apoio emocional.

### Passo 4: Intervenções e Ações Conjuntas

Responsáveis: Escola, ESF e Equipe Multiprofissional

Ações:

1. Implementação de intervenções educativas e terapêuticas.
2. Acompanhamento contínuo e regular da criança/adolescente.
3. MatriciamenTo:
  - Apoio técnico e educacional para professores e profissionais da saúde.
  - Capacitação contínua dos profissionais envolvidos.
  - Monitoramento das ações implementadas.

### Passo 5: Reavaliação e Decisão sobre Encaminhamento

Responsáveis: Escola, ESF e Equipe Multiprofissional

Ações:

1. Reavaliação do progresso da criança/adolescente após intervenções.

2. Decisão conjunta sobre a necessidade de encaminhamento para serviços especializados.

#### Passo 6: Encaminhamento para Serviços Especializados

Responsáveis: ESF e equipe multiprofissional - via UBS

Ações:

1. Encaminhamento formal para serviços especializados se as intervenções anteriores não forem suficientes.
2. Coordenação do acompanhamento contínuo entre serviços especializados e equipe de atenção primária.

#### Considerações Finais

Importância da Comunicação e Integração:

- Manter comunicação contínua e integrada entre todos os atores envolvidos.
- Garantir que todas as etapas sejam bem documentadas e acompanhadas.

Envolvimento da Família:

- Assegurar o envolvimento ativo da família em todas as etapas do processo.
- Oferecer suporte e orientação contínua para os familiares.

#### Visualização do Fluxograma

1. Identificação Inicial → 2. Encaminhamento Inicial → 3. Avaliação e Acompanhamento → 4. Intervenções e Ações Conjuntas → 5. Reavaliação e Decisão sobre Encaminhamento → 6. Encaminhamento para Serviços Especializados (ANEXO 2).

Este fluxograma garante um cuidado integrado e contínuo, focado no bem-estar da pessoa com deficiência, com intervenções e acompanhamento adequados antes de recorrer aos serviços especializados.

- Usuários estratificados em grau de prioridade MUITO ALTA (NEONATO DE RISCO, DIAGNÓSTICO AO NASCIMENTO, ALTA e MÉDIA prioridade deverão ser encaminhados para reabilitação em nível secundário através da Regulação (CAIS, APAE e CREAB) com a guia do município, sendo necessário que o paciente passe por avaliações e intervenções pertinentes na APS antes de encaminhar.
- Pedidos particulares e de outras localidades seguem o mesmo critério, necessário que

o paciente passe por avaliações e intervenções pertinentes na APS antes de transcrever e/ou encaminhar.

- Cópia do documento de identidade (RG e CPF), cópia do comprovante de residência e cópia do cartão SUS (CNS).
- Usuários estratificados em grau de prioridade BAIXO deverão permanecer na UBS para análise do caso junto à eMulti e direcionamento para grupos.

#### GLOSSÁRIO:

- SUS (Sistema Único de Saúde): Sistema público de saúde no Brasil que oferece atendimento gratuito à população, com princípios de universalidade, integralidade e equidade.
- Municípios pactuados: Cidades que firmaram acordos de cooperação e prestação de serviços de saúde entre si.
- Encaminhamento multiprofissional: Documento emitido por diversos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, terapeutas, etc.), solicitando atendimento especializado para o paciente.
- CNS (Cartão Nacional de Saúde): Documento de identificação utilizado pelos usuários do SUS para acesso aos serviços de saúde.
- UBS (Unidade Básica de Saúde): Centros de atendimento primário que oferecem serviços preventivos, consultas e tratamentos básicos.
- Transtornos do Neurodesenvolvimento: Grupo de condições com início precoce no desenvolvimento infantil, caracterizado por déficits no desenvolvimento cognitivo, social ou motor.
- Deficiência Intelectual: transtorno no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, abrangendo áreas como aprendizado e habilidades práticas.
- TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade): Condição neuropsiquiátrica marcada por desatenção, hiperatividade e impulsividade.
- Transtorno do Espectro Autista (TEA): Transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, além de padrões de comportamento repetitivos.
- Síndrome de Rett: Distúrbio neurológico raro que afeta principalmente meninas, com regressão do desenvolvimento motor e da fala.

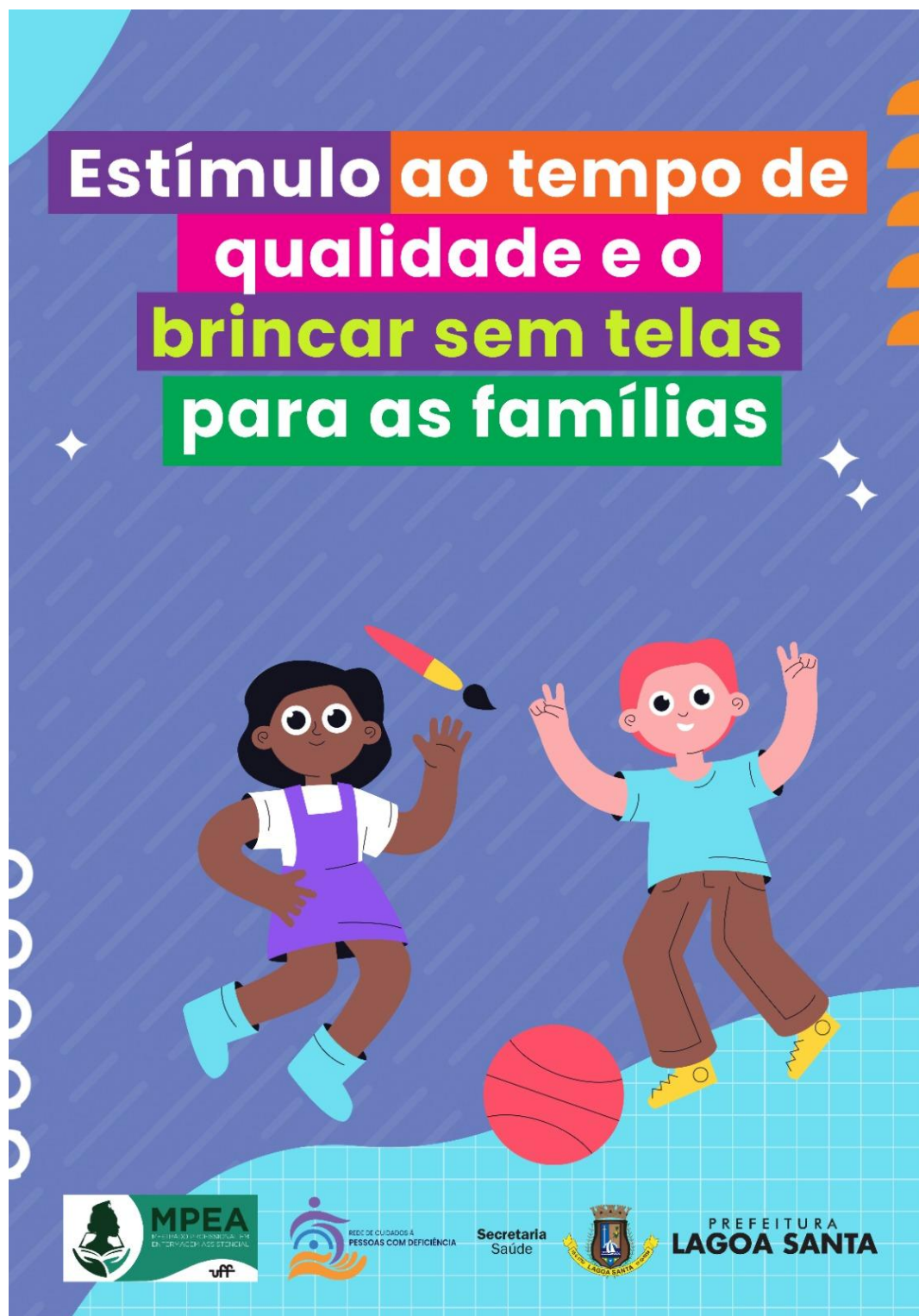
- ESF (Estratégia Saúde da Família): Modelo de atendimento do SUS voltado para a atenção primária, organizado em equipes multiprofissionais que acompanham as famílias em suas comunidades.
- APS (Atenção Primária à Saúde): O primeiro nível de contato da população com o sistema de saúde, oferecendo cuidados gerais e preventivos.
- Estratificação dos casos: Processo de categorização dos pacientes de acordo com a urgência e a gravidade do quadro clínico, priorizando o atendimento de acordo com a necessidade.
- eMulti: Abreviação usada para equipe multiprofissional, grupo de profissionais de diferentes áreas que atuam conjuntamente no atendimento de saúde.
- Neurodesenvolvimento: Processo pelo qual o sistema nervoso se desenvolve, influenciando as capacidades motoras, cognitivas e comportamentais do indivíduo.
- Prioridade Muito Alta, Alta, Média, Baixa: Termos usados para definir o grau de urgência no atendimento dos pacientes com base na gravidade do quadro clínico e na necessidade de intervenção imediata ou a longo prazo.

## REFERÊNCIAS

1. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Texto Revisado. Porto Alegre: Artmed, 2023.
2. BELO HORIZONTE, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Diretrizes para a Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência Intelectual na Rede de Reabilitação do SUS-BH. Belo Horizonte, 2019.
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a Rede de Atenção à Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2010. Seção 1, p. 89.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 793/GM/MS, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 abr. 2012
5. BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 18 nov. 2011.
6. BRASIL. Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

7. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Conjunta Nº 21, de 25 de Novembro de 2020. Anexo: Protocolo para diagnóstico etiológico da deficiência intelectual.
8. BRASIL. Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021. Dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 30 nov. 2021.
9. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Revisão da Política Nacional de Atenção Básica: Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
10. Merhy EE. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: Merhy EE & Onocko R (Orgs). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: HUCITEC; Buenos Aires: Lugar Editorial; 1997. (Saúde em debate n.108).
11. LAGOA SANTA (MG). Decreto nº 4879, de 13 de abril de 2023. Implementa a Política de Atenção à Pessoa com Deficiência no âmbito do Município de Lagoa Santa/MG. Diário Oficial do Município, Lagoa Santa, MG, 14 abr. 2023.
12. MINAS GERAIS. Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.272, de 24 de outubro de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no SUS/MG. Diário Oficial de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 25 out. 2012.
13. MINAS GERAIS. Deliberação CIB-SUS/MG Nº 1.404, de 19 de março de 2013, que institui o Programa de Intervenção Precoce Avançado – PIPA.
14. SBP - Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de Orientação: Transtorno do Espectro do Autismo. Vol. 5; Abril 2019.

## APÊNDICE G





## Dicas para o desenvolvimento saudável das crianças

- ★ Desconecte para reconectar: dê ao seu filho o presente da atenção plena longe das telas.
- ★ O brilho da tela não substitui o brilho dos olhos: priorize momentos reais para um crescimento saudável.
- ★ Cada toque na tela é um toque na alma: equilibre a tecnologia com carinho e presença.
- ★ Menos tempo de tela, mais tempo de brincar: construa um futuro mais feliz para seu filho com experiências reais.
- ★ O melhor aprendizado não está na tela, mas nos momentos compartilhados: invista na conexão real.
- ★ Desenvolvimento saudável começa fora da tela: encoraje seu filho a explorar o mundo ao seu redor.
- ★ Telinhas não substituem carinhos reais: dê ao seu filho o presente da interação genuína e da saúde emocional.



- ★ A imaginação floresce fora da tela: dê espaço para que seu filho brinque e descubra o mundo.
- ★ A tela pode ser uma fuga, mas a vida é uma aventura: incentive experiências que nutrem o crescimento emocional.
- ★ Conecte-se com seu filho além da tela: momentos de qualidade são a chave para um desenvolvimento saudável.



AMANDA REZENDE SILVA DE OLIVEIRA  
MAITHÊ DE CARVALHO  
LEMO GLOULART  
LEIDIANE FARIAS DE SOUSA



Saiba mais: (31) 3688-1360



Secretaria  
Saúde



PREFEITURA  
LAGOA SANTA

## Implementação de Melhorias na rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência

### Mestrado Profissional – MPEA/UFF

Projeto voltado à educação de pais e famílias do município de Lagoa Santa/ Minas Gerais, sobre a importância de reduzir o tempo de tela das crianças e promover o brincar de qualidade, bem como a oferta de tempo e atenção adequados aos filhos, visando a promoção da saúde física e emocional infantil.



## **APÊNDICE H**

### **RELATÓRIO SOBRE A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (RCPD) NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - MG**

Lagoa Santa/MG, 2024

## RELATÓRIO SOBRE A REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (RCPD) NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – MG

### 1. Introdução

Este relatório apresenta um panorama da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) em Lagoa Santa, Minas Gerais, destacando as etapas do fluxo de entrada, processo e saída, bem como os desafios enfrentados e medidas adotadas para aprimorar a gestão da rede.

---

### 2. Estrutura da RCPD em Lagoa Santa

A RCPD no município é composta pelos seguintes níveis de atenção:

- Atenção Primária à Saúde (APS): Porta de entrada da rede, com papel fundamental na identificação e encaminhamento dos casos.
- Regulação: Responsável por avaliar, priorizar e direcionar os pacientes para os serviços especializados.
- Serviços Especializados: Compreendem o Centro de Atenção Integrada à Saúde (CAIS), o Centro de Reabilitação (CREAB) e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

---

### 3. Etapas do Fluxo da RCPD

#### 3.1. Entrada na Rede

O acesso à RCPD inicia-se com a identificação ou suspeita de deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou distúrbios de aprendizagem, realizada pelos seguintes setores:

- Profissionais de saúde;
- Profissionais da educação;
- Profissionais do bem-estar social.

Procedimentos na etapa de entrada:

- O encaminhamento pode ocorrer a partir de dificuldades de aprendizado ou demandas sociais.
  - Todos os encaminhamentos devem passar obrigatoriamente pela APS, garantindo triagem qualificada e evitando sobrecarga nos serviços especializados.
  - É obrigatório o preenchimento do instrumento de avaliação do neurodesenvolvimento por médico ou enfermeiro da APS.
  - A regulação avalia, prioriza e encaminha o paciente ao serviço adequado.
- 

### 3.2.Processos dentro da Rede

Os serviços especializados recebem os pacientes conforme a classificação da regulação:

- CAIS: Atende casos de longa duração, deficiência intelectual, transtornos do neurodesenvolvimento e distúrbios de aprendizagem.
- CREAB: Recebe encaminhamentos diretamente nas unidades CREAB Várzea e CREAB Vila Maria, com regulação descentralizada conduzida por fisioterapeutas.
- APAE: Atua no atendimento especializado, reabilitação e no Programa de Intervenção Precoce Avançado (PIPA), voltado para neonatos de risco.

Atendimento Interdisciplinar nos Serviços Especializados:

- Profissionais envolvidos: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos generalistas, pediatras e neuropediatras.
  - Objetivo: Promoção da reabilitação, desenvolvimento de habilidades funcionais e autonomia do paciente.
- 

### 3.3.Saída da Rede

Atualmente, a RCPD enfrenta desafios na definição de critérios de alta dos serviços, o que resulta em:

- Permanência prolongada de alguns pacientes, sem necessidade real de continuidade.
- Aumento da fila de espera para novos atendimentos.

Necessidade de intervenção: Implementação de critérios objetivos para a conclusão do atendimento e otimização do fluxo de saída.

---

#### 4. Regulação e Capacidade dos Serviços

- Até julho de 2024, os encaminhamentos eram feitos por guias físicas. Desde agosto, utilizam o Sistema de Regulação do MS (SISREG), garantindo mais eficiência.
  - A APAE atende 152 crianças acima de dois anos e 09 neonatos de risco.
  - Desde outubro de 2023, a regulação atingiu o limite máximo da capacidade instalada para pacientes acima de dois anos, suspendendo novos encaminhamentos para essa faixa etária.
  - Neonatos de risco (0 a 24 meses) seguem sendo encaminhados e acompanhados.
- 

#### 5. Principais Desafios Identificados

- Falhas na execução das investigações e intervenções na APS, impactando o acesso aos serviços especializados.
  - Sobrecarga no CAIS devido ao grande volume de encaminhamentos.
  - Falta de critérios estruturados para a alta dos serviços especializados, resultando em aumento da demanda reprimida.
  - Limitação da capacidade instalada na APAE para pacientes acima de dois anos.
- 

6. Ações Implementadas e Recomendações Para otimizar a gestão da RCPD, foram desenvolvidos e publicados no Protocolo da Secretaria de Saúde:

- Novo desesho da distribuição dos serviços, visando melhor equilíbrio da demanda.
- Fluxograma de entrada, reforçando a obrigatoriedade da avaliação prévia pela APS.
- Implantação do SISREG, garantindo maior transparência e agilidade na regulação.
- Propostas de critérios de alta para os serviços especializados, a fim de evitar longas permanências e melhorar o fluxo de atendimento.

---

## 7. Conclusão

A RCPD de Lagoa Santa enfrenta desafios significativos, principalmente na APS e na regulação da capacidade dos serviços especializados. As medidas implementadas visam garantir um cuidado mais eficiente e integrado às PCDs, priorizando o acesso, a continuidade e a qualidade do atendimento.

Recomenda-se monitoramento contínuo das ações para garantir sua efetividade e ajustes necessários conforme a demanda do município.

Coloco-me à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou fornecer suporte adicional conforme necessário.

---

Amanda Rezende Silva de Oliveira

Referência da Política Municipal de Cuidado à Pessoa com Deficiência

## ANEXO 1 - AVALIAÇÃO DA PRONTIDÃO ORGANIZACIONAL PARA MUDANÇA (POM)

Categoria profissional: \_\_\_\_\_ Tempo de formação: \_\_\_\_\_ Tempo de atuação na RCPD: \_\_\_\_\_

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro Idade: \_\_\_\_\_

| <b>AVALIAÇÃO POM (Prontidão Organizacional para Mudança)</b><br><br>Responda as perguntas, baseando-se no serviço em que trabalha e nos fatores que podem ser facilitadores ou barreiras para aquisição do conhecimento | <b>Con<br/>corda<br/>Totalmente</b> | <b>Con<br/>corda<br/>parcialmente</b> | <b>Inde<br/>ciso</b> | <b>Disc<br/>orda</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>NECESSIDADES DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                                          |                                     |                                       |                      |                      |
| Seu serviço precisa de orientação/suporte adicional para:                                                                                                                                                               |                                     |                                       |                      |                      |
| 1- Avaliar as necessidades do cliente                                                                                                                                                                                   |                                     |                                       |                      |                      |
| 2- Utilizar serviços para atender às necessidades                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                      |                      |
| 3- Aumentar a participação dos clientes no programa de tratamento                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                      |                      |
| 4- Medir o desempenho do cliente.                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                      |                      |
| 5- Melhorar a qualidade das sessões em grupo                                                                                                                                                                            |                                     |                                       |                      |                      |
| 6- Melhorar a qualidade geral das orientações.                                                                                                                                                                          |                                     |                                       |                      |                      |
| 7- Usar avaliações de clientes para orientar decisões clínicas e do programa de tratamento.                                                                                                                             |                                     |                                       |                      |                      |
| 8- Usar as avaliações dos clientes para documentar a efetividade do programa de tratamento                                                                                                                              |                                     |                                       |                      |                      |
| <b>NECESSIDADES DO TREINAMENTO</b>                                                                                                                                                                                      |                                     |                                       |                      |                      |
| Você precisa de mais treinamento para:                                                                                                                                                                                  |                                     |                                       |                      |                      |

|                                                                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 9- Avaliar os problemas e as necessidades do cliente                                           |  |  |  |  |
| 10- Aumentar a participação do cliente no tratamento                                           |  |  |  |  |
| 11- Monitorar o progresso do cliente                                                           |  |  |  |  |
| 12- Melhorar o relacionamento com os clientes                                                  |  |  |  |  |
| 13- Ajudar o cliente a entender seus problemas e encontrar formas de resolvê-los               |  |  |  |  |
| 14- Melhorar o controle comportamental dos clientes                                            |  |  |  |  |
| 15- Melhorar a atenção dos clientes durante as atividades em grupo                             |  |  |  |  |
| 16- Utilizar avaliações computadorizadas com os clientes.                                      |  |  |  |  |
| <b>PRESSÕES POR MUDANÇA</b>                                                                    |  |  |  |  |
| As atuais pressões para que sejam realizadas mudanças no programa vêm de:                      |  |  |  |  |
| 17- Clientes no programa de tratamento                                                         |  |  |  |  |
| 18- Funcionários do serviço                                                                    |  |  |  |  |
| 19- Supervisores ou gerentes do serviço                                                        |  |  |  |  |
| 20- Membros do governo (ou de agências)                                                        |  |  |  |  |
| 21- Grupos de ação da comunidade                                                               |  |  |  |  |
| 22- Agências de fomento ou supervisão à ciência                                                |  |  |  |  |
| 23- Autoridades de licenciamento ou homologação                                                |  |  |  |  |
| <b>FUNCIONÁRIOS</b>                                                                            |  |  |  |  |
| 24- Existem profissionais suficientes aqui para atender às necessidades dos clientes           |  |  |  |  |
| 25- É necessária uma maior equipe de suporte para ajudar a atender às necessidades do serviço. |  |  |  |  |
| 26- A grande rotatividade de funcionários é um problema para este serviço                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 27- Os profissionais aqui são capazes de passar tempo suficiente com os clientes                                             |  |  |  |  |
| 28. A equipe de suporte aqui tem as habilidades necessárias para realizar seu trabalho.                                      |  |  |  |  |
| 29. A equipe clínica aqui é bem treinada.                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>TREINAMENTO</b>                                                                                                           |  |  |  |  |
| 30- Formação de pessoal e educação continuada são prioridades neste serviço.                                                 |  |  |  |  |
| 31. Você aprendeu novas habilidades ou técnicas em uma conferência profissional no ano passado.                              |  |  |  |  |
| 32. O orçamento da instituição permite que os funcionários participem de conferências profissionais a cada ano.              |  |  |  |  |
| 33- Este serviço sedia programas de treinamento regularmente.                                                                |  |  |  |  |
| <b>QUALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS - CRESCIMENTO</b>                                                                              |  |  |  |  |
| 34- Este serviço incentiva e financia o crescimento profissional                                                             |  |  |  |  |
| 35- Você lê sobre novas técnicas e informações de tratamento a cada mês                                                      |  |  |  |  |
| 36- Você tem oportunidades suficientes para manter suas habilidades de atendimento atualizadas todo mês                      |  |  |  |  |
| 37- Você lê regularmente artigos de periódicos profissionais ou livros sobre intervenções baseadas em evidência científicas? |  |  |  |  |
| 38- Você consegue atualizar-se regularmente e melhorar suas habilidades.                                                     |  |  |  |  |
| <b>INFLUÊNCIA</b>                                                                                                            |  |  |  |  |
| 39- Você, frequentemente, compartilha seu conhecimento sobre novas ideias de atuação com outros funcionários.                |  |  |  |  |
| 40. A equipe, geralmente, considera você uma valiosa fonte de informação.                                                    |  |  |  |  |
| 41. Outros funcionários pedem seu conselho com frequência sobre os procedimentos do programa.                                |  |  |  |  |
| 42- Outros funcionários geralmente perguntam sua opinião sobre orientação e problemas de tratamento                          |  |  |  |  |
| 43- Você geralmente influencia nas decisões de outros funcionários                                                           |  |  |  |  |
| 44- Você é visto como um líder por outros funcionários                                                                       |  |  |  |  |

| ADAPTABILIDADE                                                                                |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 45- Você está disposto a tentar novas ideias, mesmo que alguns funcionários sejam relutantes. |  |  |  |  |
| 46- Aprender e utilizar novos procedimentos é fácil para você                                 |  |  |  |  |
| 47- Você é algumas vezes muito cauteloso ou muito devagar para fazer mudanças                 |  |  |  |  |
| 48- Você é capaz de se adaptar rapidamente quando precisa mudar o foco                        |  |  |  |  |
| ATITUDES NO TRABALHO - ESGOTAMENTO                                                            |  |  |  |  |
| 49- Você se sente sobrecarregado pela burocracia                                              |  |  |  |  |
| 50- Você se sente como se não fizesse diferença                                               |  |  |  |  |
| 51- Você sente como se fosse um fardo vir ao trabalho                                         |  |  |  |  |
| 52- Você se sente deprimido.                                                                  |  |  |  |  |
| 53- Você se sente cansado                                                                     |  |  |  |  |
| 54- Você se sente desiludido e ressentido.                                                    |  |  |  |  |
| SATISFAÇÃO                                                                                    |  |  |  |  |
| 55. Você está satisfeito com o seu trabalho atual.                                            |  |  |  |  |
| 56. Você gostaria de encontrar um emprego em outro lugar.                                     |  |  |  |  |
| 57. Você se sente valorizado (feliz) pelo trabalho que faz.                                   |  |  |  |  |
| 58. Você gosta das pessoas com quem trabalha.                                                 |  |  |  |  |
| 59. Você valoriza muito o trabalho que faz aqui.                                              |  |  |  |  |
| 60. Você tem orgulho de contar aos outros onde você trabalha.                                 |  |  |  |  |
| SATISFAÇÃO COM O TREINAMENTO                                                                  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                           |      |               |            |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------|--------------------|------------|
| 61. Você ficou satisfeito com o treinamento oferecido nas oficinas disponíveis para você durante o último ano.                            |      |               |            |                    |            |
| 62. Você ficou satisfeito com as oportunidades de treinamento disponíveis para você durante o último ano.                                 |      |               |            |                    |            |
| UTILIZAÇÃO DO TREINAMENTO                                                                                                                 | unca | Ra<br>ramente | s<br>vezes | Frequent<br>emente | S<br>empre |
| 63- Quando você comparece a “workshops” com que frequência aplica as novas intervenções ou técnicas aprendidas?                           |      |               |            |                    |            |
| 64- Seus clientes estão interessados ou dão uma boa resposta às novas ideias ou aos materiais de tratamento aprendidos?                   |      |               |            |                    |            |
| 65- Nos últimos anos, com que frequência você adotou (para o uso cotidiano) as novas intervenções ou técnicas aprendidas nos “workshops”? |      |               |            |                    |            |

## ANEXO 2 – Decisão OBJN

25/09/2024, 20:43

Gmail - Fwd: Online Brazilian Journal of Nursing - Decision on Manuscript ID OBJN-2023-0160



Amanda Oliveira <amandarsoliveiraenf@gmail.com>

### Fwd: Online Brazilian Journal of Nursing - Decision on Manuscript ID OBJN-2023-0160

2 mensagens

Maithê Goulart <maithegoulart@gmail.com>

29 de julho de 2024 às 13:59

Para: "amandarsoliveiraenf@gmail.com" <amandarsoliveiraenf@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Editor Chefe/Adjunto** <onbehalf@manuscriptcentral.com>

Date: dom., 28 de jul. de 2024 às 16:05

Subject: Online Brazilian Journal of Nursing - Decision on Manuscript ID OBJN-2023-0160

To: <maithegoulart@gmail.com>

28-Jul-2024

Dear Dr. Goulart:

It is a pleasure to accept your manuscript entitled "Boas prática gerenciais da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: protocolo de scoping review" in its current form for publication in the Online Brazilian Journal of Nursing.

Thank you for your fine contribution. On behalf of the Editors of the Online Brazilian Journal of Nursing, we look forward to your continued contributions to the Journal.

Sincerely,

Dr. Editor Chefe/Adjunto

Editor-in-Chief, Online Brazilian Journal of Nursing

[chefe.adjunto2021@gmail.com](mailto:chefe.adjunto2021@gmail.com)

Prezados autores,

É um prazer aceitar seu manuscrito OBJN-2023-0160 em sua forma atual para publicação no Online Brazilian Journal of Nursing. Obrigado pela sua bela contribuição. Em nome dos Editores do Online Brazilian Journal of Nursing, esperamos suas contínuas contribuições para o Journal.

Para otimizar o processo de produção e publicação do seu manuscrito, abaixo estão listadas algumas dicas:

1- No site do OBJN, consulte o Manual do Autor para compreender os próximos passos (<https://objn.uff.br/normas-e-instrucoes/>);

2- Pague a taxa de publicação (<https://objn.uff.br/taxas-e-pagamentos/>) e encaminhe o comprovante para o email [objn.cme@id.uff.br](mailto:objn.cme@id.uff.br). No assunto coloque: COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO - OBJN-2023-0160;

2- Escolha uma empresa para fazer a revisão e/ou tradução do seu manuscrito e title page. Envie um e-mail para [objn.cme@id.uff.br](mailto:objn.cme@id.uff.br) indicando a empresa escolhida e prazo para entrega do manuscrito revisado. No assunto coloque: EMPRESA PARA REVISÃO/TRADUÇÃO - OBJN-2023-0160;

3- Ao receber o manuscrito revisto e traduzido encaminhe para o e-mail [objn.cme@id.uff.br](mailto:objn.cme@id.uff.br). Indique no assunto: ARTIGO REVISADO - OBJN-2023-0160;

4- Você receberá um e-mail para fazer a conferência da versão final do seu artigo;

5- Aguarde a publicação e divulgue em suas redes sociais

Atenciosamente,

Ana Carla Dantas Cavalcanti

Editora Chefe do Online Brazilian Journal of Nursing

—

Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. Maithê de Carvalho e Lemos Goulart

Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense  
Campus Universitário de Rio das Ostras

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=95a653dc15&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1805933512253791074&simpl=msg-f:1805933512253...> 1/2

## ANEXO 3 – PUBLICAÇÃO



Contratações  
COVID-19

Prefeitura ▾ Cidadão ▾ Servidor ▾ Empresas ▾ Turismo e Cultura ▾ Legislação ▾ Compras Públicas ▾ Acesso a Informação ▾ Contatos ▾

### Fazenda

Institucional

Notícias

Editais - SEFA

Legislação Tributária

Prestação de Contas

Serviços da Arrecadação

### ANEXO 2 - PROTOCOLO RCPD - Rede de Cuidados à Pessoa Com Deficiência

 [ANEXO 2 - PROTOCOLO RCPD - Rede de Cuidados à Pessoa Com Deficiência](#)

Tamanho: 1.24 MB

Download

### Notícias Recentes

- Sistema de alerta por SMS da Defesa Civil também está ativo para Lagoa Santa
- Lagoa Santa abre cadastro para comerciantes participarem de eventos em 2025
- Estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta em Lagoa Santa
- Prefeitura realiza limpeza e

## ANEXO 4



### DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que **Amanda Rezende Silva de Oliveira**, discente do curso de atualização em “*Competências clínicas para o cuidado de enfermagem na primeira infância*”(ACCCEPI), oferecido pelo Programa de Extensão Primeira Infância Plena (PPiP) da Escola de Enfermagem da UFMG (EEUFMG) por meio da parceria com o Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG), e Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), participou das aulas, ministradas nos 22 módulos, que totalizam 176 horas e concluiu a etapa teórico-prática, sendo 88 horas de conteúdo prático e 88 horas de conteúdo teórico. A carga horária descrita refere-se ao período de 19 de abril até 13 de setembro de 2024.

A implementação do projeto de intervenção local ainda está pendente e será apresentado em 2025, sendo requisito essencial para certificação como enfermeira multiplicadora ACCCEPI.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

#### GRUPO DE TRABALHO EM SAÚDE DA CRIANÇA DO COREN-MG

Documento assinado digitalmente



**DELMA AURELIA DA SILVA SIMÃO**

Data: 08/10/2024 16:11:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DRA. DELMA AURELIA DA SILVA SIMÃO**  
**PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA**  
**PLENA**



Rua da Bahia, 916 – 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º andares Centro - Belo Horizonte – MG CEP: 30160-011  
Telefone: (31) 3238-7500 - Telefax: (31) 3238-7520 - Site: [www.corenmg.gov.br](http://www.corenmg.gov.br) E-mail: [gab@corenmg.gov.br](mailto:gab@corenmg.gov.br)

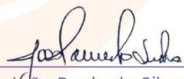
## ANEXO 5



Certificamos que Amanda Rezende Silva de Oliveira participou como palestrante do **1º Seminário da Rede de Cuidados à Pessoa Com Deficiência (RCPD) do Município de Lagoa Santa/MG**, referente à implementação de Melhorias dos Fluxos e na Qualidade da Assistência Prestada aos Usuários. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Santa, na Escola Municipal Dr. Lund, nos dias 07 e 08 de novembro de 2024, com carga horária de 4 horas de duração.

Lagoa Santa, 9 de novembro de 2024

  
Mariane Cristina Rios Silveira Oliveira  
Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde

  
João Paulo da Silva  
Secretário Municipal de Saúde

  
Breno Aparecido da Costa  
Diretor



Secretaria de  
Saúde



PREFEITURA  
**LAGOA SANTA**

## ANEXO 6

 Instagram

 prefeituraagoasanta



**Brincar sem telas: Estímulo  
ao tempo de qualidade**

Desconecte para reconectar: dê ao seu filho  
o presente da atenção plena longe das telas.



 1 

 Curtido por maiticaemos e outras  
pessoas

**prefeituraagoasanta** Em um mundo cada  
vez mais conectado, o equilíbrio entre o  
uso da tecnologia e o tempo dedicado ao  
brincar é fundamental para o  
desenvolvimento saudável das crianças. 🛝